

目 录

更多相关资源请访问 <http://www.klrs999.cn/> hbtmxy 制作

第一章 绪论	1
一、古老而又新奇的拔罐疗法	1
二、拔罐疗法的渊源	1
三、可调式磁疗医用拔罐	3
四、现代医学对拔罐疗法的研究和探索	4
1、镇痛作用	4
2、对机体各系统功能的调整作用	4
五、拔罐疗法的发展前景	7
第二章 拔罐疗法的治病机理	9
一、中医学原理	9
1、疏通经络 和调脏腑	9
2、平衡阴阳 扶正祛邪	9
二、经络学说	10
1、经络的作用	10
2、运用经络预防和治疗疾病	12
三、微循环理论	31
附 磁疗作用	34
第三章 拔罐的种类、方法及注意事项	41
一、罐具的种类	41
二、拔罐的方法	43

三、临床常用罐法	44
四、拔罐疗法与其它疗法的关系	44
五、吸拔时间	47
六、起罐的方法及起罐后的处理	47
七、施用拔罐疗法应该注意的事项	48
八、拔罐治疗时应注意观察患者局部和全身反应	50
九、拔罐前的准备工作	50
十、适应症与禁忌症	51

第四章 拔罐在诊病中的应用

52

第五章 常见病的治疗

54

一、内科疾病

54

1、感冒

54

2、咳嗽

55

3、哮喘

55

4、支气管炎

58

5、消化不良

58

6、胃痛

59

7、胃炎

59

8、肠炎

60

9、消化道溃疡

62

10、腹痛

62

11、呕吐

63

12、腹泻	63
13、便秘	63
14、头痛	66
15、失眠	67
16、眩晕	68
17、健忘	70
18、疲劳	70
19、冠心病	71
20、风湿性心脏病	72
21、病毒性心肌炎	72
22、心律失常	73
23、高血压	74
24、低血压症	76
25、贫血	76
26、高脂血症	76
27、白血病	78
28、血小板减少性紫癜	79
29、中风后遗症	80
30、面瘫	80
31、三叉神经痛	83
32、神经衰弱	83
33、癫痫	84
34、老年痴呆症	85

35、胆结石、胆囊炎	86
36、病毒性肝炎	86
37、泌尿系感染	87
38、肾盂肾炎	88
39、遗尿	88
40、慢性前列腺炎	89
41、阳痿	90
42、糖尿病	91
43、肥胖症	92
44、甲状腺机能亢进症	93

二、 外科疾病..... 93

45、落枕	93
46、颈椎病	94
47、颈椎骨质增生症	95
48、肩关节周围炎	95
49、腰痛	97
50、软组织损伤	98
51、注射后肿块、疼痛	98
52、坐骨神经痛	99
53、腰椎间盘突出症	100
54、腰肌劳损	101
55、风湿性关节炎	101
56、类风湿性关节炎	101

57、急性阑尾炎	102
58、胆道蛔虫病	104
59、胆绞痛	104
60、急性乳腺炎	105
61、急性尿潴留	107
62、急性胰腺炎	109
63、肾绞痛	109
64、直肠脱垂	111
65、疝病	113
66、丹毒	113
三、 妇科疾病	115
67、月经不调	115
68、痛经	116
69、白带增多	116
70、闭经	117
71、妇女更年期综合症	117
72、冷感症	119
73、产后乳汁不足	120
74、不孕症	120
75、子宫肌瘤	121
四、 五官科疾病	121
76、急性扁桃体炎	121
77、急性咽炎	122

78、慢性咽炎·····	123
79、牙痛·····	124
80、急、慢性鼻炎·····	126
81、耳鸣、耳聋·····	126
82、近视·····	127
五、儿科疾病·····	128
83、小儿遗尿·····	128
84、小儿疳疾·····	129
85、小儿腹泻·····	129
86、小儿厌食·····	131
87、小儿营养不良·····	132
88、小儿咳嗽·····	133
89、小儿麻痹后遗症·····	133
第六章 拔罐常用经穴 ·····	136
一、常用腧穴·····	136
1、胸腹部腧穴·····	136
2、背腰部腧穴·····	140
3、侧面腧穴·····	148
4、肩部及上肢腧穴·····	149
5、下肢腧穴·····	152
二、拔罐疗法必选经穴·····	157
第七章 临床典型病例 ·····	159

第一章 绪 论

一、古老而又新奇的拔罐疗法

拔罐疗法是指利用各种筒罐为工具,并采用不同的方法排出筒罐中的空气,使其形成负压后吸附于体表部位或经穴上,造成被拔部位出现充血、瘀血等现象,以达到治疗和预防疾病目的的一种安全方便的中医传统特色疗法。

拔罐疗法以中医针灸经络学说为理论依据,是祖国医学中的一个重要组成部分。中医学家常把其纳入针灸学的范畴之中。千百年来,拔罐疗法同针灸、按摩、刮痧等传统疗法相互影响,相互补充,为中华民族的健康事业做出了巨大贡献,是中国医药学中一朵光辉夺目的奇葩。

而在诸多中医传统疗法中,拔罐疗法又因其工具简单,使用方便,疗效优良,费用低廉等特点,深受群众喜爱,一直在民间广泛使用。近年来随着国家和社会对中医的日益重视,医学家们对拔罐疗法也进行大量的深入的研究,使拔罐疗法更加系统,更加完善。而发明家们也在罐具上不断进行大胆改新,力求使拔罐疗法更简单,更方便,更有效,服务于广大人民群众。特别是目前一种罐体透明、不用点火、罐内负压可自如调节的可调式拔罐制作出来以后,大大加快了拔罐疗法的运用和普及。相信在不远的将来,拔罐这种对人体无创伤、无痛苦、无毒副作用的传统疗法,定将成为许多家庭配备的一种医疗工具。这不仅符合世界卫生组织所倡导的医疗保健发展方向,也顺应了医疗保健家庭化的世界潮流。

二、拔罐疗法的渊源

拔罐疗法在我国有着数千年的发展历史。最早的罐具是用兽角制成的,所以拔罐疗法古称“角法”。1973年在湖南长沙马王堆出土的汉墓帛书《五十二病方》中就有拔罐疗法的记载,这是目前发现的最早的文献。公元281—361年晋代葛洪《肘后备急方》记载有用兽角(牛角)制成罐状,以吸拔瘀血。公元752年唐代王焘《外方秘要》中记载:“患癰瘰癧(肺癰之类)等病,即以墨点记之,取三指大青竹筒,长寸许,一头留节,无节头割令薄如剑,煮此筒子数沸,及热出筒,浓墨点处按之,良久,

以刀弹破所角处，又煮筒子重角之，当出黄白赤水，次有脓出，……数数以此角之，今恶物出尽，乃即除，当目明身轻也。”这说明在唐代人们不仅完全掌握了竹筒的制作工艺，而且记录了水煮拔罐法，并对拔罐疗法的治疗范围从以前单纯的吸拔脓血扩大到内科疾病的范围，大大丰富了拔罐的内容。拔罐疗法在宋、金、元、明时期开始广泛使用，如宋代科学家沈括在《苏沈良方》中用火筒法治久嗽。《古今录验》、《证类本草》、《济急仙方》、《外科正宗》等书都载有竹筒吸毒、煮拔筒等内容。到了清代，医学家对拔罐疗法开始全面总结，清吴谦《医宗金鉴》一书载有拔罐疗法。清代赵学敏在《本草纲目拾遗》中论述：“以小烧见火焰，投入罐中，即将罐合于患处……罐得以火气，合入肉即牢不可脱，须待其自落，患者但觉有一股暖气，从毛孔透入，少倾火力尽则自落。肉上起红晕，罐中有气水出，风寒尽出，不必服药。”另外赵学敏还用火罐治疗“风寒头痛及风痹、眩晕、腹痛等症”。清代吴师机《理论骈文》记载有用拔罐治疗“黄疽”与“风疾”，这些都充分说明经过历代医家的研究和充实，到了清代拔罐疗法已经非常成熟了，不仅在拔罐工具、拔罐方法、对拔罐时皮肤局部的观察，而且在治疗范围等方面都有非常详实的记录，足已证明当时的拔罐疗法在医界和民间的普及已达到相当的程度。

拔罐疗法很早就传至了国外。大约在 6 世纪，与针灸一起传入朝鲜，同时吴人知聪携带《明堂孔穴图》、《针灸甲乙经》等书，介绍到日本，公元 17 世纪末传到欧洲。

由于历史的原因，近代此法多在民间使用。新中国成立后，中国医学出现了崭新的面貌，拔罐疗法也同针灸疗法一样，获得了蓬勃发展。现如今，大到全国各大综合性医院、中医院，小到广大农村卫生院、各村诊所，都得到了普及。尤其是近年来，随着经济的快速发展，人们对健康的要求越来越高，拔罐这种不用药、不用电、无毒副作用的疗法日益引起人们的重视。大量的临床报道见于各地医药报刊中。由于临床实践与理论研究相互促进，从而使拔罐疗法在罐具、拔罐方法、治病范围、治疗效果等各方面都得到长足的发展。在治疗方法上，有从原来的单罐法、多罐法、留罐法、走罐等方法发展到按神经节段拔罐法、内脏表层反射区拔罐法等。在治病范围上，从最原始的拔罐吸脓发展到现在的

内、外、妇、儿、骨伤科等各种疾病,并在拔罐治疗痛经、哮喘等疾病方面有所突破。在治病原理方面从传统的经络理论发展至神经反射、微循环等各方面。特别是在罐具上,现代科学工作者,发明家不断运用高科技手段,研制出许多更科学合理的罐具。尤其是目前北京生产的可调式磁疗医用拔罐,不仅罐体透明、不用点火,可自如调节罐内的负压,而且不用电,不用药,携带方便,是现代罐具中杰出代表。

三、可调式医用磁疗拔罐——罐具新发展

罐具作为一种医疗用具,在拔罐疗法中占有极其重要地位。不同的罐具有不同的特点,可因人、因时、因病情选择使用。最早人们用兽角制成罐具,用以吸毒排脓。随着生产力的不断发展,人们又用毛竹、陶土等制成竹罐、陶罐,并得以长期使用。近代又制作出玻璃罐,因其透明,便于医患观察拔罐部位的各种情况,所以很快替代了竹罐和陶罐,是目前临床上使用最普遍的罐具,为拔罐疗法的发展起了非常巨大的作用。

但无论是竹罐、陶罐还是玻璃罐,大多需点火排气,这就要求术者应掌握一定的拔罐技巧,以免因点火而烫伤患者皮肤。另外这三种罐一旦吸附于体表,其罐内的负压值就固定下来,医者无法因人、因时、因病对拔力进行调节,这也就带来不便。近几十年来,现代科技工作者一直在想方设法克服传统拔罐需点火、无法调节罐内负压这两个缺点,并研制出许多新一代的罐具,如上海针灸研究所制成了“经穴电动拔罐仪”、江西研制的“多用拔罐机”等集电真空、磁、红外线为一体的现代罐具。但这些罐具大多生产成本高,无法得以普及,最近北京研制出一种可调式医用磁疗拔罐,它总结了各种传统罐具的特点,吸取了竹罐的轻便、陶罐的吸力大、玻璃罐的透明等优点,并在罐体内放置螺旋式旋转装置,只要轻轻扭旋转罩,就可形成负压使之吸附于体表部位,并可随意调节,以增加或减少罐内的压力。这种装置成功地解决了传统拔罐需点火、拔力不可调节这两大缺点,并且罐体采用 AS、ABS 等工程塑料制作,质地轻便,造型美观,罐体透明,色泽光亮,坚固耐用,价格合理,无毒无刺激作用,携带方便,是理想的新一代罐具。

可调式医用磁疗拔罐使拔罐方法变得更简单,更方便,更有效。可以预见,随着罐具上的重大突破,拔罐疗法将以更快的速度为人们所了

解和应用,成为人人皆知的医疗保健方法,将为全世界人民的医疗卫生事业作出更大贡献。

四、现代医学对拔罐疗法的研究

拔罐疗法是祖国传统医学的一个重要组成部分,一直在中医理论的指导下应用于临床,其作用机理也大多运用中医理论进行概括和归纳。如调气血、通经络、平阴阳、和五脏等。近几十年来,随着医学的发展,医学家们又运用现代医学的理论对拔罐进行以系统的研究和探索,并取得许多重要成果,从而使拔罐疗法的作用基础更加明确。

关于拔罐对机体的作用,大致可以归纳为三个方面,即镇痛、对机体各系统功能的调整和增加机体的防御免疫等方面的作用。

1、镇痛作用

从丰富的中医文献及近代大量临床实践总结资料来看,拔罐具有良好的镇痛效果。如临床常见的头痛、胁痛、胃痛、腹痛、腰痛、三叉神经痛、坐骨神经痛、关节痛、痛经等,都有良好的镇痛作用。

实验证明,拔罐可提高痛阈,故增加了疼痛的耐受力,降低了痛觉的敏感性。拔罐能提高痛阈的原因是多方面的:(1)拔罐时可增加外周血5-羟色胺的含量,而5-羟色胺作为中枢神经递质在拔罐镇痛中具有重要作用。(2)拔罐时能使肾上腺髓质中的肾上腺素细胞和去甲肾上腺素的数目增加,胞体增大,胞质反应加深,引起痛阈明显升高。(3)科学家近年来发现,当对动物进行拔罐时,动物脑内内啡肽含量明显增加,而且与镇痛效应相关。从临床观察到,用拔罐镇痛时,人脑脊液中内啡肽的含量显著增加。(4)拔罐时能使外周血液中的致痛物质,如钾离子、组织胺、缓激肽的浓度降低。

总体来说,拔罐镇痛是在拔罐刺激作用下,在机体内发生的一个从外周到中枢各级水平,涉及神经、体液许多因素,包括致痛与抗痛这对立又统一的两个方面的复杂的动态过程。

2、对机体各系统功能的调整作用

拔罐对人体各系统许多器官和组织都有明显的调整作用,它可以使人体机能由不正常恢复到正常。这方面的内容相当丰富,现举例说明:

(1) 对器官和组织的调整

研究者报道,在肺俞、大椎、风门等穴位进行拔罐治疗哮喘 114 例,总有效率 92.1%,其中显效率为 31.58% (针灸临床杂志 1995 年 11 卷 10 期)。在大椎、定喘、天突、中府等穴位拔罐治疗慢性支气管炎,取得较好疗效。研究者认为,哮喘或支气管炎对呼吸困难的发生,是由于迷走神经的过度紧张,导致支气管痉挛,引起管道阻力增高的缘故。拔罐可使迷走神经的紧张度降低,交感神经兴奋性增高,从而使支气管痉挛解除,支气管粘膜的血管收缩,渗出减少,故使气道阻力减低,通气功能得到改善。

拔罐治疗急、慢性胃炎,胃神经痛,胃痉挛,胃下垂,胃及十二指肠溃疡等,都有较好的疗效。研究者在内关、中脘、足三里等穴位拔罐治疗胃痛 120 例,总有效率 98% (针灸临床杂志 1996 年 12 卷 10 期)。研究者认为,拔罐对胃的运动、胃液的分泌都有明显的调整作用,而这种作用是双向性的,也就是说如果胃蠕动减弱,拔罐可使蠕动增强,反之亦然;如果胃液分泌过多,拔罐可使其减少,反之亦然。这也就是拔罐能治疗多种胃部疾病的重要原因。

拔罐对肝胆功能也具有良好的调整作用。在期门、阳陵泉、足三里等穴拔罐,可治疗胆绞痛、急性黄疸型病毒性肝炎等肝胆疾病。研究者发现在这些穴位拔罐时,胆总管可出现规律性的收缩,蠕动明显增强,胆汁流量明显增加,肝功能及肝肿大可得到改变。研究者在肾俞、膀胱俞、命门、关元、中极、三阴交等穴位进行拔罐,并配以针刺,治疗遗尿、尿失禁、排尿困难、肾炎等疾病,取得良好效果。拔罐时一方面可以通过神经反射机理影响肾小球的滤过率,也可以调节肾小球的毛细血管通透性,拔罐对膀胱的影响,主要是通过调整膀胱的紧张度来实现的。如果原膀胱处于高紧张状态,拔罐可使其松弛,若原膀胱处于松弛状态,拔罐可使其收缩。所以拔罐既能治疗泌尿症,又可治疗尿闭症。

在心俞、厥阴俞、至阳、内关、膻中等穴拔罐并配以针刺,可治疗冠心病、高血压、早搏等病症,拔罐可改善冠状动脉的血液循环及脑循环,对有病的的心脏有良性调整作用。拔罐对血压的调整也是双向性的。研究者发现运用拔罐治疗血压异常时,可使原血压水平较高者血压降低,

原血压水平较低者血压升高。对血压的调整是通过交感神经的兴奋或迷走神经的兴奋来实现的。

(2) 对血液成份的调整

血液在维持人体各个器官与组织的正常生理活动及防御疾病的侵袭方面,居于非常重要的地位。各种内外因素对机体的刺激,常可影响血液成份的改变。拔罐具有调整血液成份的作用,例如对白细胞、红细胞、血沉、血糖、血钙等都具有比较明显的调整作用。

有文献报告,在进行拔罐的地方,血红蛋白和白细胞都比全身有明显增加,其中血红蛋白增加百分之二十,红细胞增加一百万以上,白细胞增加八千左右。

研究者通过拔罐配合针灸治疗缺铁性贫血,发现针罐后外周血液内网状红细胞数剧增。在对某些炎症患者进行治疗后,血沉也明显趋于正常。

研究者在脾俞、膈俞、足三里等穴进行拔罐治疗糖尿病时发现,毛细血管通透性增高,血糖明显降低。在对血钙、血钾、血钠、血中的转氨酶等指标进行观察时,发现拔罐对以上血液成份均有良好的双向调节作用。

(3) 拔罐的防御免疫作用

拔罐同针灸一样,能增强体质、预防疾病。如拔罐可预防感冒,预防哮喘的复发。拔罐能治疗病毒引起的感冒、黄疸,能治细菌引起的痢疾、肠炎,还能治各种慢性炎症,如急性咽喉炎、阑尾炎、胃炎、乳腺炎。这些都是通过增强机体抗病能力实现的。

拔罐时,局部皮肤出现充血、瘀血。罐内的负压可使局部毛细血管壁扩张,破裂,血细胞遭到破坏,红细胞产生溶血现象,使部分细胞蛋白质分解,产生组织胺、5-羟色胺等物质,使毛细血管扩张,改善局部皮肤营养,促进神经兴奋或抑制,刺激神经末梢感觉传导,提高肌肉工作能力与耐力。加速血液及淋巴液循环,促进胃肠蠕动,改善消化功能,促进和加快肌肉和脏器对代谢产物的清除排泄。

研究者在拔罐时,通过高速摄影发现被拔皮肤表面有大量气泡溢出,气泡来自血液和局部组织,是组织器官进行新陈代谢后的产物,如

炎症渗出物、致病因子等。这与中医所说的“散寒除湿”、“清热解毒”等不谋而合。

拔罐可使全身及外周血液中的白细胞数量增多,对细菌的吞噬能力加强。研究者报告“第一次被吸拔的部位有瘀血斑,过1—2天后,在该瘀血斑1/2表面做第二次吸拔,次日瘀血斑消退极快,甚至完全消失,这种现象表明吸拔刺激能动员吞噬细胞吃掉瘀血。根据这个原理,吸拔人体任何部位都可以激发吞噬作用加强,有助于排出异物”。这证明拔罐有激活网状内皮系统吞噬功能的作用。拔罐能调动机体免疫生理功能,当在足三里、大椎等穴拔罐后,可发现人体血清调理素促进吞噬指数、促进吞噬率和促进吞噬细胞细菌平均最高指数均比以前有一定提高,说明拔罐能调动机体免疫生理功能,防御外来的致病因素的侵袭。

总之,拔罐对防御免疫的影响是多方面的,网状内皮系统功能活动增强,机体内各种特异性和非特异性免疫抗体的增加,对于增强机体防卫抗病能力,具有非常重要的意义。

综上所述,拔罐对机体具有三大作用是相互关连的,拔罐在临床治疗的疗效更是通过拔罐对机体的许多作用来实现的。

五、拔罐疗法的发展前景

拔罐同针灸、推拿等疗法一样,是中华民族传统医学宝库中的一颗灿烂明珠,也是当代全人类共同的宝贵财富。

拔罐疗法临床适用范围十分广泛,许多疾病都可以运用拔罐治疗,甚至有些目前现代医学难以医治的病,使用拔罐也能取得极好的效果。这种疗法不但疗效高,使用的工具也很简单,携带方便,操作比较容易掌握,既可免除服药、注射的麻烦,节省医药费用,又可避免各种药物可能带来的副作用,因此,越来越受到国内外医家和人民群众的欢迎。然而拔罐疗法本身也有不足之处,特别是在罐具方面,远远落后于拔罐疗法的应用,传统罐具如竹罐、玻璃罐,由于需点火排气,所以只能限于在医院里或在医生的帮助下使用,而对火的畏惧,又往往使病人无法在非常放松的状态下接受治疗。另外传统罐具罐内的负压是无法根据病情需要进行调节的,所以往往达不到理想的效果,这对拔罐疗法的科研与

普及应用带来一定的局限性。随着拔罐疗法的日益发展,人们对罐具的要求越来越高,这种局限性也就越来越明显了。一种现代化的罐具就应运而生了。可调式拔罐,一改传统的罐具,利用科学的方法,采用先进的生产工艺,不仅克服了点火排气的缺陷,而且能因人、因时、因病调节罐内的负压值,磁疗的应用,又使这种罐具具备了罐疗和磁疗的双重作用。加上外观的精美设计,使罐体比传统罐具更轻便,更精致,更耐用,为拔罐疗法今后更好地在医院和家庭中普及和应用奠定了良好的基础。

拔罐疗法同其它任何传统疗法一样,只有广泛使用,才能显示出其强大的生命力。现如今,针灸、推拿等疗法已蜚声海内外,在全世界范围内都得到了广泛使用,随着新一代罐具的发明和使用,拔罐疗法将变得更简单,更方便,更有效,相信在很短的时间内,拔罐疗法就可以走进千家万户,走出国门,走向世界。

第二章 拔罐疗法的治病机理

一、中医学原理

1. 疏通经络,和调脏腑

我们知道脏腑是人体中的重要器官,是人体生命活动的根本,脏腑的功能活动维系着人体生命的一切。脏腑既有自己独立的功能,又相互制约。脏腑之间的相互联系、相互制约是通过经络来实现的。

经络是经脉和络脉的总称。经,有路径的含义,经脉贯通上下,交通内外,是经络系统的主干;络,有网络的含义,络脉是经脉的分支,比经脉细小,纵横交错,遍布全身,是经络系统的分支部分。经络内属于脏腑,外络于肢节,将人体脏腑器官联系成为一个有机整体,并藉以行气血,营阴阳,使人体各部的功能活动得以保持协调和相对平衡。

人体上有许多穴位,这些穴位是营卫气血循环流动过程中会和交汇之处,是脏腑经络之气盛衰的反应点。总之,人的脏腑产生的营卫气血,是维持和营养人体生命活动的基本物质,并以经络系统为通道,作用于人体各部,将脏腑构成相互联系、相互制约的有机整体,并反应于人体穴位上。

一个健康的人,脏腑、经络、穴位保持通畅,维持平衡,则“阴阳调和”。而人体在致病因素的作用下,就破坏了这种平衡,发生疾病,同时反应到脏腑、经脉和穴位上。例如:患有胃肠疾病的人常在足三里、中脘等穴出现压痛;患有肺脏疾病的人,常在肺俞、中府等穴有压痛及皮下结节。人体外部受邪,邪气也会通过体表、穴位,通过经络,引起脏腑功能失调,使人体呈病态。例如:感冒患者,虽是外感风寒所致,却引起头痛、鼻塞、流涕、发烧等多种全身性反应。

拔罐疗法借助于罐内产生的负压作用于机体的经络和穴位处引起局部皮肤充血或瘀血,促使经络通畅,气血旺盛,调节脏腑功能,使人体从不平衡的病理状态,改变为新的生理平衡状态,成为祛除疾病的一种方法。

2. 平衡阴阳,扶正祛邪

平衡阴阳:祖国医学认为,人的生命活动,是由于阴阳双方保持着

对立统一的协调关系结果,阴阳是处于相互对立、依存、消长、转化的关系中。只有这种协调关系,才保持了人体各组织器官、脏腑的正常生理功能。如果因某种原因使阴阳的平衡遭到破坏,出现阴阳偏盛或偏衰,就会导致疾病的发生。

拔罐疗法就是通过对经脉和穴位的刺激,来调节脏腑和经络的阴阳失衡。例如:拔关元穴可以温阳去寒;拔大椎穴可以泄实热。再如脾胃虚寒引起的泄泻,可取足阳明胃经和足太阳膀胱经的穴位天枢、足三里、脾俞、胃俞等以温阳散寒。因肝阳上亢或肝火上炎而引起的项背痛、头痛、头晕、高压等症,则可取大椎穴,用三棱针刺出血后,加拔罐,以清泄肝热。总之,通过拔罐的刺激,影响脏腑,使人体的阴阳偏盛、偏衰得以矫正,机体功能达到新的平衡。

扶正祛邪,祖国医学认为,疾病的发生是由于人体的正气虚或邪气(致病因素)实所致。正气是指人体的机能活动和其抗病能力。邪气则是指各种致病因素,如外部的风、寒、暑、湿、燥、火,即六淫;内部的脏腑失调,诸如痰饮、瘀血、积食等。

正、邪双方消长的变化,显示着疾病的进退,若邪气消退,则正气增长,正能胜邪而病愈,经常进行拔罐可使“正气存内,邪不可干”。

经络具有运行气血,沟通表里和调节脏腑器官组织活动的功能,邪气从外侵入,先使经络受阻甚至不通,就会产生种种病变。

拔罐疗法可通过对经络、穴位的作用,引导营卫之气,鼓动经脉之气,濡养脏腑器官,加强驱病抗邪能力,从而使经络气血恢复正常,疾病得以祛除。

如一些患者拔罐后出现水疱,拔罐部位潮湿,就表明该患者已受到湿气的侵邪,影响了机体的平衡。通过拔罐把湿气拔出,驱除了体内邪气,使经络通畅,起到扶正祛邪的作用。

大量的临床实践证明,拔罐疗法具有活血,行气,止痛,消肿,散结,退热,祛风,除湿,拔毒等作用,所以已被广泛应用于内、外、妇、儿、皮肤、五官等科病症的治疗。

二、 经络学说

1、经络的作用 经络系统是人体统一整体的重要组成部分,它有

三方面的功能：

(1) 在生理方面，有运行气血、协调阴阳的功能。

(2) 在病理方面，有抵御病邪、反映症候的功能。

如果邪气不断侵入，疾病发生。经络系统也将有层次地，从表及里、由浅(体表)入深(体内)反映症候。同样，由脏腑所生的病症也会沿着经络的通路反映到体表。由于经络有一定的循环路线和所属的脏腑，所以经络与经络之间，经络与脏腑之间，在反映症候上也是互相对应，互相联系，息息相关的。这在中医临床上常用于疾病的诊断。如头痛一证，即可根据经脉在头部的循行分布而辨别，其痛在前额者，多与阳明经有关；痛在颈项者，多与太阳经有关；痛在巅顶者，多与厥阴经有关；痛在两侧者，多与少阳经有关。内脏有病时，可在有关部位寻找其压痛点，便可得知其为何脏、何腑的病症，如肠痹患者，有时在足阳明胃经上的足三里与上巨虚穴间出现压痛；脾不促运，长期消化不良，脾俞穴可出现压痛、结节或疹点；肺脏有病，中府穴可有明显压痛，或在肺俞穴出现结节。

(3) 在防病、治病方面，有传导感应，调整虚实的作用

经络系统不仅有运行气血的作用，而且有感应传导的作用，所以经络系统也是人体各组成部分之间的传导网。当使用拔罐疗法时，拔罐所产生的刺激，将通过经络传导于脏腑，以达到调节脏腑的功能。当人体发生疾病时，出现气血不和及阴阳偏盛偏衰时，通过拔罐可以激发经络的调节作用，以“泻其有余，补其不足，阴阳平复”。实践证明刺激有关经络的穴位，对各脏腑有调节作用，原来亢进的可使之抑制，原来抑制的可使之兴奋。经络系统的这个作用被广泛应用在临床治疗和预防疾病上。

人体十二经脉和任脉、督脉是经络系统的主要组成部分，在正常情况下起着运行气血，濡养人体器官组织的作用，而当其受到某种致病因素的侵袭，经络就会通过联系的相对应的有关部位反应出各种症状和体征来，称之为“症候”。经络病候对诊断治疗起着重要作用。

十四经病候表现，都是经络脏腑机能发生病理变化时出现的异常现象。祖国医学的施治方法，无论是内服药，外敷，或针灸，推拿，拔罐

罐,将十四条经脉轮流拔拭,将能很好地增加机体抗病能力。

本文详细绘出了各经的循行路线(A图)和各经上的穴位分布(B图)。患者可根据A图循行走罐,同时按B图所示选择穴位进行拔罐,对细小局部无法拔罐的穴位可用罐口进行刮痧。

注:除任、督脉上的穴位外,其余十二经脉均为左、右对称。比如合谷,左右手各一个。患者使用时,可这次选左边的,下次选右边的。

【1】手太阴肺经(与手阳明大肠经为表里经)

(1) 循行路线:手太阴肺经起于中焦,下行络大肠,再上行至胃,通过膈膜归属于肺,再从气管到喉。横出腋下,沿上肢内侧前缘,经过寸口,到拇指桡侧端。有分支从腕后分出,绕到食指桡侧端(接于手阳明大肠经),见图1A、图1B。

(2) 本经穴:中府、云门、天府、侠白、尺泽、孔最、列缺、经渠、太渊、鱼际、少商。

(3) 本经病候:本经所属腧穴能治疗和预防下列病症:胸闷胀满、缺盆痛、咳嗽、气喘、桡臂痛、肩背痛。

(4) 治疗和预防方法:常拔罐手太阴肺经和表里经(手阳明大肠经)上的穴位或循行走罐,可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【2】手阳明大肠经(与手太阴肺经为表里经)

(1) 循行路线:直于食指桡侧端,经手背行于上肢伸侧前缘,上肩经大椎穴,向前下入锁骨上窝(缺盆)。在此分为两支:一支入胸络肺,通过膈膜连属大肠;另一支同锁骨上窝上行,经颈部到面部,进入下齿中,环出口角和上唇,与另一侧手阳明大肠经相交,到对侧鼻翼两旁(接于足阳明胃经),见图2A、图2B。

(2) 本经穴:商阳、二间、三间、合谷、阳溪、偏历、温溜、下廉、上廉、手三里、曲池、手五里、臂臑、肩髃、巨骨、天鼎、扶突、禾髃、迎香。

(3) 本经病候:本经所属腧穴能治疗和预防下列病症:下牙痛、咽喉肿痛、口干、颈部肿胀、眼睛昏黄、鼻塞、流清涕、肩前、上臂部痛。

(4) 治疗和预防方法:常拔手阳明大肠经和表里经(手太阴肺经)上的穴位或循经走罐,可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【3】足阳明胃经(与足太阴脾经为表里经)

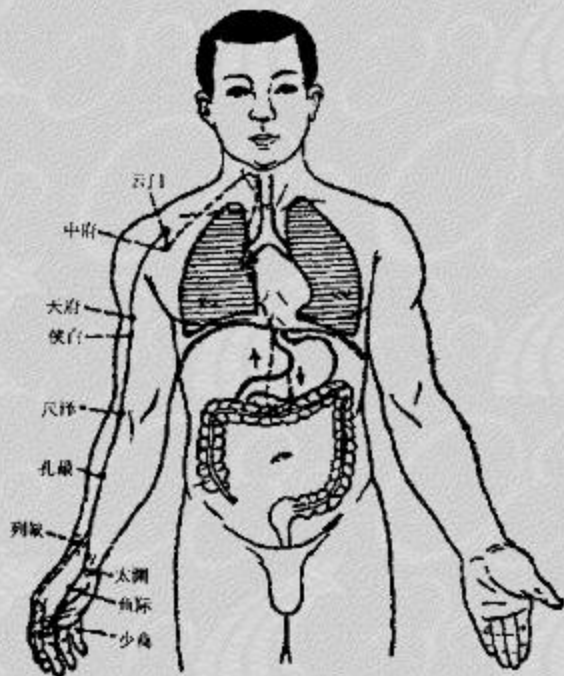


图 1A 手太阴肺经循行部位图

(1) 循行路线：起于鼻翼两侧，经眼内角、眼眶下，进入上齿，环绕嘴唇，交于承浆，分布于耳前、前额等处，然后从颊部下行，沿喉咙进入锁骨上窝。在此分为两支，一支经过胸部膈膜，属胃络脾，下行至腹股沟；另一支经乳头，沿腹部下行，二支会于腹股沟。再沿下肢外侧下行，经足背，到达第二足趾外侧端；并有三支：一支从膝腘下缘（足三里）连接第三趾外侧端；另一支从足背接到足大趾内侧端（交于足太阴脾经）见图 3A、图 3B。

(2) 本经穴：承泣、四白、巨髎、地仓、大迎、颊车、下关、头维、人迎、水突、气舍、缺盆、气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根、不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门、天枢、外陵、大巨、水道、归来、气冲、髀关、伏兔、阴市、梁丘、犊鼻、足三里、上巨虚、条口、下巨虚、丰隆、解溪、冲阳、陷谷、

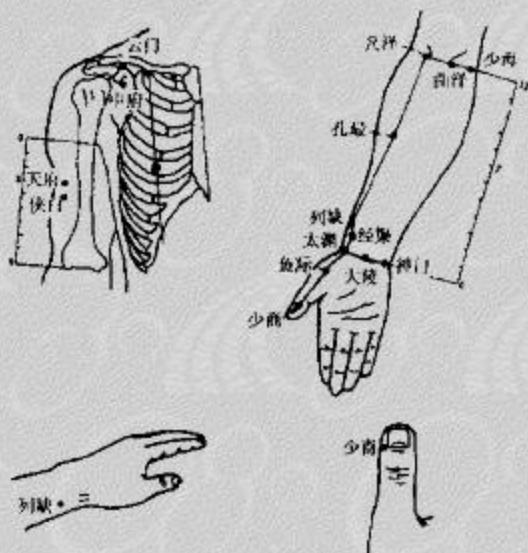


图 1B 手太阴肺经穴分布图

内庭、厉兑。

(3) 本经病候：本经所属腧穴能治疗和预防下列病症：高热汗出，鼻衄，唇疹，口歪，咽喉痛，颈痛，惊惕，发狂，脘腹胀满，肠鸣，腹水，下肢外侧及足背痛或运动障碍。

(4) 治疗和预防方法：常拔足阳明胃经和表里经（经足太阴脾经）上的穴位或循经走罐，可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【4】足太阴脾经（现足阳明胃经为表里经）

(1) 循行路线：起于足大趾内侧端，经足内踝前上行，交出于足厥阴肝经之前，沿下肢内侧入腹部，属脾络胃。通过膈膜进入胸部，上行于咽喉侧，连舌根，分布于舌下，并有分支从胃上膈到心中（接于手少阴心经）见图 4A、图 4B。

(2) 本经穴：隐白、大都、太白、公孙、商丘、三阴交、漏谷、地机、阴陵泉、血海、箕门、冲门、府舍、腹结、大横、腹哀、食窦、天溪、胸乡、周荣、

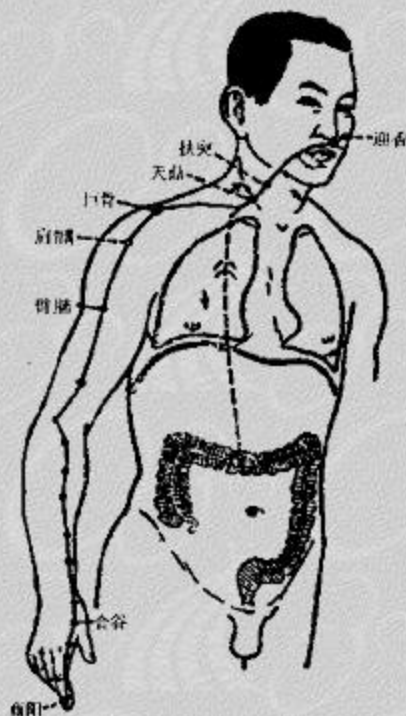


图 2A 手阳明大肠经循行部位图

大包。

(3) 本经病候：本经所属腧能治疗和预防下列病症：舌本强，食则呕与善噎，倦怠无力，身体困重，脘腹胀痛，大便溏泻，下肢内侧肿痛或厥冷，足大趾运动障碍等。

(4) 治疗和预防方法：常拔足太阴脾经及表里经（足阳明胃经）上的穴位或循经走罐，可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【5】手少阴心经（与手太阳小肠经为表里经）

(1) 起于心中，连接“心系”从心系分三支：一支经肺膈肌，络小肠；一支沿食管上行，经咽部，连接“目系”；一支经肺部到腋窝，沿上肢屈侧

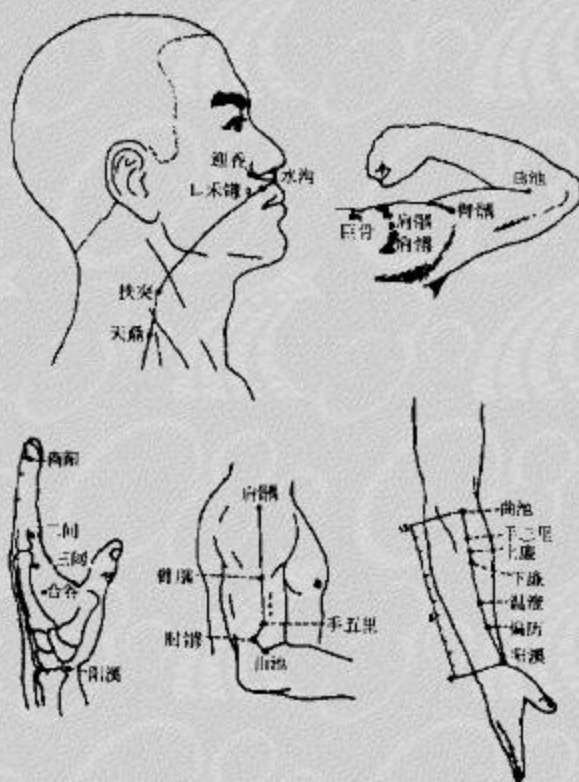


图 2B 手阳明大肠经穴分布图

后缘小指桡侧端(交于手太阳小肠经)见图 5A、图 5B。

(2) 本经穴:极泉、青灵、少海、灵道、通里、阴郛、神门、少府、少冲。

(3) 本经病候:本经所属腑穴能治疗和预防下列病症:心前区疼痛,胸痛,咽干,口渴,上肢屈侧后缘疼痛,厥冷,手心热等。

(4) 治疗和预防方法:常拔手少阴心经及表里经(手太阳小肠经)上的穴位或循经走罐,可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【6】手太阳小肠经(与手少阴心经为表里经)

(1) 循行路线

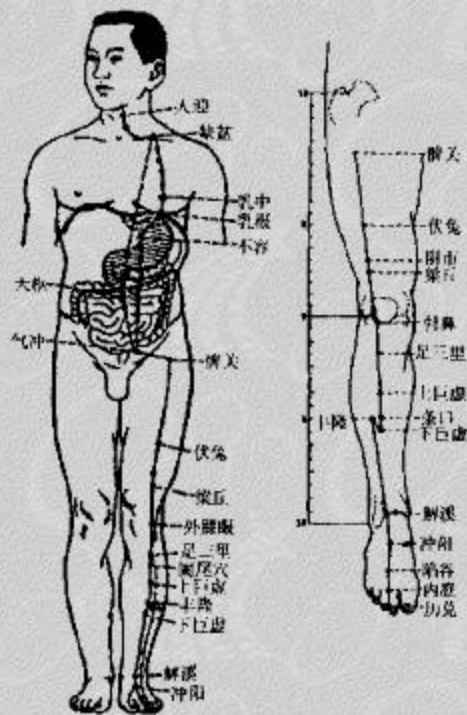


图 3A 足阳明胃经循行部位图

起于小指尺侧端，沿上肢伸侧后缘上行，经肩后下方，绕肩胛，与督脉交汇于大椎，向前折入锁骨上窝，进入胸中，与心脏联络继而下行，通过膈肌进入腹腔，归属于小肠；从缺盆分出的支脉沿颈侧，上颊部，到眼角，并从面部分支于到眼角内（内于足太阳膀胱经）见图 6A、图 6B。

(2) 本经穴：少泽、前谷、后溪、腕骨、阳谷、养老、支正、小海、肩贞、髃俞、天宗、秉风、曲垣、肩外俞、肩中俞、天窗、天容、颞髃、听宫。

(3) 本经病候：耳聋、目黄、咽痛、下颌及颈部肿痛以致不能转动，肩、臂部均牵引作痛，以及上肢伸侧后缘疼痛等。

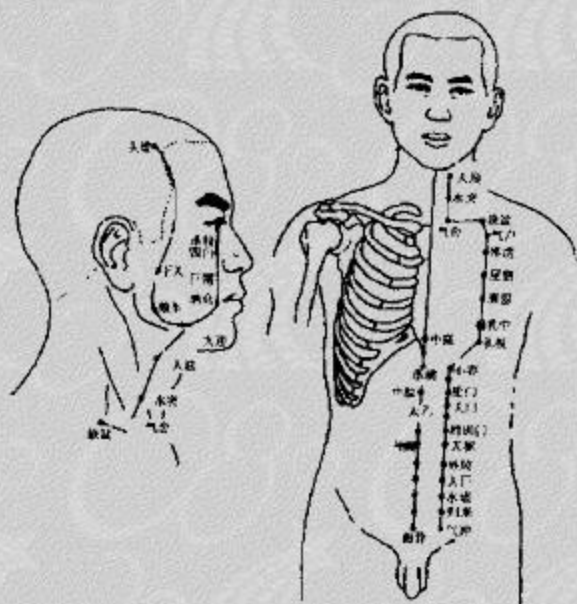


图 3B 足阳明胃经穴分布图

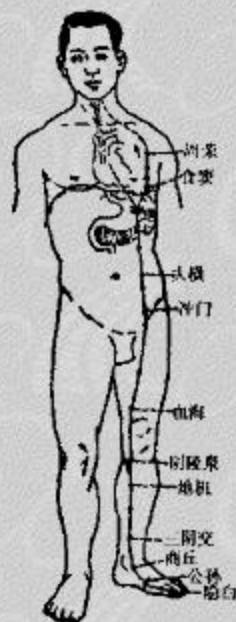
(4) 治疗和预防方法:常拔手太阳经和表里经(手少阴心经)上的穴位或循经走罐,可预防或治疗本经病候所列表的病症。

【7】足太阳膀胱经(与足少阴肾经为表里经)

(1) 循行路线

起于眼内角,上额,分布于头顶,及耳上角并由头顶入颅内络脑,出项后分二支:一支由项下行(沿背中线旁开1.5寸)到腰部,络肾,属膀胱,并从腰下行,经股部后侧进入腘窝;另一支由项部经肩胛下行到臀部(沿背中线旁开3寸),下到腘窝,与前一支会合。然后下入腓肠肌,经外踝后方,到达小趾外侧端(交于足少阴肾经)见图7A、图7B。

(2) 本经穴：睛明、攒竹、眉冲、曲差、五处、承光、通天、络却、玉枕、天柱；大杼、风门、肺俞、厥阴俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃



4A 足太阴脾经循行部位图

俞、三焦俞、肾俞、气海俞、大肠俞、关元俞、小肠俞、膀胱俞、中膂俞、白环俞、上髂、次髂、中髂、下髂、会阳；附分、魄户、膏肓、神堂、噎膈、膈关、魂门、阳纲、意舍、胃仓、育门、志室、胞育、秩边、承扶、殷门、浮郄、委阳、委中、合阳、承筋、承山、飞扬、跗阳、昆仑、仆参、申脉、金门、京骨、束骨、通谷、至阴。

(3) 本经病候：

本经所属腧穴能治疗和预防下列病症：

头项强痛，腰背痛及运动障碍，眼球胀痛，癰疽及疔疮，腓肠肌，足小趾等处疼痛或运动障碍。

(4) 常按足太阳膀胱经和表里经(足少阴肾经)上的穴位或循经走罐，可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【8】足少阴肾经(与足太阳膀胱经为表里经)

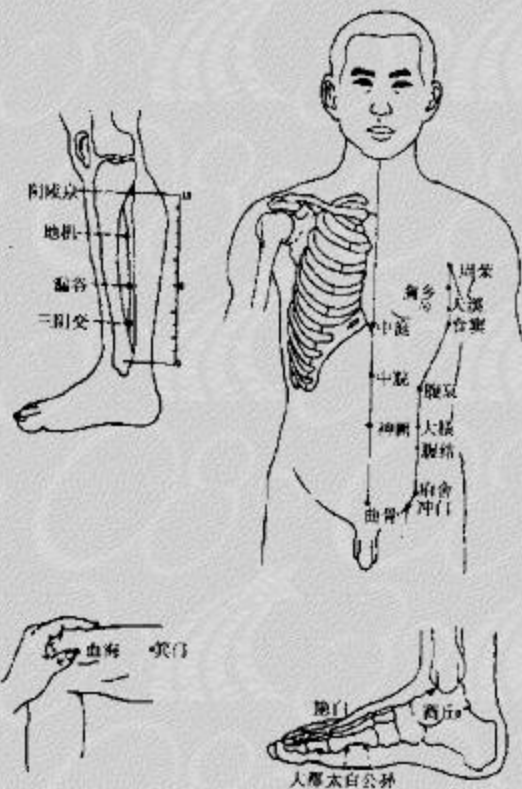


图 4B 足太阴脾经穴分布图

(1) 循行路线

起于足小趾，斜走足心和内踝下方，中下肢内侧后缘上行，贯脊属肾，络膀胱；并从肾上行，穿过肝和膈肌，进入肺中（交于手厥阴心包经）。从肺分出二支：一支络心并分布于胸中，一支沿喉咙到舌根两侧（见图 8A、图 8B）。

(2) 本经穴：涌泉、然谷、太溪、大钟、水泉、照海、复溜、交信、筑宾、阴谷、横骨、大赫、气穴、四满、中注、育俞、商曲、石关、阴都、通谷、幽门、步廊、神封、灵墟、神藏、谿中、俞府。

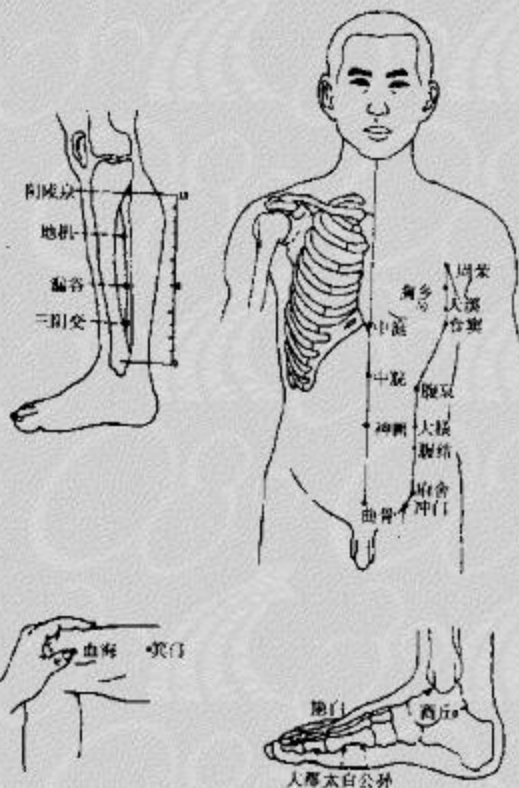


图 4B 足太阴脾经穴分布图

(1) 循行路线

起于足小趾，斜走足心和内踝下方，中下肢内侧后缘上行，贯脊属肾，络膀胱，并从肾上行，穿过肝和膈肌，进入肺中（交于手厥阴心包经）。从肺分出二支：一支络心并分布于胸中，一支沿喉咙到舌根两侧见图 8A、图 8B。

(2) 本经穴：涌泉、然谷、太溪、大钟、水泉、照海、复溜、交信、筑宾、阴谷、横骨、大赫、气穴、四满、中注、育俞、商曲、石关、阴都、通谷、幽门、步廊、神封、灵墟、神藏、谿中、俞府。

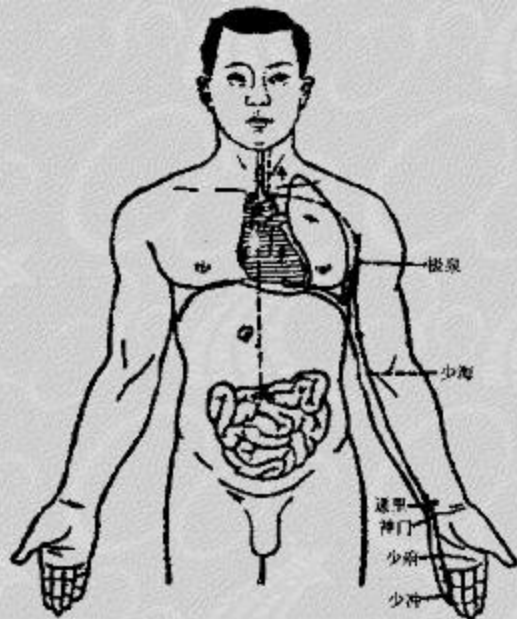


图 5A 手少阴心经循行部位图

(3) 本经病候：本经所属腧穴有治疗和预防下列病症：

气短喘促，咳嗽咯血，头昏目眩，心如悬若饥状，惊恐，口舌干燥，咽干及肿痛，心胸烦闷、疼痛，腹泻，腰脊疼痛，下肢无力，厥冷，足心发热等。

(4) 经常拔足少阴肾经和表里经(足太阳膀胱经)上的穴位或循经走罐，可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【9】手厥阴心包经(与手少阳三焦经为表里经)

(1) 循行路线

起于胸中，出属心包，再下膈肌，历络上、中、下三焦，另一支脉从胸中出于胁部，经腋窝下，沿中上肢屈侧中线，到中指末端。有分支从掌心分出，沿无名指尺侧缘到指端(交于手少阳三焦经)。见图 9A、图 9B。

(2) 本经穴：天池、天泉、曲泽、郄门、间使、内关、大陵、劳宫、中冲。

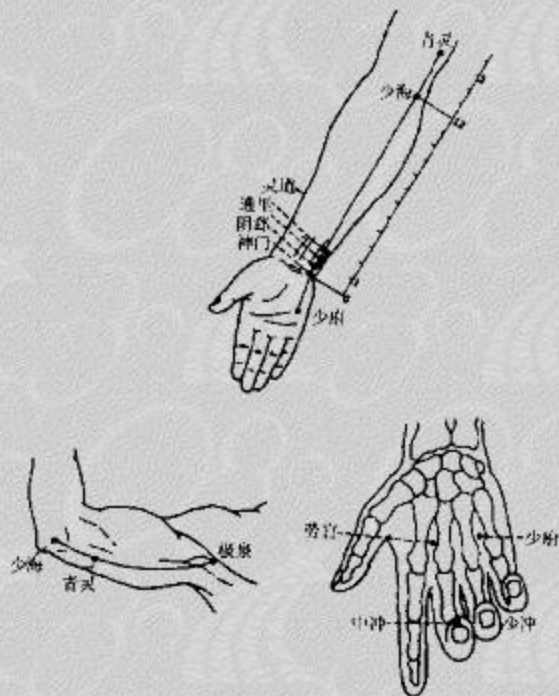


图 5B 手少阴心经穴分布图

(3) 本经病候：本经所属腧穴能治疗和预防下列病症：
心悸，心烦，胸胁支满，心前区痛，上肢痉挛，手心热等。

(4) 常拔手厥阴心包经和表里经（手少阳三焦经）上的穴位或循经走罐，可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【10】手少阳三焦经（与手厥阴心包经为表里经）

(1) 循行路线

起于无名指（尺侧），上行经手腕出臂外尺桡二骨之间，沿上肢伸侧中线到肩后，折入锁骨上窝，分布于胸中的“膻中”。在膻中分为二支：一支联络心包，穿过膈膜，历膻上、中、下三焦；另一支由膻中，经锁骨上窝、颈部、耳后、耳上方、颊部，到目下。并有小支从耳后入耳中，出耳前，

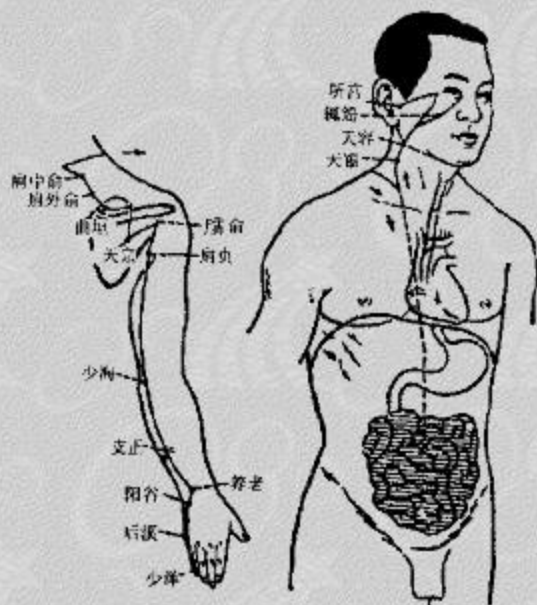


图 6A 手太阳小肠经循行部位图

布于颊部及目外角(交于足少阳胆经)。见图 10A、图 10B。

(2) 本经穴:关冲、液门、中渚、阳池、外关、支沟、会宗、三阳络、四渎、天井、清冷渊、消泅、臑会、肩髃、天髃、天髃、翳风、瘰脉、颌息、角孙、耳门、和髃、丝竹空。

(3) 本经病候:本经所属腧穴能治疗和预防下列病症:

耳聋,咽喉肿痛,颊部、耳后疼痛,肩部、前臂痛,或无名指运动障碍等。

(4) 常拔手少阳三焦经和表里经(手厥阴心包经)上的穴位或循经走罐,可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【11】足少阳胆经(与中厥阴肝经为表里经)

(1) 循行路线

起于眼外角,环绕分布于耳前后(有分支从耳后,入耳中,出耳前,

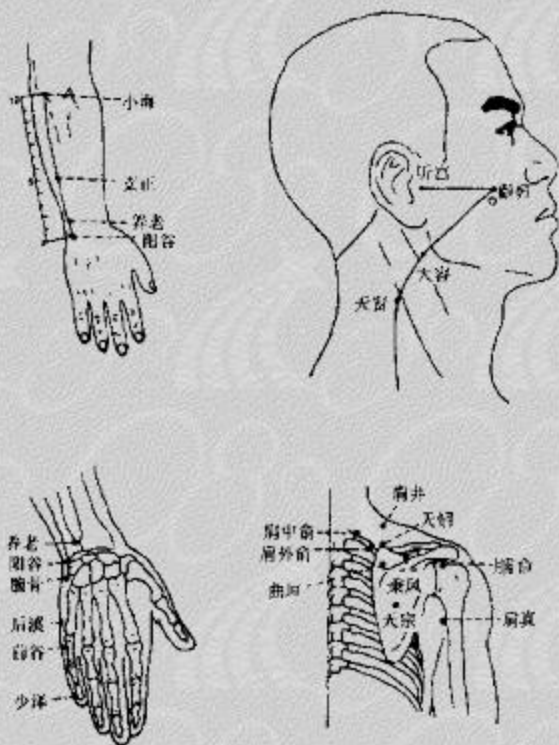


图 6B 手太阳小肠经穴分布图

到眼外角，并从眼外角经下颌角到目下，折向颈部），由颈部侧面，进入锁骨上窝。并分为二支：一支入胸中，过膈肌，络肝属胆，经腹股沟绕阴毛边缘，横入髋关节；另一支经腋窝，分布于胸、腹的侧面。两支在关节会合，后沿下肢外侧中线下行，经外踝到足第四趾外侧端。并有小支沿足背到大趾爪甲后（交于足厥阴肝经）。见图 11、图 11B。

(2) 本经穴：瞳子髎、听会、上关、颞颥、悬颅、悬厘、曲鬓、率谷、天冲、浮白、头窍阴、完骨、本神、阳白、头临泣、目窗、正营、承灵、脑空、风池、肩井、渊液、辄筋、日月、京门、带脉、五枢、维道、居髎、环跳、风市、中渎、膝阳关、阳陵泉、阳交、外丘、光明、阳辅、悬钟、丘墟、足临泣、地五

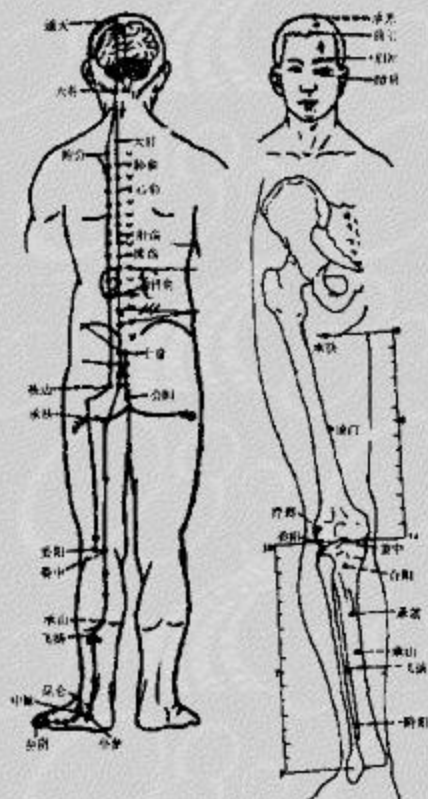


图 7A 足太阳膀胱经循行部位图

会、侠溪、足窍阴。

(3) 本经病候：本经所属腧穴能治疗和预防下列病症：往来寒热，口苦，善叹息，胁痛，偏头痛，疟疾及股、膝、小腿外侧及足第四趾等处疼痛或运动障碍等。

(4) 常拔拭足少阳胆经和表里经（足厥阴肝经）上的穴位或循经走罐，可预防或治疗本经病候所列示的病症。

【12】足厥阴肝经（与足少阳胆经为表里经）

(1) 循行路线：起于足大趾背面甲后，经过足背和内踝前，沿下肢

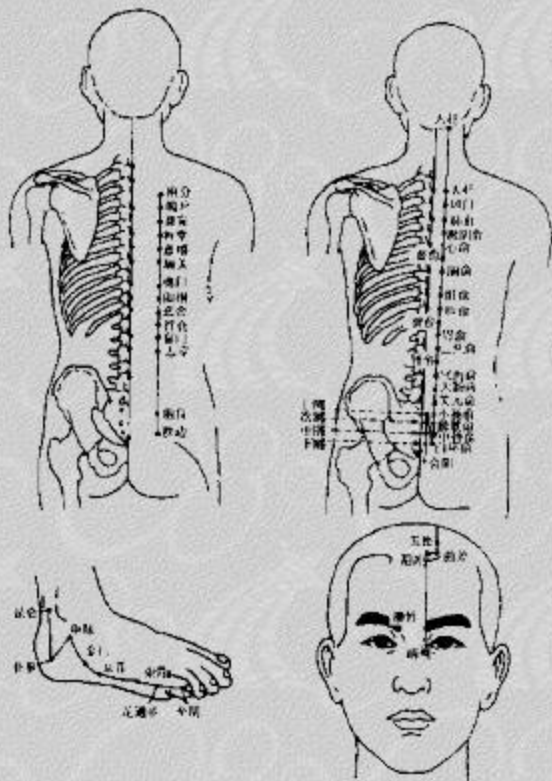


图 7B 足太阳膀胱经穴分部图

内侧上行。在小腿中部(踝上八寸处)交叉到足太阴脾经的后方,再沿股内侧上行,绕阴部,过小腹,经过胃的两旁,属肝络胆,上贯膈肌,分布于胁肋,并注入肺(交于手太阴肺经),再沿喉咙后面向上进入鼻咽部,连接“目系”。由目系分成二支:一支向下,环绕口唇;一支向上出于前额,与督脉会合于头顶。见图 12A、图 12B。

(2) 本经穴:大敦、行间、太冲、中封、蠡沟、中都、膝关、曲泉、阴包、足五里、阴廉、急脉、章门、期门。

(3) 本经病候:本经所属腧穴能治疗和预防下列病症:腰痛、胁胀

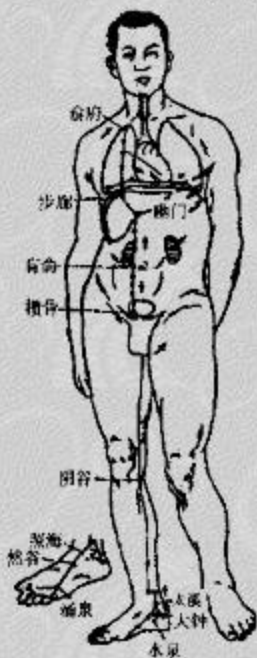


图 3A 足少阴肾经循行部位图

痛,胸满,呕吐,腹泻,疝气,尿闭,妇女少腹胀等。

常按足厥阴肝经和表里经(足少阳胆经)上的穴位或循经走罐,可预防或治疗本经病候所列表的病症。

【13】督脉

督,有总督的意思。督脉行于背正中,能总督一身之阳经,故又称“阳脉之海”。

(1) 循行部位:起于胞中,下出会阴,后行一腰背下中,经颈部,进入脑内,属脑,并由项沿头部中线,经头顶、额部、鼻部、上唇,到上唇内系带处。并有支脉络肾,贯心。见图 13A、图 13B。

(2) 本经穴:长强、腰俞、腰阳关、命门、悬枢、脊中、中枢、筋缩、至阳、灵台、神道、身柱、陶道、大椎、哑门、风府、脑户、强间、后顶、百会、前

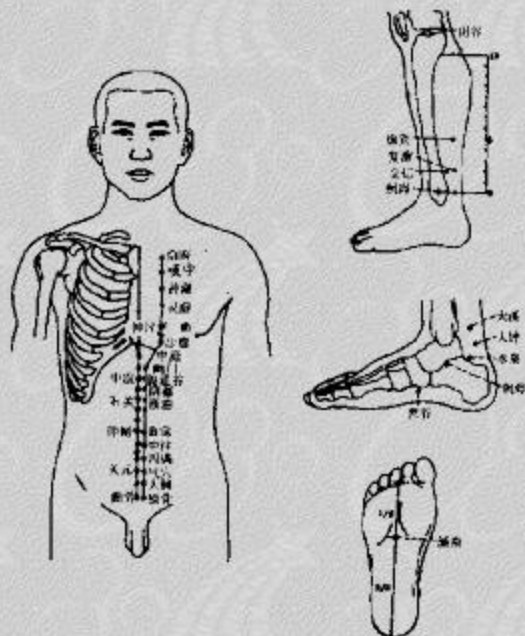


图 8B 足少阴肾经穴分部图

顶、颞会、上星、神庭、素髎、水沟、兑端、龈交。

(3) 本经病候：本经所属腧穴治疗和预防下列病症：脊柱强直，角弓反张，脊背疼痛，精神失常，手足麻木，手足拘挛，中风不语，头部和小儿惊厥等。

(4) 常按督脉上的穴位或循经走罐，可预防或治疗本经病候所显示的病症。

【14】任脉

这条经脉行于胸腹部的正中，能总任一身之阴经，故有“阴脉之海”之说。任，还有“妊养”的意思，其脉起于胞中，在女子具有孕育胎儿的作用，故又有“任主胞胎”的说法。

(1) 循行部位：起于胞中，下出会阴，经阴阜沿腹部正中线上行，通

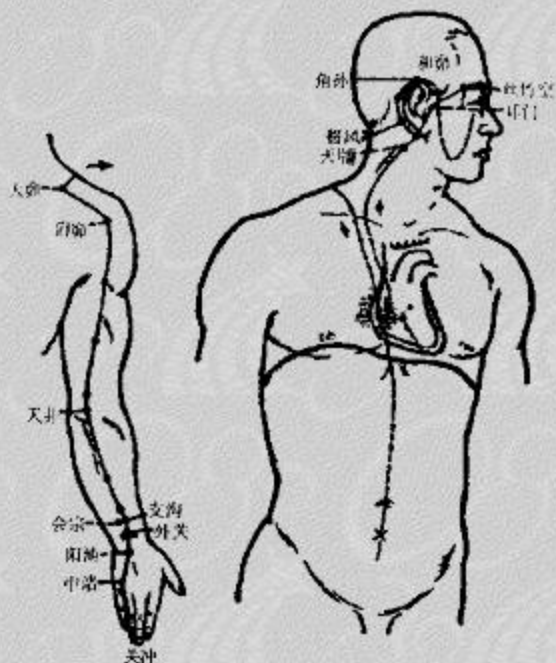


图 10A 手少阳三焦经循行部位图

三、微循环理论

皮肤上拔罐后,使毛细血管扩张,局部充血,通过温热和机械负压刺激作用,引起局部和全身反应,从而调整机体的功能,消除病理因素,以达到治病的目的。临床实践证实拔罐具有平衡阴阳、扶正祛邪、疏通经络、宣通气血、增强体质、祛风除湿、温经散寒、通利关节、温固阳气、清热泻火、止痛消肿、托毒排脓、健脾和胃、宽胸宣肺、调整脏腑等作用。但其治疗机理离不开中医脏腑经络理论。人体患病在外为风、寒、湿、毒、热侵入机体后,使脏腑功能失调,产生的病理产物无非是瘀血、滞气、痰涎、宿食、邪火、水浊这些致病因子。这些致病因子通过经络和腧穴走窜、逆乱、充斥、滞留、瘀阻,从而出现种种疾病。拔罐后的真空负压有一种较强的吸拔力,其作用于经络穴位上,能够开泄腠理,将汗毛孔

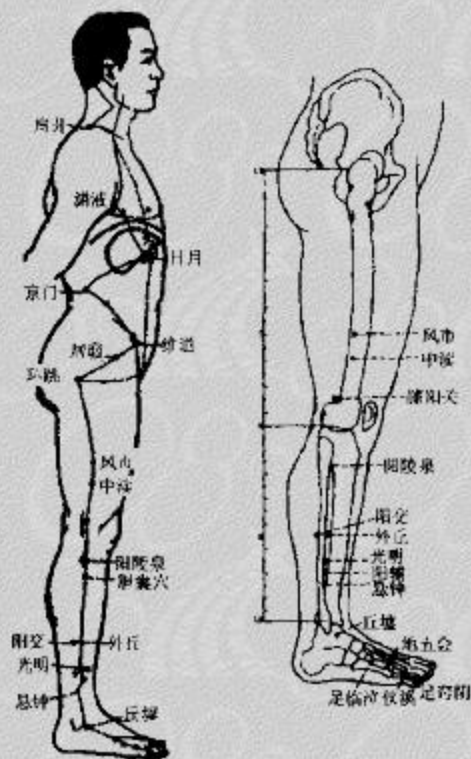


图 11A 是少阳胆经循行部位图

小口罐的吸拔力，临床上实际应用的负压值一般多在 320mmHg。抽气拔罐器为 320mmHg，30 分钟内负压值基本不变。这样大的负压吸拔力，能引起皮肤发红、瘀紫，使局部毛细血管充血，甚至破裂，红细胞破坏，产生溶血现象，使部分细胞蛋白质分解，产生组织胺或类组织胺物质，促使毛细血管扩张，改善局部皮肤营养，促进神经兴奋或抑制，刺激神经末梢感觉传递，提高肌肉工作能力与耐力，加速血液及淋巴液循环，促进胃肠蠕动，改善功能，促进和加快肌肉和脏腑对代谢产物的清除排泄。

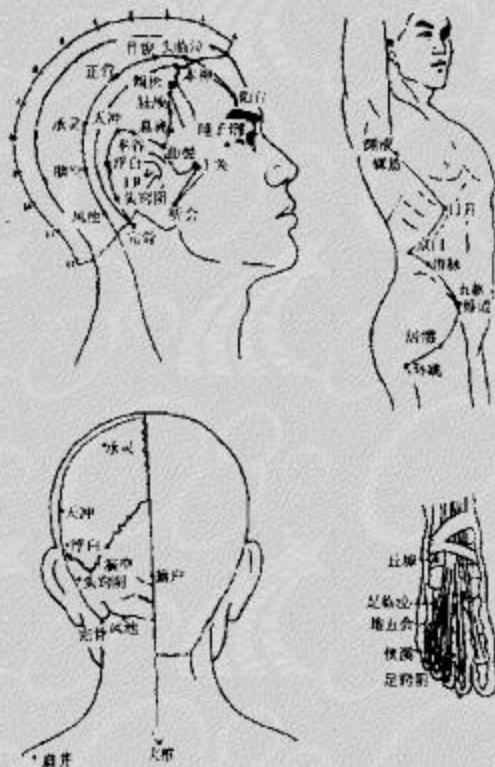
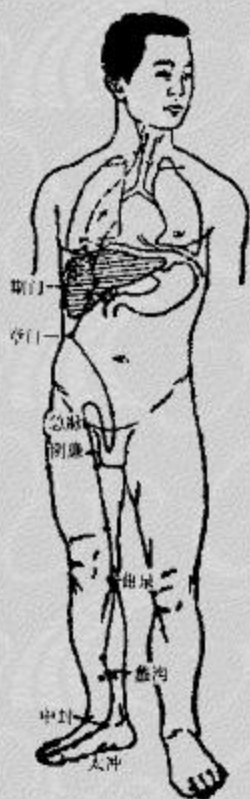


图 11B 足少阳胆经脑穴分部图

此外,拔罐的作用还随其使用拔罐方法不同而有所侧重和区别。如留罐主吸拔风寒痼冷;闪罐主祛风疏经;走罐宜卫祛邪,通络活血;疏排法则泻实。同时,虽然拔罐的作用是多方面的,但如果与别的治法如温和灸、贴敷、按压等结合起来,那么临床作用和治疗效果必将大大加强,其应用范围也将大大扩展。拔罐的机理是一个复杂的综合过程,目前的研究还不够深入和全面,需要进一步研究与探索。

附：磁疗作用

可通式磁疗拔罐的中央配有永磁材料,是集中医针灸、磁疗、拔罐



12A 足厥阴肝经循行部位图

于一体的新罐具，具有磁疗作用。

(一) 磁穴疗法

磁穴疗法，简称“磁疗”，是利用磁场作用于人体经络穴位或患部以治疗疾病的一种方法。在我国应用磁石治疗疾病，历史非常悠久。早在公元前 39 年，就有“磁石招铁”的记载。《史记·扁鹊仓公列传》载有磁石治病之说。公元前二世纪《神农本草经》中明确记载“磁石味辛，至周痹风湿，肢节肿痛不可持物……”。

这些记载都是将磁石作为内服药物应用。宋代严用和《济生方·耳

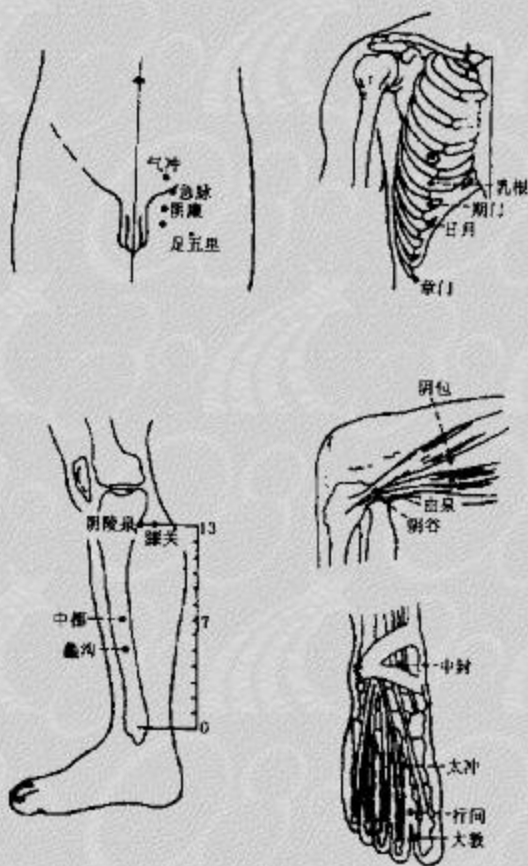


图 12B 足厥阴肝经经验穴分部图

门》所载“鸣聋散”治耳鸣耳聋，以“磁石一块如豆大，穿山甲烧存性，为末，右用新绢子裹了，塞于所患耳内，口中衔小生铁，觉耳内如风声即住。”此为目前所见我国将磁石微弱场能用于外治的最早记载。此后《直指方》也记有“铁石半钱，入病耳内，铁砂末入不病耳内，自然通透”。国外应用磁疗也较早，公元前 50 年希腊有手握磁石疗法治痛风报告，15 世纪以后相继出现磁带等磁械，本世纪 50 年代曾用磁性降压带治疗高

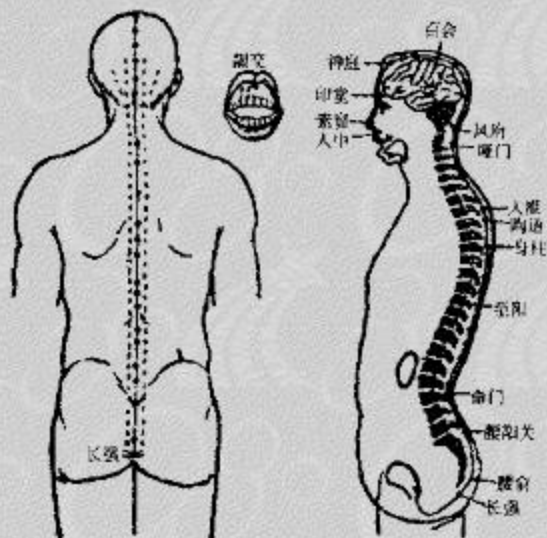


图 13A 督脉循行部位图

血压病及神经衰弱。1961 年第一次国际生物磁学会议后，产生了“生物磁学”这一边缘科学，十多年来对磁场生物效应，生物磁场和磁共振等方面已有不少研究。我国医务工作者努力继承和发掘祖国医学遗产，1973 年湖南和北京首先用稀土元素钐钴、钕钴永磁体作穴位治疗，创造性地将经络结合起来，提高了治疗效果，扩大了治疗范围。

(二) 磁场对人体的作用

1. 镇痛作用 疼痛是机体接受刺激后生理、心理的综合反应，大约 90% 的疾病的主要临床症状是疼痛，磁场可以降低反应疼痛的一项重要客观指标——内啡肽，延缓它的存在，即可延长镇痛时间。就中医学来看，“不通则痛”，磁场作用于患处可引起毛细血管扩张、血流加快，这即是“通则不痛”。此外，疼痛就局部来看主要是由于缓激肽，组织胺，五羟色胺，钾离子达到一定浓度引起的，经磁场作用后血流加快，能够减少这些致痛物质的局部浓度，从而达到止痛的效果。

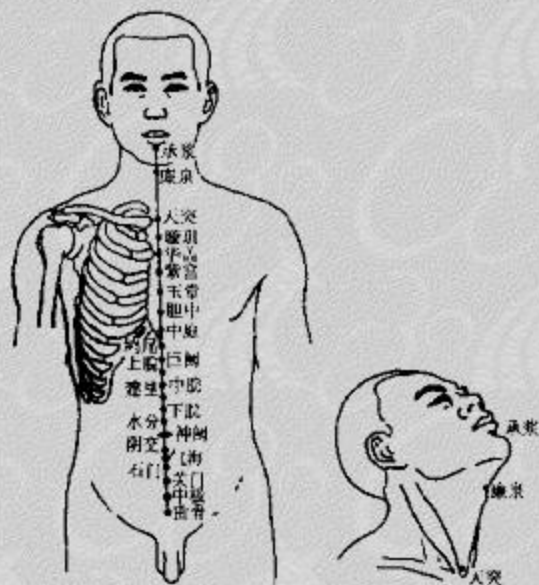


图 14B 任脉穴分部图

第三章 拔罐的方法及注意事项

一、罐具的种类

罐具的种类很多。最早的罐具用兽角制成,以后又出现竹罐、陶罐、玻璃罐,随着科技的发展,目前又研制出新一代罐具——可调式拔罐。各种罐具特点不同,临床上应根据需要选用。

1、竹罐:用坚固的细毛竹,截成长6—9厘米的竹管,一端留节为底,一端为罐口,口径为3厘米、4.5厘米、5厘米不等。用刀刮去青皮及内膜,管壁的厚度约0.6—1厘米,用砂皮磨光,口圈必须平正光滑。竹罐的特点是轻巧、价廉、不易跌碎,且取材容易,制作简便,但易爆裂漏气。

2、陶罐:由陶土烧制而成,罐的两端较小,中间略向外展,形同腰鼓,口径的大小不一。特点是吸力大,但较重,且落地易碎。

3、铜罐和铁罐:采用铜或铁皮制成,形状如竹罐,口径的大小不一。特点是不易破碎,但传热太快,容易烫伤皮肤,目前已较少应用。

4、玻璃罐:系用玻璃制成。特点是罐口光滑,质地透明,使用时可以窥测罐内皮肤的瘀血程度,便于掌握时间,但容易破碎,临床上应用最为广泛。日常生活中用的广口瓶也是很理想的拔罐工具。一般分大、中、小三个型号,其型如球状,下端开口,口小肚大。(见图3-1)

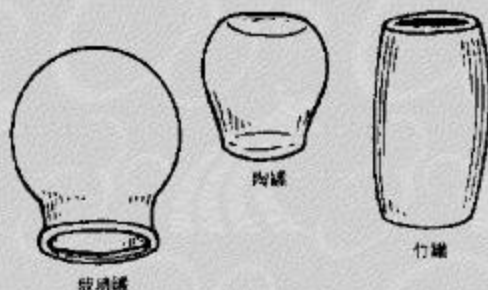


图3-1

5、挤压罐：由橡胶和塑料制成。其外形与玻璃罐相似但不透明，使用时只要用力将罐具挤压到一定程度，再将罐口扣在应拔部位并压紧，放松挤压后，罐具靠本身弹力恢复原形，罐内即形成负压状态而吸拔住。其优点是不怕摔跌，使用方便，适合患者自己拔罐。缺点是吸拔力维持时间短，且不便观察拔罐部位情况。

6、多功能罐：此罐是采用现代电真空、磁、红外线等技术研制的拔罐器具，一般多具备几种治疗功效。其罐的外形已非传统罐具模样，有的罐采用有机玻璃制成，负压及其他技术参数可调，使用较方便，唯价格较高，携带不便，尚未得到普及。

7、可调式磁疗拔罐：此罐是采用现代物理学原理制成，在罐内安装有螺旋式旋转装置，所以不需点火排气，只要旋转罐外的旋罩，即可使罐内形成负压，使之吸附于人体表面，并可根据病情的需要调整罐内负压，罐体用有机玻璃制成，质地透明，造型美观，坚固耐用，是理想的新一代罐具。

可调式样磁疗拔罐与传统拔罐的比较图 3-2

罐具	优点	缺点
竹罐	质轻，价廉	需点火，易爆裂，不透明，拔力小，无法调节罐内的负压
陶罐	拔力大	质重，需点火、易跌碎、体积大，不透明，无法调节罐内的负压
玻璃罐	透明	需点火，易跌碎，无法调节罐内的负压
可调式磁疗拔罐	质轻，透明，拔力大，不需点火，不易跌碎，可自如调节罐内的负压。有罐疗和磁疗的双重作用	无上述缺点。高科技产品，生产成本低，使用时间长

二、拔罐的方法

罐的吸拔主要是通过各种方法排去或抽出罐内的空气而使罐内产生负压,从而吸着于皮肤。

1、火罐法:

利用燃烧时火焰的热力,排去空气,使罐内形成负压,将罐吸着在皮肤上。具体操作方法有以下几种:

(1) 投火法:将小纸条点燃后,投入罐内,不等纸条烧完,迅速将罐罩在应拔的部位上。纸条未燃的一端向下,可避免烫伤皮肤。(图 3-3)

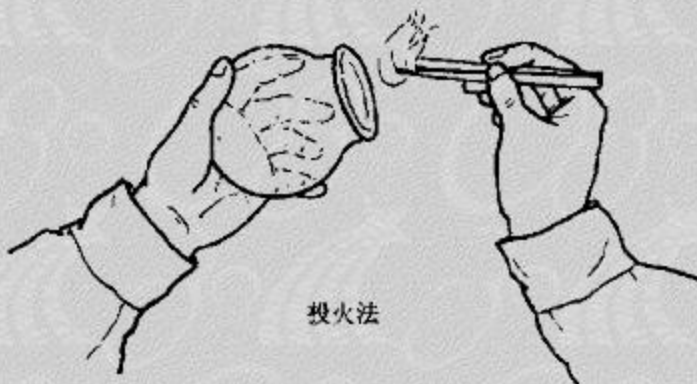


图 3-3

(2) 闪火法:用长纸条或用镊子夹酒精球或用特制的点火棒点燃火焰后,放入罐的中下部停留一下即抽出,迅速将罐子罩在应拔的部位上,即可吸住。

(3) 贴棉法:用 1 厘米见方的棉花一块,不要过厚,略浸酒精,贴在罐内壁上中段,以火柴点着,罩于选定的部位上,即可吸住。

(4) 架火法:用一不易燃烧及传热的块状物,直径 2—3 厘米,放在应拔的部位上,上置小块酒精棉球,点燃后将火罐扣上,可产生较强吸力。

(5) 滴酒法:在罐内壁上中段滴 1—2 滴酒精,将罐子横侧翻滚,使

酒精均匀附于罐壁上,点燃罐内酒精,迅速吸拔在应拔的部位上。

2、水罐法:

一般应用竹罐。先将罐子放在锅内加水煮沸,使用时将罐子倾倒入镊子夹出,甩去水液或用折叠的毛巾紧扣罐口,趁热按在皮肤上,即能吸住。

3、抽气法:

将青、链霉素或盐水瓶等,去掉瓶底部分,磨制成抽气罐,紧扣在需要拔罐的部位上,用注射器从橡皮塞抽出瓶内空气,使产生负压,即能吸住。或用抽气筒套在特制的抽气罐的活塞上,将空气抽出,即能吸着。

三、 临床常用罐法

1、单罐:用于病变范围较小或压痛点,可按病变或压痛范围的大小,选用适当口径的拔罐。如胃痛在中脘穴拔罐;冈下肌腱炎在天宗穴拔罐;网球肘在压痛点处拔罐。

2、多罐:用于病变范围比较广泛的疾病,酌量吸拔数个乃至十几个。如某一肌束劳损时可按肌束的位置成行排列吸拔多个火罐,称为“排罐法”。治疗某些内脏或器官的瘀血时,可按脏器的解剖部位的范围在相应的体表部位纵横并列吸拔几个罐子。

3、闪罐:罐子吸上后,立即取下,反复吸拔多次,至皮肤潮红为止。多用于局部皮肤麻木或机能减退的虚症病人。

4、留罐:拔罐后,留置一定的时间,一般留置5—20分钟。罐具吸力强的应适当减少留罐时间,夏季及肌肤嫩薄处,留罐时间也不宜过长,以免起疱损伤皮肤。这种方法能加强拔罐的持续作用,所以在临床上最为常用。

5、走罐:又称“推罐”,一般用于面积较大,肌肉平厚的部位,如腰背臀、大腿部等。须选口径较大的罐子,罐口要求平滑。先在罐口涂一些滑润油脂,将罐吸上后,以手握住罐底,稍倾斜,即后半边着力,前半边提起,慢慢向前推动,这样在皮肤表面上下或左右来回推拉移动数次,至皮肤潮红为止(如图3-4)。

四、 拔罐疗法与其它疗法的关系

拔罐疗法属于中医针灸学的范畴,常与针灸、推拿、刮痧、药物等疗

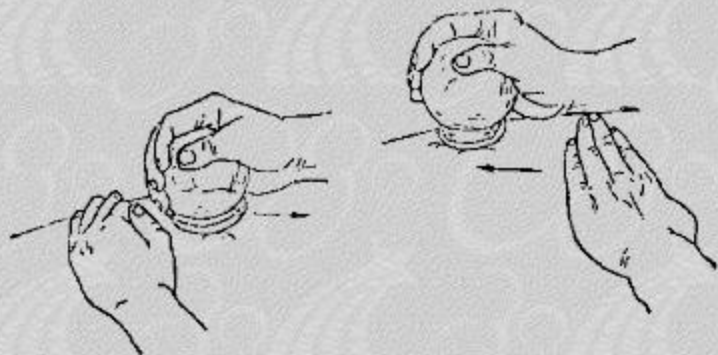


图 3-4

法配合使用,以达到更好的效果。

1、与针灸配合使用

俗语说:“针灸拔罐,病好一半”,这说明拔罐疗法与针灸是密切不可分的,一方面拔罐需要针灸理论加以指导,另一方面拔罐常与针灸一起配合使用。

(1) 针罐

针罐是指先在一定部位施行针刺,待达到一定刺激量后,将针留原处,再以针刺为中心,拔上火罐,以增加治疗效果的一种方法。

针罐结合,增强了对经络穴位的刺激量,常用于比较顽固的病证:如中医所指的“痹证”。如顽固性风湿痛,陈旧性筋骨损伤,坐骨神经痛,腰椎间盘突出等病症。

针罐时应注意手法的掌握,防止滞针、断针。

(2) 灸罐

灸罐是指先在穴位上施以艾灸,等局部皮肤潮红后再进行拔罐。灸罐的目的是增加穴位的温热刺激作用,有散寒除湿,温阳镇痛的效果,常用于寒湿入侵或阳虚内寒病证的治疗,如风湿性关节炎,腰肌劳损,手足冰凉,腰背冷痛,月经不调,遗精,带下等病症。

(3) 刺络拔罐

刺络拔罐是指用三棱针、皮肤针（梅花针、七星针等）刺激病变局部或小血管，使其潮红、渗血或出血，然后加以拔罐的一种方法。

刺络拔罐的应用范围非常广泛，具有开窍泄热、活血祛瘀、清热止痛、疏经通络等功能。既适用于实证和热证，又适用于虚证和寒证。

方法：先在局部刺络出血，然后再进行拔罐，实证和热证留罐 2—5 分钟，虚证和寒证留罐 10—15 分钟左右取下，再用干棉球擦净皮肤即可。

2、与药物配合作用

（1）煮药罐：将配制成的药物装入布袋中，扎紧袋口，放入清水煮至适当浓度，再把罐具投入药汁内煮 15 分钟，使用时，按水罐法吸拔在需要的部位上，多用于风湿痹痛等病。常用处方：麻黄、蕲艾、羌活、独活、防风、秦艽、木瓜、川椒、生乌头、曼陀罗花、刘寄奴、乳香、没药各 6g。

（2）贮药罐：在抽气罐内事先盛贮一定的药液（约为罐具 $2/3 - 1/2$ ）然后按抽气罐操作法，抽出空气，使其吸在皮肤上。常用药液有辣椒水、生姜水、风湿酒等。常用于风湿痛、哮喘、咳嗽、感冒、溃疡病、消化不良、牛皮癣等。

药罐的操作过程较为繁琐，一般作为一种特色专科，在医生操作下使用。

3、与推拿的配合使用

在治疗一些伤骨科疾病时，推拿医生在推拿完毕后，常在一些穴位上进行拔罐，以使局部毛孔开合，起到祛风清热、通经活络的作用，用于风热感冒、筋骨疼痛等实证。或是在拔罐后，揉按局部皮肤，以使毛孔闭合，以防风寒入侵，并加快局部血液循环。用于体质虚弱、易感风寒的虚寒病证。

4、与刮痧的配合使用

刮痧法是利用一定的工具，如牛角板、木梳背、瓷调羹等，在人体某一部位的皮肤上进行刮擦，使皮肤发红充血，呈现一块和一片紫红色的斑点为止，以达到防治疾病的目的的一种疗法。

刮痧疗法与拔罐疗法同属中医的外治疗法，治疗作用也基本相同，

有着异曲同工的效果,这两种方法也可配合使用,如在某条经络或某个穴位上拔罐以前,用罐口先在这些部位进行刮痧,待局部呈现一块和一片紫红色的斑点时,再予以拔罐,以增加疗效。

五、吸拔时间

关于吸拔时间的长短,也是拔罐疗法临床应用应该注意的重要原则。那么,究竟吸拔多长时间好呢?原则上是应该根据病情的需要而定。一般来说是这样的:疼痛的疾病,需要吸拔的时间,要长一些为宜;麻痹的病证,需要吸拔的时间,要短一些为宜。如果采用兴奋手法,所用小罐的数要少,吸拔的时间要短,约10分钟;如果要采取抑制手法,用小罐的数量要多些,吸拔的时间要长,约15分钟左右。遇到病人感觉特别难受时,就可以提早起罐;如果病人感觉舒适,罐子的吸力也不很大,而且局部的肌肉又比较丰满,时间就可以长一些。体质消瘦虚弱者,罐子吸拔的力量要小,时间要短,拔罐的数量要少;体质健壮肌肉丰满者,罐子拔的力量要大,拔罐的数量要多,吸拔的时间要长。病人比较敏感,耐受能力比较强,吸拔的时间可以长一些。新接受拔罐疗法的病人,即首次接受拔罐疗法的病人,吸拔的时间要短一些;经常接受拔罐疗法的老病人,吸拔的时间可长一些。例如:坐骨神经痛,可在肾俞、大小肠俞、阳关、环跳、风市、髀骨、委中、足三里、阳陵泉等处轮流吸拔,每日或隔日吸拔一次,每次留罐15—30分钟。又例如股外侧皮神经痛,以止痛为目的,在环跳、风市、阳陵泉的穴位上吸拔,可留拔15—30分钟。

六、起罐方法及起罐后处理

关于起罐的方式方法及起罐后,拔罐当中出现情况都统一妥善处理,亦是拔罐疗法临床应用应该注意的重要原则之一。

关于起罐的方法:如果吸拔的是火罐、竹罐、药罐,在起罐时,应一手按在罐口边的肌肉上,另一只手拿住罐子稍微向一边倾斜,使罐口处(手按罐口边肌肉处的那边罐口)进入空气,当罐内负压消失,罐子就自然脱落,一拔自下。

如果吸拔的是抽气式罐子,可以用注射器插入罐子内,向罐内注入空气,待罐内负压消失,罐子也自然脱落,一拔即下。

千万不能暴力硬拔,或者快速倾斜罐子,造成被拔部位反肤与肌肉

的损伤与疼痛。拔罐疗法对病人无任何副损伤，任何由于操作不慎给患者带来不应有的损伤和疼痛，都是不对的。所以，如何正确的起罐，也该充分的注意。

拔罐当中，也有极少数患者发生休克和晕厥时，此时患者感到头晕眼花，心烦欲吐，面色苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，呼吸迫促，脉搏频数，而细小等现象，应立即将罐取下，使患者平卧床上，喝些热开水。稍重者可用针灸针刺十宣、人中，即可恢复常态。如无针灸针，可点穴指压人中也能恢复常态，继续平卧床上休息一刻钟才能离开治疗室。

拔罐以后，如果发生水疱，原因可能是与拔罐的时间过长，患的疾病是风湿、或者是水肿的患者。这不应怕，不算事故，在拔罐疗法中，有些疾病就是能吸出水疱来，应该向患者做详细、耐心的解释，发生水疱并不是坏事，有的故意采取发泡疗法。当然，不需发泡疗法的，应当是尽量避免发生水疱。如果发生水疱了，可在常规碘酒和酒精消毒后，用注射器在水疱的边缘刺入将水抽出来。然后涂以紫药水即可，不必包扎，涂上烫伤膏也可以。如果没有烫伤膏的情况下，敷以雷夫奴尔纱布，然后包扎上也可以。如果为了预防感染，或者出现了感染，可服用抗菌药物。

如果只是有的灼烫伤痕，勿须特殊处理，只涂上紫药水即可。

七、施用拔罐疗法应该注意的事项

拔罐疗法是一种无创伤性的理学刺激疗法。但是，操作不慎，粗疏大意，也可引起局部烫伤。因此，必须注意以下几点，这也是拔罐疗法临床应用应该注意的原则。

（一）选好体位和穴位

一般以肌肉丰满、皮下组织丰富、毛发稀少的部位为宜。应拔的局部皮肉须保持紧张，如有皱纹、松弛、凹凸不平、体位移动等，都容易使罐脱落。

一般不在血管浅显处、心窝处、鼻、眼、乳头和皮肤细嫩处拔罐。血管浅显处拔罐，易造成小血管破裂、出血不止。切忌在颈部两侧拔罐。鼻和眼经受不了拔罐疗法的负压刺激。乳头是内分泌最敏感的感受器官，不能承受拔罐疗法这样的强力负压刺激。皮肤嫩处施用拔罐疗法易起

水疱,造成皮肤破损。

(二) 根据不同部位和病情,选择不同质料和大小适合的罐子

如需要吸拔的部位在背、腹、胸部,可用大号罐子;如果吸拔的部位是肩部、臀部、大腿部,亦可用大号和中号的罐子;如果吸拔的部位是小腿和上肢可用中号和小号罐子;如果吸拔的部位在手、足或者是穴位,则应该选用小罐子。

一般来说,需要吸拔的部位,若是平坦、肌肉丰满、皮下脂肪比较厚,可用大罐;需要吸拔的部位,若是比较窄小,肌肉较薄、皮下脂肪较小,可用小罐;需要吸拔的部位,若是小的关节或穴位,则用小竹罐或抽气罐。

(三) 运用不同的拔罐方法,有不同的特殊注意之处:

1、如果运用投火法时,火焰要旺,动作要敏捷,拔罐时用另一只手掌挡一下罐口,或摇晃一下火罐,以免烫伤。

2、若是运用闪火法时,棉絮蘸沾的酒精不宜过多,防止滴下,造成烫伤。

3、若是运用贴棉法时,一定要防止和避免燃着的棉花脱落,掉在病人的身上,造成灼、烫伤。

4、如果运用架火法时,一定要留心,燃着的火架不能歪倒或倾斜,烧伤病人的皮肤。另外,扣火罐时,一定要准确,避免火焰扑灭,拔罐不成功。

5、用煮药罐或竹罐时,必须甩尽罐内的热药液或热水,以免烫伤皮肤。

6、运用刺络拔罐时,要掌握针刺的深浅、出血的多少。这一定要按病情而定,如果是实热证,则可深刺,并多出血,即就是所谓的“泻”法;如果是虚寒证,则可浅刺,少出点血,这为“补”法。但是,不管“泻”和“补”,都不能出血过多,若是拔后,血出如喷泉,应该立即取罐止血。

7、运用针罐时,一定要找准穴位,先行针刺,待“得气”后,再扣罩上罐子,在扣罩罐子时,决不能撞压针,以免针刺过深,造成不应有的损伤。尤其胸、背部,针刺更不能过深,如果由于不慎撞压导致针刺过深,容易产生气胸。这在实际操作过程中,并不是没发生过的,应该引起借

鉴。

8、在使用多罐时拔的罐子不宜过密，以免相互牵拉，引起疼痛，同时相互排挤，不易拔牢。但是，也不能过稀。只要是选择多罐丛拔法，就是病情需要大面积，而且是强力负压刺激，若是过于稀疏，也会影响疗效。一般来说，密排法，罐距不超过1寸（同身寸法），适用于体壮而有疼痛者；疏排法，罐距在2寸以上，适用于体弱者。

9、在运用走罐（推罐）时，不能在骨突出处或小关节处、皮肤有皴裂、细嫩之处，以免损伤皮肤，或使吸拔的罐子漏气脱落。

八、拔罐治疗时应注意观察患者局部和全身反应

1、拔上火罐之后，须询问病人感觉怎样，如有发热、发紧、凉气外出、温暖、舒适等感觉时，都属于正常现象，可以继续吸拔治疗。

2、如果病人感觉紧、灼痛、难受，或此处不舒适，应该立刻起罐，而另外选择附近肌肉较多地方，再重新进行吸拔，或改用较小的罐子多拔几次，这就是连续吸拔法，如拔上罐子之后，病人觉得罐子吸拔得不紧，说明吸拔力量不够。可以起罐或改用较大的罐子，再重新吸拔，否则也会影响疗效。

3、如果病人连续几天都来接受拔罐疗法，应该注意轮换位置。为了针对病因和病情，可以在同一经络腧穴上选不同位置，并且有同样疗效的穴位。例如拔罐疗法治疗咳嗽。咳嗽为呼吸系统疾病的主要证候。常见于呼吸道感染（包括上呼吸道感染和支气管炎）、支气管扩张、各种肺炎、肺结核等。

7、如果施用走罐（推罐）或刺络拔罐法，则在上背部、脊柱两侧，每隔2—3天，左右交替进行。

九、拔罐前的准备工作

（一）做好器材准备

1、如果用火罐疗法，就选择口径大小不等的火罐足够用的个数；备好酒精和棉球；准备好火柴或酒精灯、油灯、蜡烛；长镊子两把；肥皂、毛巾、面盆。

2、如果用水罐或药罐疗法，就选择口径大小不等的竹罐数十个，中药、铝锅、电炉或火炉、毛巾、大镊子和需要用的足够量的药液。

(二) 给患者解释清楚,摆好体位。

有人主张拔罐疗法不必分疗程,常常拔两三次,甚至拔一次疾病就能治愈。一般的慢性病,也不要天天拔,以隔天拔1次,或2—3天拔1次为妥。至于急性或危重病,应当赶紧选用其他疗法,以免耽误。也有人主张,急性病应该每天拔罐治疗一次,慢性病应该隔天拔罐治疗一次,连续治疗10—15次为一个疗程。

十、适应症与禁忌症

(一) 适应症

拔罐的适应症,早已从早期的疮疡发展到用于内、外、妇、儿等各种病症,已经能治疗一般常见病、多发病达百种之多。特别是近年来,一些从未用本法治疗过的疾病如白塞氏症、术后腹胀等,以及一些疑难急症如老年性慢性支气管炎、肺水肿,甚至如心脏病、骨折、银屑病等,使用本法也取得意想不到的效果。根据临床观察,本法对高血压、心绞痛亦有明显疗效。另外用本法治疗效果较理想的病症有:感冒、流行性腮腺炎、哮喘、支气管炎、百日咳、冠心病、心律不齐、中暑、肺水肿、急性胃肠炎、胃痛、小儿消化不良、高血压、中风后遗症、糖尿病、头痛、肋痛、神经痛、肌肉痛、关节痛、腰背痛、痛经、月经不调、乳腺炎、术后肠粘连、荨麻疹、带状疱疹、产后缺乳、牙痛、扁桃体炎、面瘫、毒蛇咬伤、疮疹初起、近视等。

(二) 禁忌症

- 1、孕妇、危重病人及严重心脏病者不宜拔罐。
- 2、过度体虚,过度疲劳、饥饿或刚结束剧烈运动者不宜拔罐。
- 3、皮肤有损坏处不宜拔罐。
- 4、血液病,有出血倾向者不宜拔罐。正在出血的部位不宜拔罐。
- 5、眼、鼻、二阴不可直接拔罐。

第四章 拔罐在诊病中的应用

通过临床观察,拔罐不仅对一些疾病有良好治疗效果,而且在诊断疾病中也有重要的作用。下面予以简单介绍:

1、对散发斑疹的早期诊断

在拔罐处,如有微细出血的现象,即证明毛细血管已经发生变化,这种变化的原因,可能是麻疹、风疹、猩红热、斑疹伤寒等疾病引起的。这些病症在未发作前 4、5 天,用拔罐吸拔后,发现在皮肤上有些出血,而且呈紫块相重叠着,这就是将要发斑疹的病据。

2、对水肿的早期诊断

如果患心脏病、肾脏病、肝脏病、内分泌系统疾病,都可能发生水肿,除此之外,某些寄生虫病、营养不良也可能发生水肿。是否有水肿,标志着疾病的严重程度。有时水肿难以鉴别,特别是肉眼很难发现,这时,为了搞清楚是否有水肿,可以用罐子吸拔,起罐后如果发现病者的皮肤上呈现很多小水泡,这就证明病者确有水肿病。通过此法,来证实是否有水肿,从而判断疾病是处于什么阶段,以便制定治疗措施。

3、对疾病的鉴别诊断

神经痛或高血压等症状的病人经过拔罐治疗后,拔罐部位皮肤呈现粉红或红色。如果肌肉风湿症和类风湿性关节炎病人,施行拔罐,拔罐部位的皮肤多呈现紫红色,并且在紫红色中间常出现黑褐色斑纹。根据此种现象,可以帮助诊断和鉴别诊断。

4、判断疾病的轻重程度及转归

肌肉风湿症和类风湿性关节炎患者在拔罐治疗过程中,皮肤所呈现的颜色和斑纹逐渐减少,就证明此病患者的症状减轻,而且此时,患者也感觉疼痛和关节活动情况逐渐好转;如果在拔罐部位皮肤所呈现的颜色和斑纹在逐渐增多增重,说明此类疾病的病情在转重。因此,通过拔罐可以判断病情好转或恶化。

5、用于虚实辨证

有人治疗 150 例以疼痛为主的风湿、类风湿性关节炎和腰肌劳损、肩周炎、急性腰扭伤、颈椎病,根据舌、脉、症状,辨证为虚、实证,以同样

方法在肩、背、腰、四肢肌肉丰厚处拔罐。结果显示:实证在疼痛部位首次拔罐后,皮肤呈深紫色,经治疗后,疼痛减轻,拔罐部位肤色变浅;虚证在疼痛部位首次拔罐后,皮肤呈浅红色,经治疗后,疼痛,皮肤色仍同首次拔罐一样,并可见局部皮肤有压痕。此提示上述病拔罐治疗实证效果好,虚证效果差。为这些疾病治疗方法的选择,提供了依据。

第五章 常见病的治疗

一、内科疾病

1. 感冒

感冒是以恶寒、发热、鼻塞、喷嚏、流涕、咳嗽、头痛、全身不适为主要症状的一种外感病。轻者俗称“伤风”，一年四季都可发病，但以春、冬两季气候骤变时为多。体质虚弱者常易感冒。

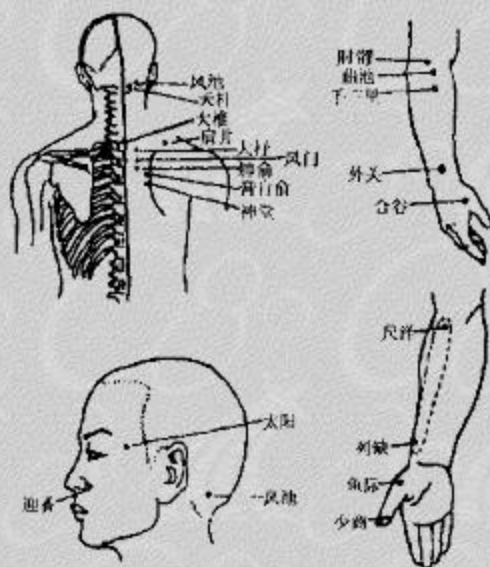
【施治部位】

大椎、风池、大杼、风门、膏肓、神堂、合谷、列缺。

鼻塞加拔迎香穴。

头痛加拔太阳穴。

咽痛加拔曲池、外关穴。(见图1)



(图1)

操作方法1：可据症选穴5—6个，每穴拔10—20分钟。

操作方法2：用走罐法，沿督脉、足太阳膀胱经（背部）走罐，直到皮肤潮红为宜。将罐推至大椎、风门、膏肓穴停罐拔3—5分钟起罐。

为提高疗效可配合法1或法2，用罐口刮手太阴肺经、手阳明大肠经，重点刮曲池、外关、鱼际，以出痧为佳。

1）除任、督两脉上的穴位外，其余十二经上的穴位均为双数，比如合谷，左右手上各有一个，其余各穴不一一注解，请用户注意。

2）对面部不宜用重手法，防止损伤面部。

3）用走罐法或用罐口刮痧时应涂些拔罐油，既可以使操作顺手，也可有助于疗效。

2、咳嗽

咳嗽是呼吸系统疾病的主要症状之一，有急性和慢性之分。前者为外感，后者为内伤。外感咳嗽是由风寒、风热之邪，从口鼻、皮毛而入，肺合皮毛，开窍于鼻，肺卫受邪，于是肺气壅遏不宣、肺失清肃、发为咳嗽；内伤咳嗽，多因咳嗽反复发作，肺气久伤，肺虚及脾，脾虚生湿，聚湿为痰，湿痰上渍于肺，肺气不降；或因肝气郁结，久而化火，火盛灼肺，气失清肃，均可导致咳嗽。

咳嗽常见于呼吸道感染、急慢性支气管炎、支气管扩张、肺结核等病。

拔拭足太阳、手太阴、手太阴经穴部位为主。

【施治部位】

大椎、大杼至肺俞、膏肓、神堂。

列缺至尺泽。

恶寒加拔合谷、风池经穴部位。

痰多加拔丰隆、太渊经穴部位。

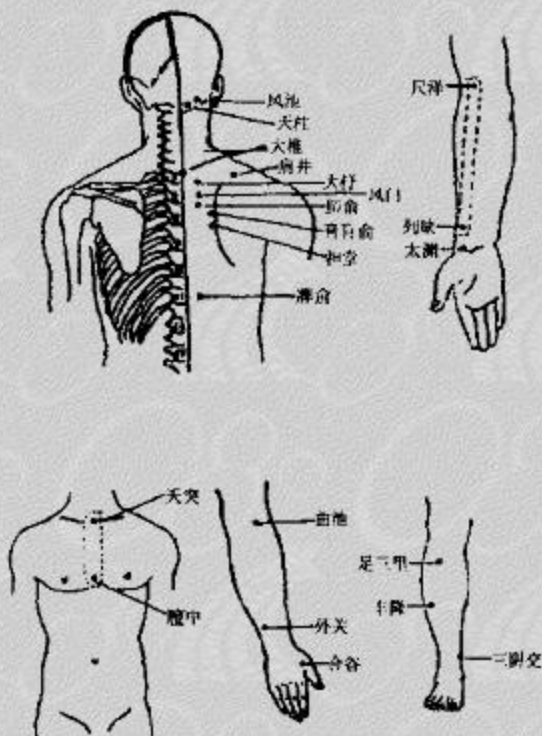
胸闷加拔天突至膻中经穴部位。

发热加拔曲池至外关经穴部位。

脾虚加拔脾俞、三阴交经穴部位。（见图2）

3、哮喘

哮喘是一种反复发作的疾病，呼吸急促，喉常有哮鸣声。哮喘，通俗称“气喘”或“吼痰”，伴有阵发性呼吸困难等症状。哮与喘是两种不同的



(图2)

症状,呼吸急促者谓之喘,喉中有声音者谓之哮。本病一年四季均可发病,尤其在寒冷季节及气候急剧变化时突然发作。先干咳,喉中哮鸣,呼吸困难,张口抬肩,不能平卧,双目肿胀,痛苦难忍。有的发作后几分钟缓解,有的持续几天不停,多反复发作。男女老少均有患此病者。

【施治部位】

大椎、定喘、大杼、风门、肺俞、天突、膻中、丰隆。

风寒外束加拔尺泽、列缺。

痰热壅肺加拔合谷、鱼际。(见图3)

操作方法1:可从以上穴位中选3~6穴(可交替使用)。以留罐法

4. 支气管炎

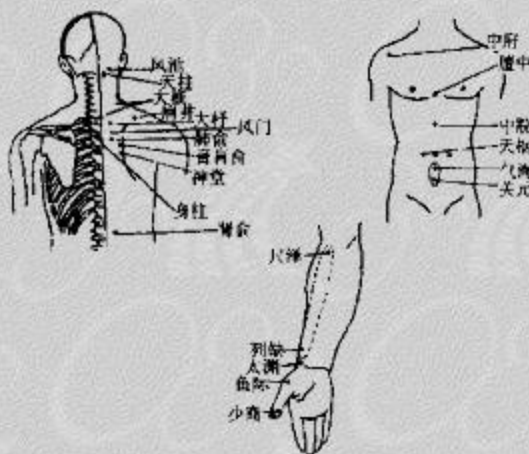
支气管炎有急、慢性之分，它们均是由病毒或细菌感染或因物理、化学刺激及过敏等所引起的炎症性疾病。急性者起病常有上呼吸道感染症状，如：鼻塞、喷嚏、咽痛、头痛、畏寒发热等，其主要临床表现为咳嗽伴胸骨后疼痛。慢性者病程缓慢，主要表现为咳嗽、咳痰，甚至哮喘。尤以晨起明显，痰呈白色粘液泡沫状，不易咳出。

【施治部位】

(急性期)：大椎、风门、肺俞、身柱；膻中、中府。

(慢性期)：大椎、风门、肺俞、身柱；膻中、中府、尺泽、太渊、肾俞。

(见图 4)



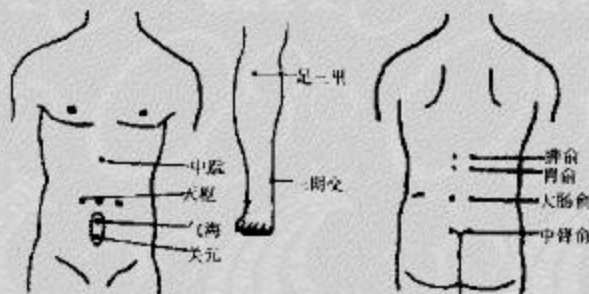
(图 4)

5. 消化不良

消化不良，是消化系统本身的疾病或其它疾病所引起的消化机能紊乱症候群。多因暴饮暴食，时饥时饱，偏食辛辣、肥甘或过冷、过热、过硬之食物所致。主要表现为腹胀不适、嗝气、恶心呕吐、食欲不振、腹泻或便秘、完谷不化等。

【施治部位】

脾俞、胃俞、中脘、天枢、足三里、三阴交。（见图 5）



（图 5）

在拔罐治疗的同时，应注意饮食有节，不可过饱，忌肥甘厚味及苦寒之物。

6、胃痛

胃痛，又称胃脘痛。常反复发作，常痛及心窝，古称“心痛”或“心下痛”，应与真心痛区别。

【施治部位】

大椎、膏肓、神堂、大杼、足三里、中脘。

肝气犯胃加拔太冲、期门。

脾胃虚弱加拔脾俞、胃俞、章门。（见图 6）

操作方法 1：可从上列穴中选取 3—6 个穴位，用留罐法拔 10—20 分钟。

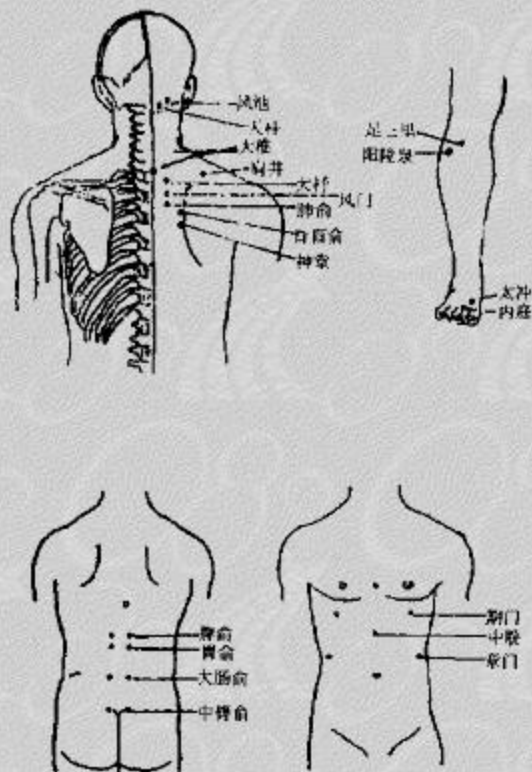
操作方法 2：沿足太阳膀胱经、足阳明胃经，手厥阴心包经肌肉丰满处用走罐法，以皮肤潮红为度。

注意事项：用走罐法应在施术部位涂拔罐油。

7、胃炎

胃炎一般分为浅表性、萎缩性及肥厚性 3 种，是以胃粘膜的非特异性慢性炎症为主要病理变化的胃病。

本病属祖国医学的“胃脘痛”范畴，其病因病机为饮食或情志所伤，



(图 6)

使脾不健运,胃失和降而致。

【施治部位】

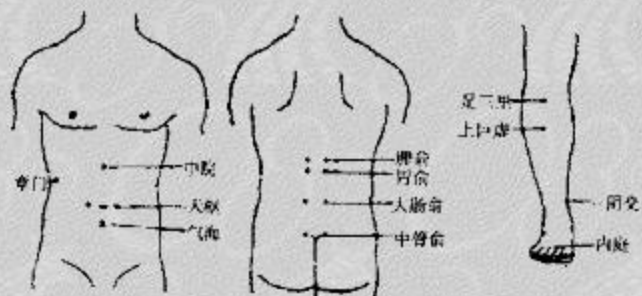
脾俞、胃俞、中脘、章门、气海、足三里。(见图 7)

8、肠炎

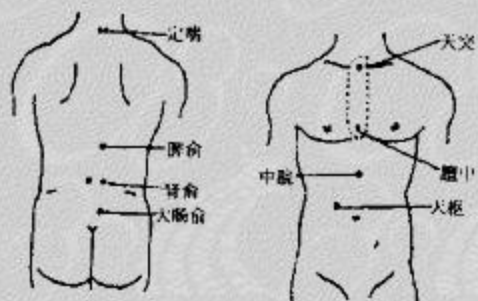
肠炎是指各种原因引起的急性或慢性肠壁粘膜的炎症性病变,临床上分为急性肠炎和慢性肠炎。

【施治部位】

天枢、中脘、足三里、大肠俞、脾俞。(见图 8)



(图 7)



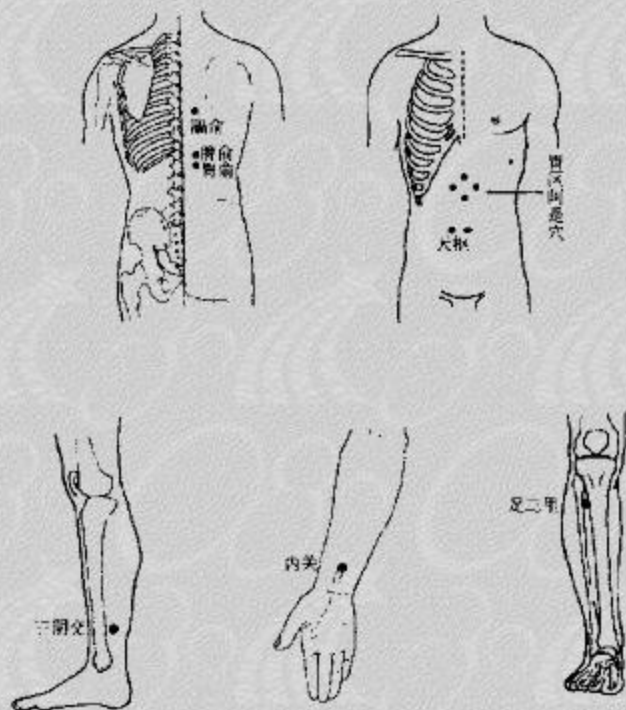
(图 8)

9、消化性溃疡

消化性溃疡是指发生于胃肠道与胃液接触部的慢性溃疡,由于溃疡发生多在胃和十二指肠,而且其形成和发展均与胃酸、胃蛋白酶的消化作用密切相关,故又称为胃、十二指肠溃疡。本病发病率很高,多发生于青壮年,男性多于女性。

【施治部位】

胃俞、脾俞、内关、足三里。(见图9)



(图9)

10、腹痛

腹痛是指脘腹和小腹部的疼痛,可伴发于多种脏腑疾患。拔拭任

脉、足阳明、足太阴经穴部位为主。

【施治部位】

大椎、大杼、膏肓、神堂、中脘、天枢、足三里。（见图 10）

寒邪内积加拔关元至气海经穴部位。

脾阳不振加拔脾俞至胃俞经穴部位。

食滞加拔里内庭穴部位。

少腹痛甚加拔三阴交穴部位。

11. 呕吐

古人云：有声无物为呕，有物无声为吐，二者同时皆有谓之呕吐。这是最常见症状，用拔罐治疗此症疗效显著。

【施治部位】

大椎、肩井、足三里、中脘、天突、地仓。（见图 11）

12. 腹泻

腹泻又称泄泻，大便次数多且质稀薄，或成水样，急性泄泻多为进食生冷不洁之物所致，慢性多因脾胃素弱，或肾阴不振，命门火衰，不能腐熟水谷而导致。

【施治部位】

大椎、膏肓、神堂、脾俞、命门、关元、肾俞、中脘、天枢、足三里、上巨虚、阴陵泉。（见图 12）

操作方法 1：可自上列穴中选取 3—6 个穴位，以留罐法拔 10—20 分钟。

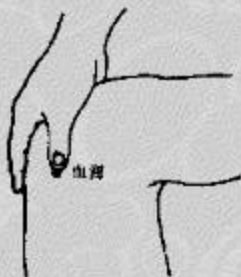
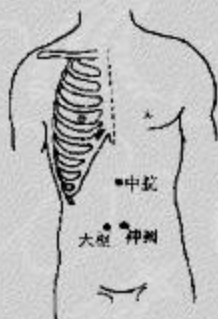
操作方法 2：体虚者可从上述穴位中选 3—6 个穴位，用闪罐法进行治疗。

操作方法 3：沿足阳明胃经、足太阳膀胱经、足太阴脾经的肌肉丰满处施行走罐法治疗，每次 3—4 分钟，至皮肤潮红为度。为提高疗效，可配合法 1、法 2 或法 3 用小号罐口刮手阳明大肠经曲池至合谷段经穴部位，以出痧为宜。

13. 便秘

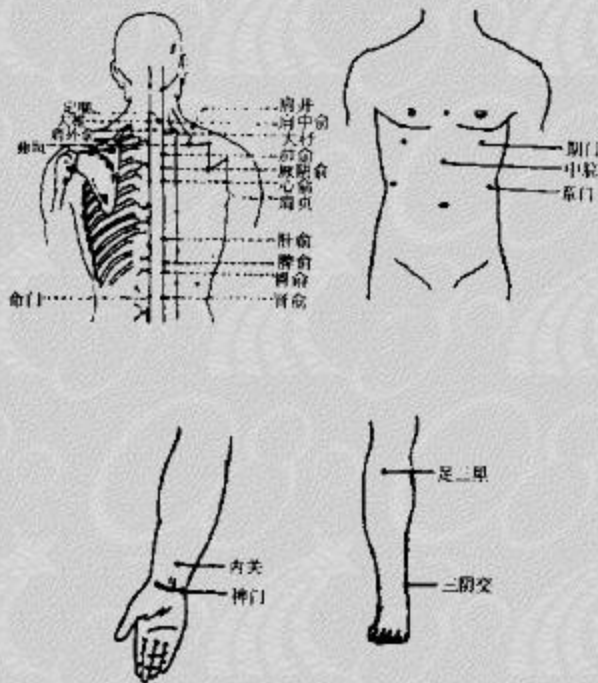
便秘为中老年人常见病，大便秘结不通超过两天以上者即为便秘。

【施治部位】



(图 10)

大椎、大杼、膏肓、神堂、大肠俞、天枢、上巨虚、支沟。(见图 13)



(图 11)

热结加拔曲池、合谷。

气滞加拔中脘、行间。

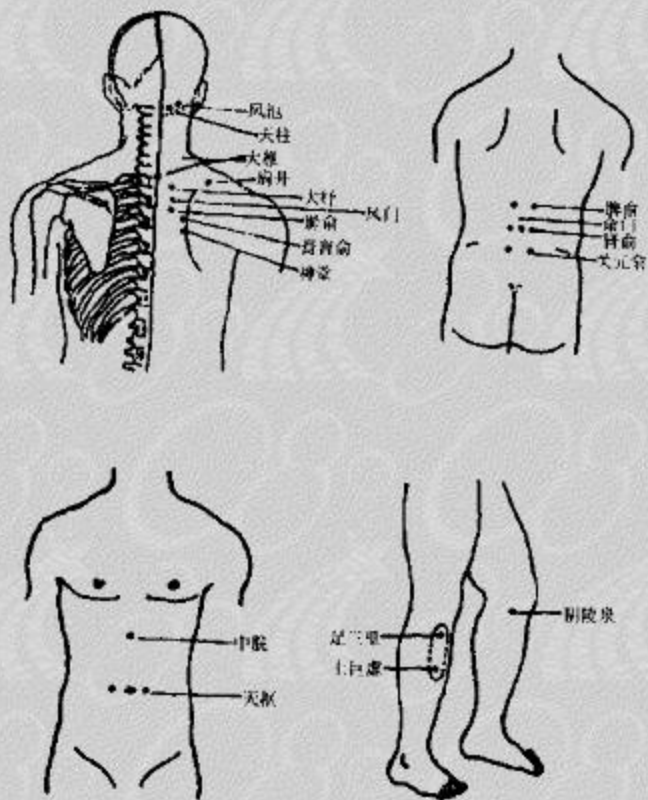
气血亏虚加拔脾俞、胃俞、大肠俞、中脘俞。

下元虚弱加拔气海、关元。

操作方法 1：自上列穴位中选取 5—7 个穴，用留罐法拔 10—20 分钟。

操作方法 2：用走罐法，沿足太阳膀胱经（背部）、足阳明胃经肌肉丰满处用走罐法，以皮肤潮红为度。走罐后应在脾俞、胃俞、大肠俞停 5 分钟后起罐。

注意：走罐应涂拔罐油。



(图 12)

14、头痛

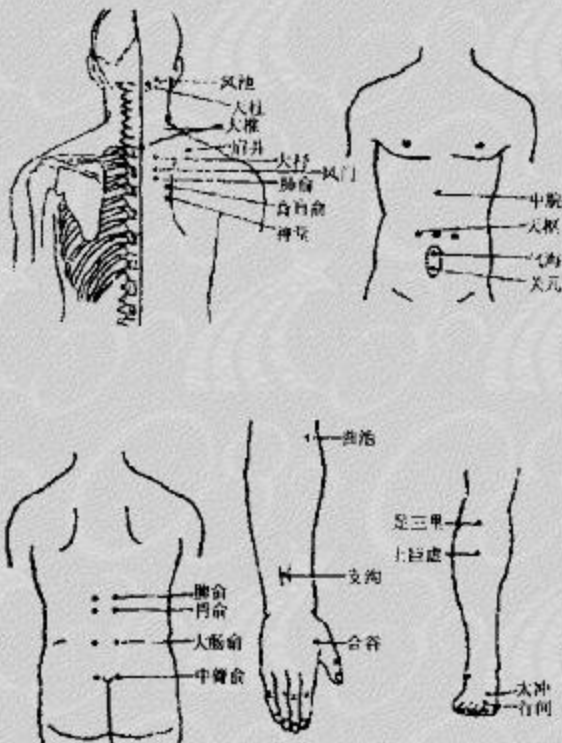
头痛是一种症状,多种疾病都可出现头痛,如感冒、高血压、颈椎病、神经衰弱等。

根据头痛部位的不同,可区分为:前头痛属阳明头痛,后头痛属太阳头痛,头顶痛属厥阴头痛,两侧头痛属少阳头痛。

【施治部位】

大椎、大杼、膏肓、神堂。(见图 14)

前头痛加拔关隘、阳白、印堂、合谷。



(图 13)

后头痛加拔督脉(走罐)。

偏头痛加拔丝竹空、太阳。

头顶痛加拔督脉走罐和太冲、行间。

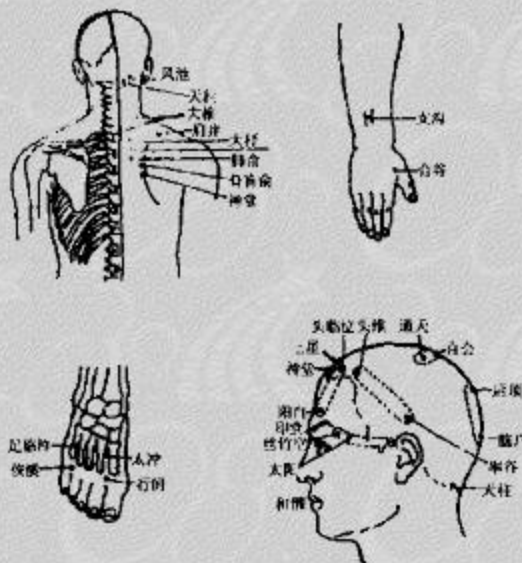
操作方法:可据头痛部位选取相应穴位,用留罐法拔 10—20 分钟。

15、失眠

失眠,多见于神经衰弱或贫血等病。常因思虑忧愁,操劳过度,气血亏虚,心神失养,或房劳太过。肾亏损或恼怒伤肝,心神不宁所致。

【施治部位】

天柱、魄户、膏肓、神堂、内关、神门、三阴交。(见图 15)



(图 14)

心脾亏损加拔心俞、脾俞。

心肾不交加拔心俞、肾俞、太溪。

肝火上炎加拔行间、太冲。

操作方法 1: 从上述穴位选取 5—7 个, 用留罐法拔 10—20 分钟, 每天一次。

操作方法 2: 用走罐法沿足太阳膀胱经走罐, 至皮肤潮红为度, 用罐口刮痧手少阴心经(双侧)3—5 分钟, 至潮红为度。

16、眩晕

眩晕是指病人自觉头昏眼花, 视物旋转翻复, 常伴有恶心、呕吐、胸闷、出汗等症。

本症可见于高血压病、动脉硬化、内耳性眩晕、贫血、神经官能症等。

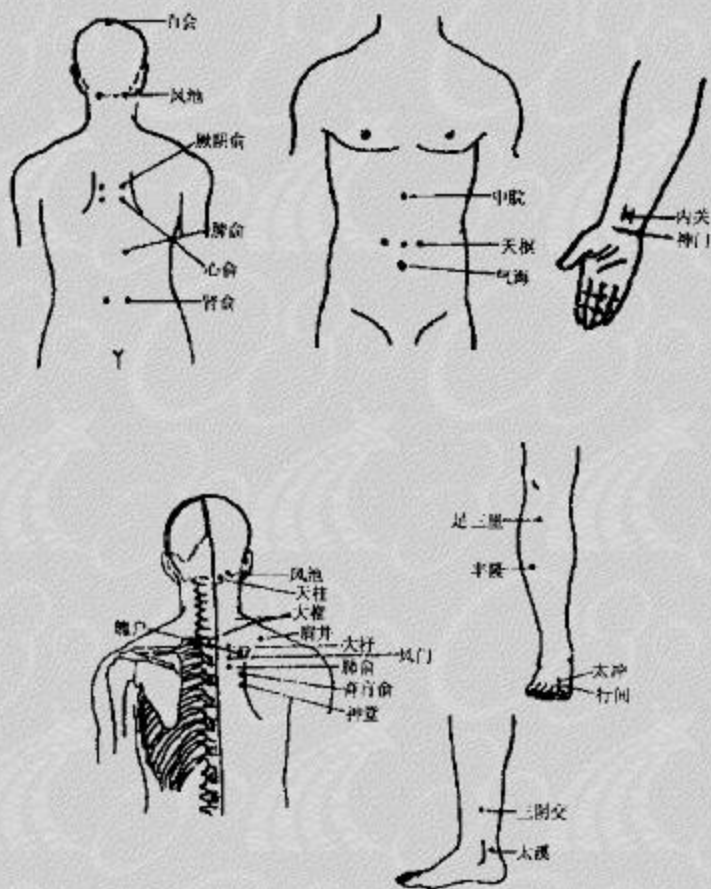
拔督脉、足太阳、足阳明、足少阳经穴部位为主。

【施治部位】

大椎、大杼、膏肓、肩井。

百会、风池、头维至率谷、足三里、太冲。

气血不足加拔脾俞、气海穴部位。

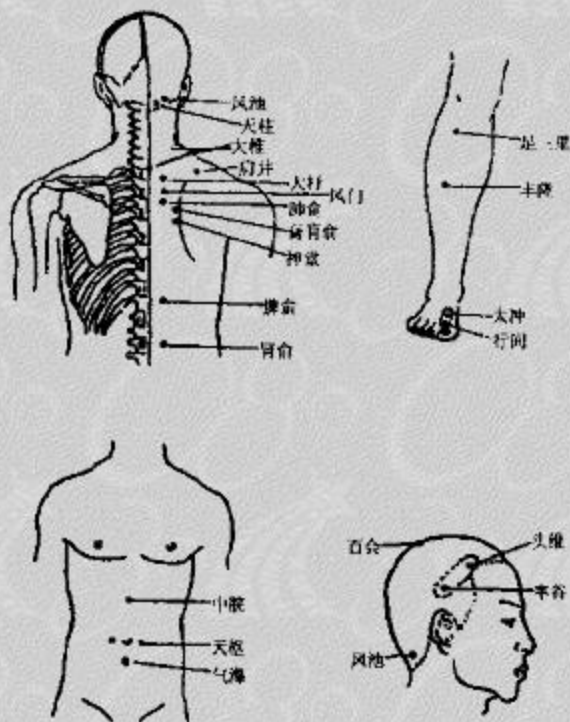


(图 15)

肾阴虚加拔肾俞穴部位。

肝阳偏亢加拔行间穴部位。

痰湿中阻加拔丰隆穴部位。(见图 16)



(图 16)

17、健忘

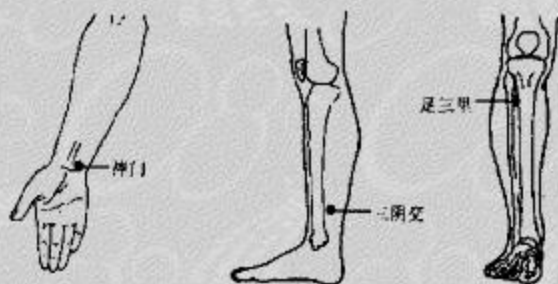
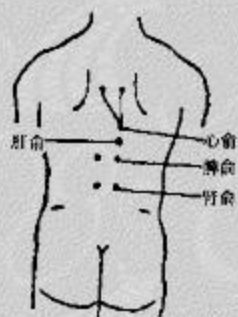
健忘使一些中小学生在 学习时注意力集中不起来,成绩下降,原因是学习负担过重,精神压力太大,以致记忆力衰退。

【施治部位】

神门、三阴交、足三里、心俞、肾俞。(见图 17)

18、疲劳

精力旺盛的人才能把工作干得有声有色。如果精力不支,疲劳不



(图 17)

堪,那必定是学习、工作、家庭生活等负担过重所引起的。特别是人到中年、老年,精力衰退更是无可奈何的事。

【施治部位】

大椎、心俞、肝俞、神门、三阴交。(见图 18)

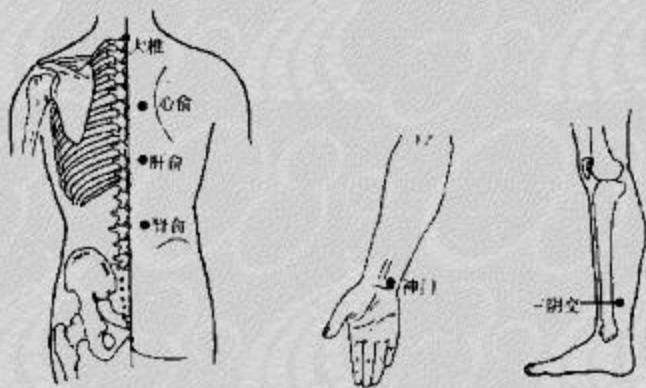
19、冠心病

冠心病又称冠状动脉粥样硬化性心脏病,即冠状动脉粥样硬化导致心肌缺血、缺氧而引起的心脏病。以心绞痛、心肌梗塞为常见冠心病,发病率自 40 岁开始增多,50 岁以上者则发病更多。

【施治部位】

内关、人迎、足三里、手三里、三阴交。(见图 19-1)

内关、中腕、足三里、巨阙、太溪。(见图 19-2)



(图 18)

注意事项:对病情较重及心肌梗塞的危重病应采取中西医结合治疗,在适当观察护理下配合拔罐穴位治疗。

20、风湿性心脏病

慢性风湿性心脏病,是指急性风湿性心脏病遗留下来的心瓣膜病变,病变部位以二尖瓣和主动脉瓣最为多见,形成瓣膜的狭窄或关闭不全,导致心功能代偿不全、心脏增大或充血性心力衰竭。

【施治部位】

内关、外关、人迎、三阴交。

配穴:心俞、厥阴俞、血海、委中。

心悸者加膻中;房颤者加间使、夹脊(胸4—5夹脊);呼吸困难者加肺俞。

心动过速者加厥阴俞、手三里,心动过缓加通里、内关,有风湿活动者加大椎。(见图20)

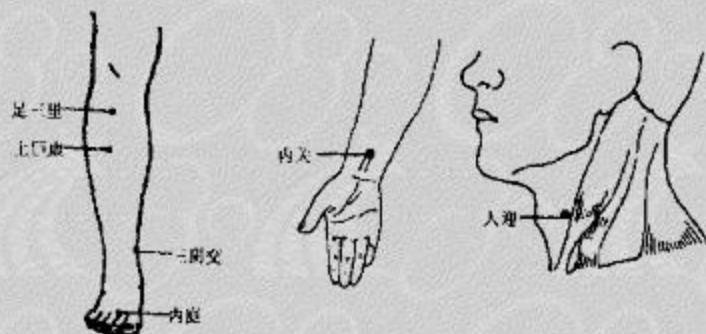
21、病毒性心肌炎

病毒性心肌炎是指外感病毒侵犯心脏后,引起心肌细胞变性坏死或心肌间质性改变的一种疾病。临床表现不尽相同,轻者无明显症状,或见神疲乏力、气短、胸闷,重者心悸、怔忡、头晕、四肢厥冷、面色苍白或发绀、唇指青紫、血压下降。重症应及时到医院救治。

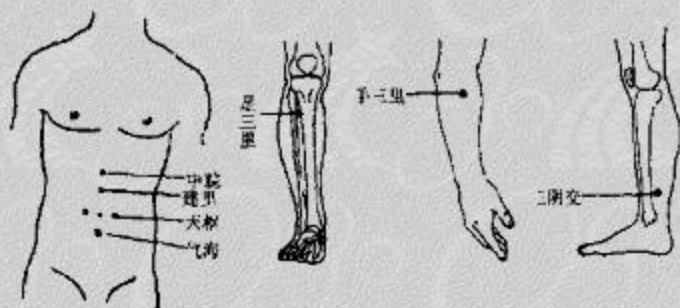
【施治部位】

主穴：内关、外关、足三里。

配穴：俞府、膻中、厥阴俞、心俞、三阴交。（见图 21）



(图 19-1)



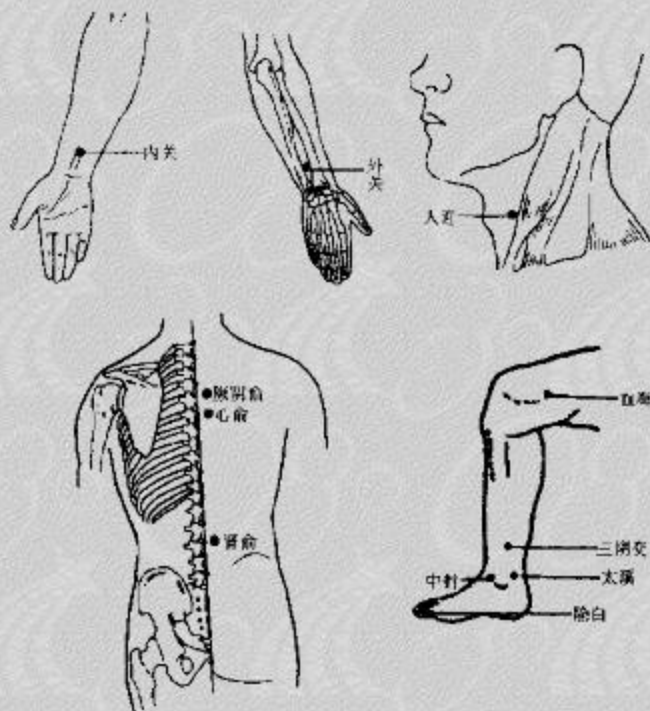
(图 19-2)

22、心律失常

心律失常又称心律不齐、心律紊乱。常见的有窦性心律不齐、心动过速、心动过缓、早搏、房颤等。可由植物神经功能失调、冠心病、心肌炎、风湿病等引起。

【施治部位】

心俞、肾俞、内关、外关、三阴交。（见图 22）



(图 20)

23、高血压

高血压又称原发性高血压,是指血压高于正常范围的一种疾病,成人正常血压为:18.6/12 千帕(140/90mm Hg)。主要因体循环动脉压升高产生的症候群:头痛、头晕、头胀、耳鸣、面红、失眠、重者可发生头重脚轻,视力减退,心悸、气短、健忘、甚至中风。

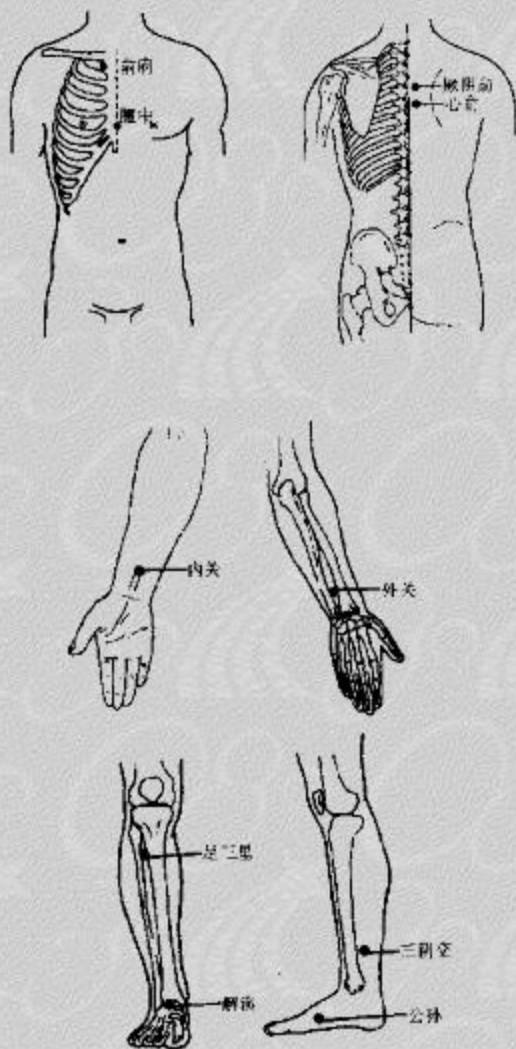
【施治部位】

肝俞、肾俞、关元俞、曲池、风池。

肝火旺盛型加拔太阳、风府。

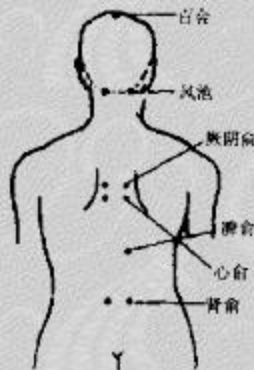
阴虚阳亢型加拔三阴交、太冲。

肾精不足加拔关元、太溪。(见图 23)



(图 21)

操作方法 1: 依症选穴 4-6 个, 用留罐法, 每穴拔 10-20 分钟。



(图 22)

操作方法 2: 走罐法, 循督脉(颈部到腰骶)及膀胱经走罐, 以皮肤潮红为度。

24、低血压症

一般成人血压在 14.6/9.3 千帕(110/70mmHg)以下者, 称低血压。多数低血压者并无明显症状, 但部分患者可出现头晕、头痛、心前区不适、疲乏、心慌、胸闷、气短, 重者出现昏厥。尤其在体位较大变化时出现, 如突然站立时, 眼前发黑, 头晕欲倒, 需要采取治疗以防病情加重。

【施治部位】

脾俞、足三里、三阴交、内关、肾俞、膈俞。(见图 24)

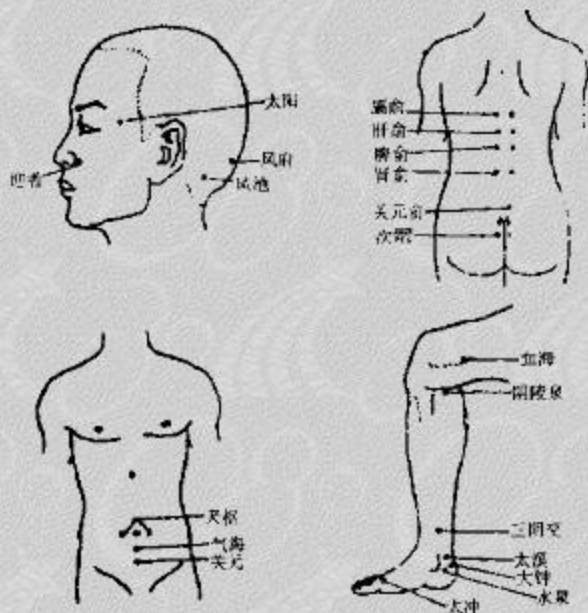
25、贫血

因不同原因, 导致血液生成减少或丢失过多而出现面色萎黄, 精神萎靡, 唇色浅淡, 自汗、盗汗, 毛发枯黄, 甚至有脱落症状者, 称为贫血症, 属中医虚劳、虚损范围。男性红细胞计数低于 450 万/mm³, 血红蛋白低于 12g/100ml, 女性红细胞计数低于 350 万/mm³, 血红蛋白低于 11g/100ml, 均为贫血症。

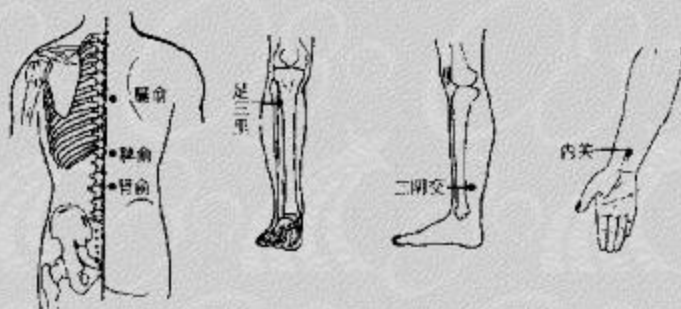
【施治部位】

脾俞、膏肓、气海、血海、足三里, 以补脾健胃, 益气养血。(见图 25)

26、高脂血症

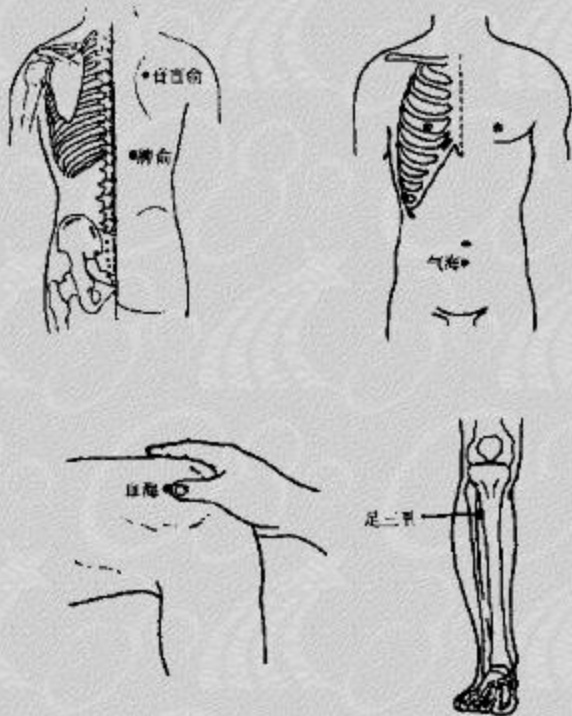


(图 23)



(图 24)

血浆胆固醇和甘油三脂的含量,40岁以下者分别高于180mg/100ml和110mg/100ml,40岁以上者分别高于220mg/100ml和



(图 25)

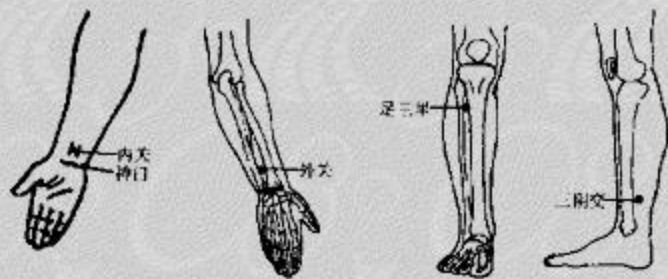
160mg/100ml 者,均为血脂偏高。血脂高有家族性倾向,可能与遗传有关,但大多数患者是由于生活水平提高,摄食高脂肪、高蛋白、高胆固醇食物造成的。临床表现为头晕、疲劳,有的困倦失神,现代医学视其为引发冠心病的三高症之一。高脂血症血粘稠度高,多造成血流减慢,使胆固醇类物质容易附着在血管壁上,形成粥样动脉硬化,甚至导致血管栓塞。

【施治部位】

内关、外关、足三里、三阴交。(见图 26)

27、白血病

白血病,被认为是造血系统恶性肿瘤,属白细胞造血系统的恶性病

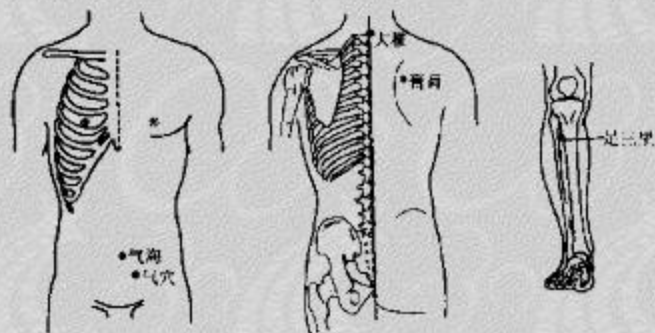


(图 26)

变。临床上出现发热、贫血、肝脾肿大、淋巴结肿大等主要症状。有急性、慢性两大类，急性白血病多见于儿童及青年，慢性白血病多发于中老年。中医属“血证”、“虚劳”等范围，为血病中的重症、危症。拔罐疗法用以补益气血，扶正祛邪，提高人体抵抗能力，并帮助改善生血生精的能力，配合输血及中西医药物综合施治。

【施治部位】

气海、气穴、膏肓、大椎、足三里、心俞、肾俞。(见图 27)



(图 27)

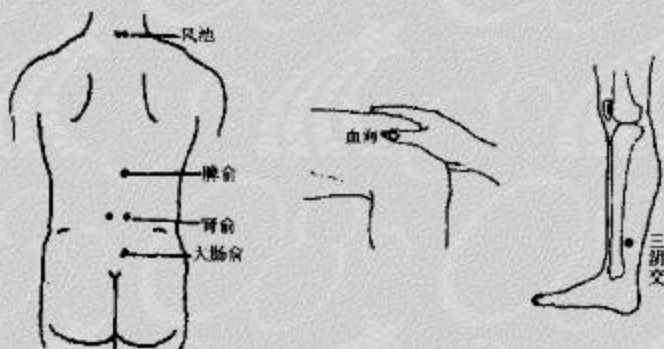
28、血小板减少性紫癜

血小板减少性紫癜是临床上常见的一种出血性疾病，临床表现为

皮肤、粘膜瘀血和瘀斑，血小板减少，出血时间延长。分原发性和继发性两类，多发于儿童及青年，女性多于男性，中医归属“血证”、“紫斑”等范围。在使用拔罐疗法治疗血小板减少性紫癜时，拔罐的力度宜轻，留罐时间宜短。

【施治部位】

肺俞、脾俞、血海、三阴交。（见图 28）



（图 28）

29、中风后遗症

中风后遗症是脑血管疾病如脑出血、脑血栓的后遗症，主要表现为肢瘫、痴呆、失语、口眼歪斜等症。

（1）口眼歪斜、语言不利、半身不遂。

【施治部位】

内关、外关、廉泉、人迎、天鼎、阿是穴。（见图 29-1）

（2）中风后上肢不遂

【施治部位】

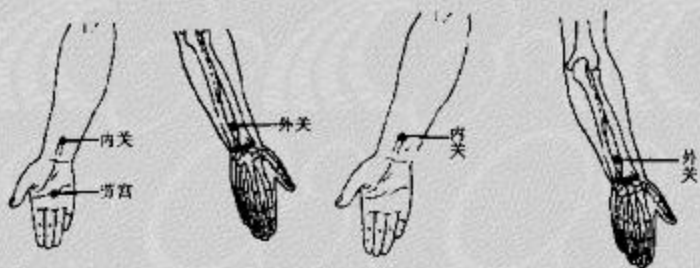
尺泽、合谷、曲池、外关、阿是穴。（见图 29-2）

（3）中风后下肢不遂

【施治部位】

委中、阳陵泉、三阴交、昆仑、阿是穴。（见图 29-3）

30、面瘫



(图 29-1)



(图 29-2)



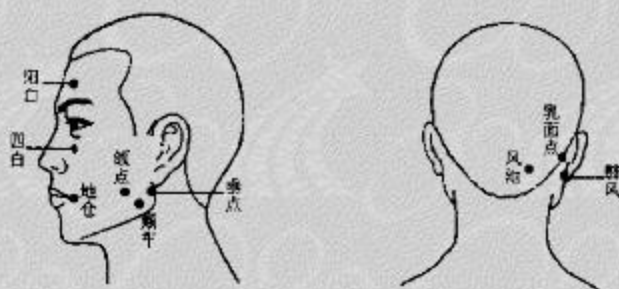
(图 29-3)

又称面神经麻痹。起病突然，每在睡眠醒来时发现一侧面部板滞，

麻木、松弛，口角向健侧歪斜，患侧额纹消失，鼻唇沟平坦，眼睑闭合不全。

【施治部位】

大椎、风池、肩井、翳风、大杼、膏肓、神堂、阳白、太阳、四白、地仓、颊车、合谷。（见图 30-1）



（图 30-1）

操作方法 1：从上述穴中选取 4—6 穴，用留罐法拔 10—20 分钟。每天一次，穴位要交替使用。

操作方法 2：循足阳明胃经走罐至潮红；用罐口刮痧手阳明大肠至潮红。

面神经麻痹

面神经麻痹分为周围性与中枢两种。

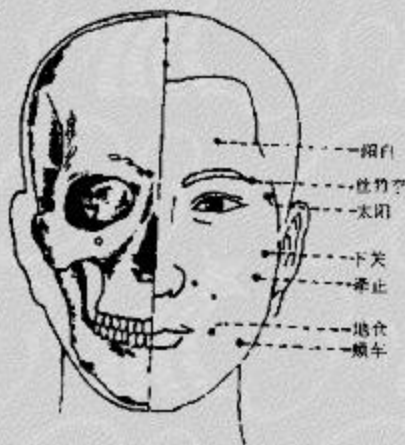
【施治部位】（见图 30-2）

方法 1：取穴：地仓、颊车、下关、牵正、阳白、风池，均取患侧，采用单纯罐法，或刺络拔罐法。每日或隔日 1 次，5 次为 1 疗程。

方法 2：用面饼贴于患侧面颊拔罐 10—20 分钟，配合梅花针叩刺地仓、颊车、水沟、承浆等穴。每日 1 次，10 次为一疗程。

方法 3：取穴：下关穴直下 1 寸处，地仓、太阳、印堂、风池。用三棱针点刺出血，拔罐 5—10 分钟，每次取 3 穴，日 1 次，3 次为一疗程。

方法 4：取穴：阳穴、下关、地仓、颊车、大椎。用闪罐法，每穴闪拔 20—30 下（夏季可减为 10—15 下）。其闪罐顺序为先取额部，次取而



(图 30-2)

部，再取口角部，最大取大椎穴。每日 1 次。

方法 5：取穴：患侧颊车、地仓、下关、阳白。用闪火法拔 10 分钟，起罐后外敷马钱子粉 0.2g 或蓖麻子仁（捣烂）如绿豆大小，外用胶布固定，隔 3 天治疗 1 次。

31、三叉神经痛

三叉神经痛是第三颅神经分支范围内反复出现阵发性、短暂、闪电样、刀割样、火灼样疼痛，无感觉缺失等神经功能障碍，检查无异常的一种病症。

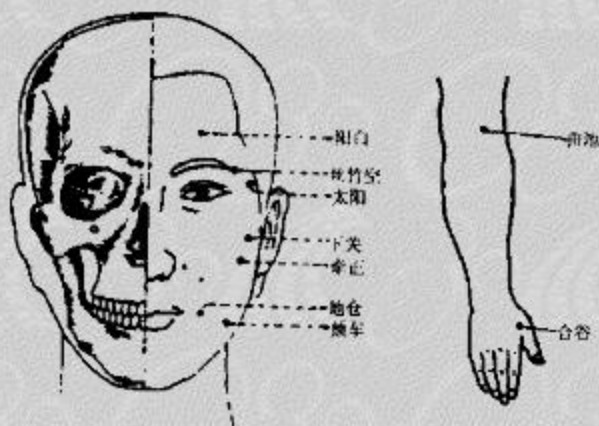
【施治部位】

丝竹空、阳白、太阳、合谷、颊车。可采用单纯罐法。风寒阻络者也可用闪罐法；风热阻络、肝火上逆者还可用刺络拔罐法；气虚血瘀者可用留针拔法。留罐 10—15 分钟，每日 1 次，10 次为 1 疗程。（见图 31）

32、神经衰弱

神经衰弱是神经官能症中最常见病症之一，多由于长期过度紧张疲劳、精神创伤或病后体弱等原因引起，是大脑皮质兴奋和抑制平衡失调而引起的一种功能性疾病。临床表现如头晕、头胀、耳鸣、记忆力减

退、精神萎靡、肢倦乏力；失眠、多梦、情绪易激动，或见心悸、手足发冷、食欲减退、恶心呕吐、腹胀、性功能减退、遗精等。



(图 31)

中医学认为本病属“郁症”、“不寐”、“虚损”、“遗精”等范围，多因思虑过度，劳伤心脾，房事不节、肾气亏损、情志不舒，肝气郁滞、神志不宁所致，其病主要在心、肝、脾、肾等脏器。

【施治部位】

心俞、肝俞、胃俞、肾俞、中脘、三阴交、足三里、神门。(见图 32)

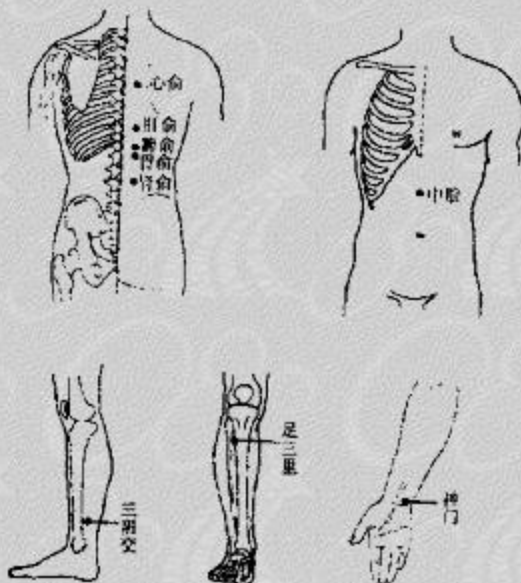
33、癫痫

癫痫俗称羊角风，是一种发作性神志异常疾病，以小儿、青壮年居多。本病反复发作，缠绵难愈，严重影响人的智力发展。其临床表现为发作性神经异常，轻者为短时间的神志丧失，突然中止活动，中断谈话，脸色苍白，两眼凝视，手中持物落地，头向前倾或转向一侧，上肢微颤动，发作 1 次，立即神志清醒，重者突然昏倒，神志丧失，口吐白沫，两眼上视。瞳孔散大，四肢抽搐，角弓反张，大小便失禁，或呕吐，或作猪、羊叫声，发作过后，往往几天都恢复不过来。

癫痫病因复杂，有的是先天性因素引起，如脑畸形，有的由于头痛、脑寄生虫、肿瘤引起，应及时到医检查治疗。

【施治部位】

身柱、心俞、脾俞、巨阙、内关、外关、筋缩、神门。（见图 33）



（图 32）

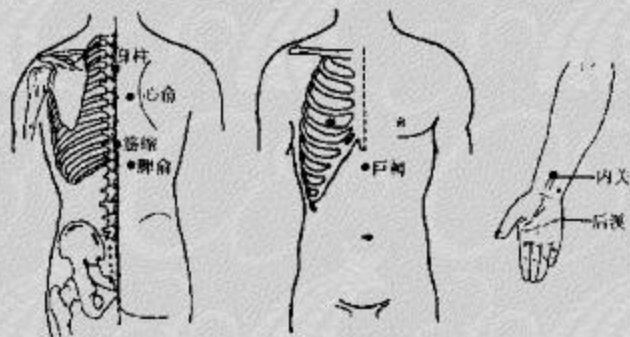
34、老年痴呆症

老年性痴呆系指进入老年期（男 65，女 55）后，随着大脑组织的衰老及受到感染、中毒、精神刺激等导致组织进行性缺损并有脑组织特征病理改变的一种精神病。典型病状有智能减退，常常先出现性格改变，变得自私、主观、固执、注意力不集中，以至逐渐出现记忆力障碍及判断错误，并由于猜疑和幻想而导致冲动和破坏性行为，最终智力几乎守全丧失，失去自理能力。

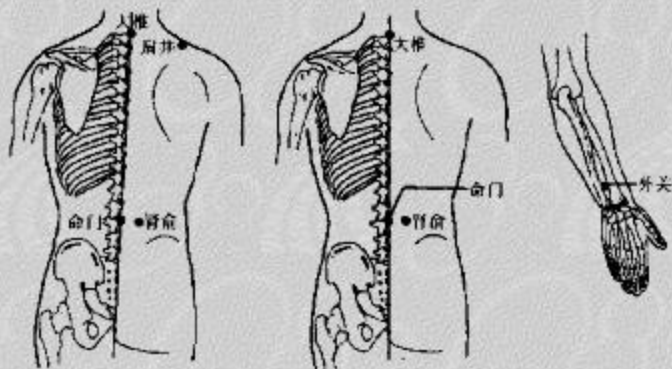
本病中医属“痴呆”、“健忘”、“郁症”、“癫病”、“狂症”等范围。

【施治部位】

大椎、肾俞、命门、内关、外关。（见图 34）



(图 33)



(图 34)

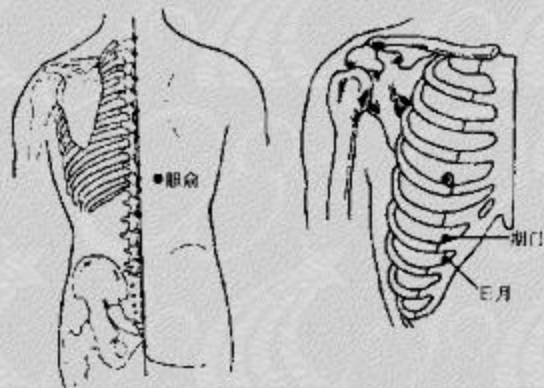
35、胆结石、胆囊炎

胆结石、胆囊炎发现率较高，尤其在我国的广大农村，由于饮水习惯不良，致使胆结石患者约占我国人口数 1/3，有的地区则高达 80%。用拔罐法治疗此病比较理想，特别是拔胆区穴位，止痛效果非常好。

【施治部位】

中渚、胆俞、太冲、阳陵泉、期门、日月、阴陵泉、阿是穴。（见图 35）

36、病毒性肝炎



(图 35)

病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的消化道传染病,以食欲减退、恶心、上腹部不适、肝区疼痛为主要临床表现。部分患者并发黄疸,如病程迁延可转为慢性。甲型肝炎易感染,应注意隔离,防止传染。乙型及丙型肝炎一般经血液感染。该病男女发病率相同,其发病率占传染病总病率的第一位。全年均可发病,对人类威胁较大。

【施治部位】

肝俞、胆俞、脾俞、中脘、太冲、足三里、三阴交、阿是穴。(见图 36)

肝俞、胆俞、阴陵泉、胆囊穴、中脘、天枢。

作用:

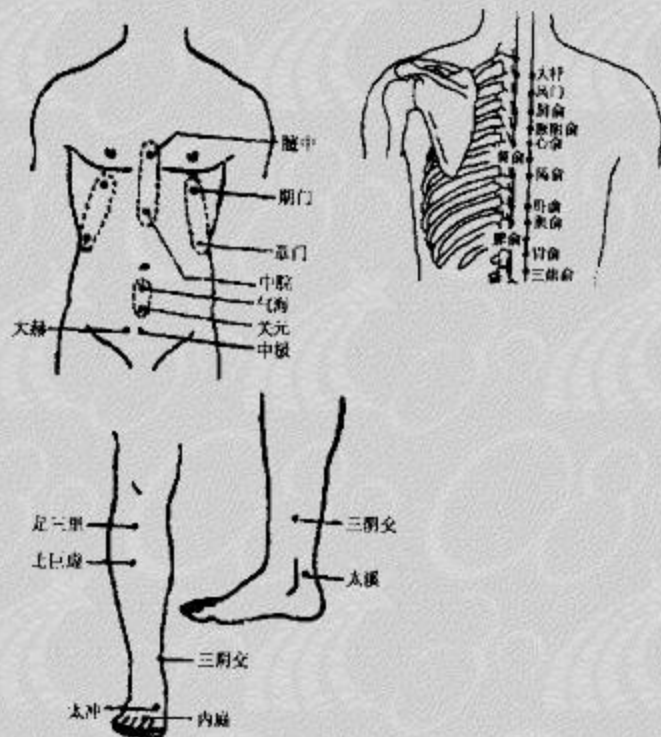
清热利湿、疏肝利胆、宽胸解郁,消炎止痛。

37、泌尿系感染

泌尿系感染,一般是指细菌直接侵入泌尿系统而引发的炎性病变。往往发病突然,表现为尿频、尿急、尿痛、尿液呈脓性。小腹胀痛,膀胱区疼痛等。有急性和慢性之分,发病女性多于男性,男女之比 1:10。急性症状如治疗不及时或不当,就易使肾脏受到损害,最终导致肾功能衰竭。本病属中医学“淋症”范围,应去医院采取综合性治疗。

【施治部位】

膀胱俞、肾俞、小肠俞、中极、阴陵泉。(见图 37)



(图 36)

38、肾盂肾炎

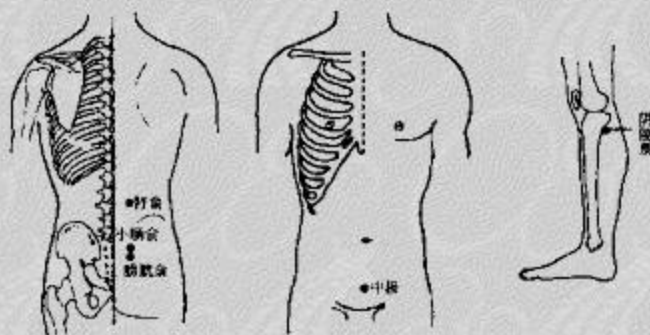
肾盂肾炎是由细菌感染造成肾盂部位的炎症,发病以女性多见,主要出现腹痛、腰痛、尿频、尿血症状。有急、慢性之分,慢性肾盂肾炎多由于急性肾盂肾炎转变而来。中医属“淋症”范围。

【施治部位】

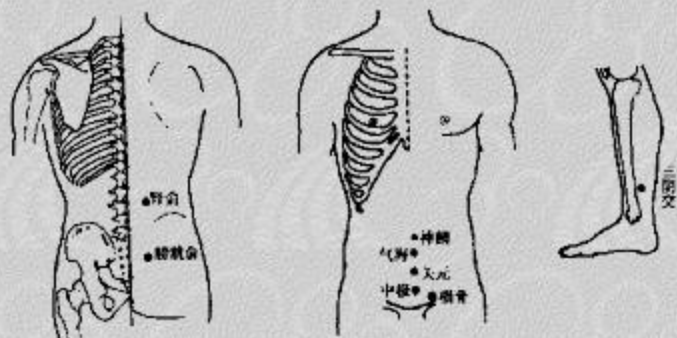
肾俞、膀胱俞、膀胱俞、中极、足三里、脾俞、肾俞。(见图 38)

39、遗尿

遗尿是指睡眠中小便经常不自觉地尿在床上,严重的甚至一夜尿数次。常见于小儿和老年人,中青年人也有患此症的。拔罐治疗此病效



(图 37)



(图 38)

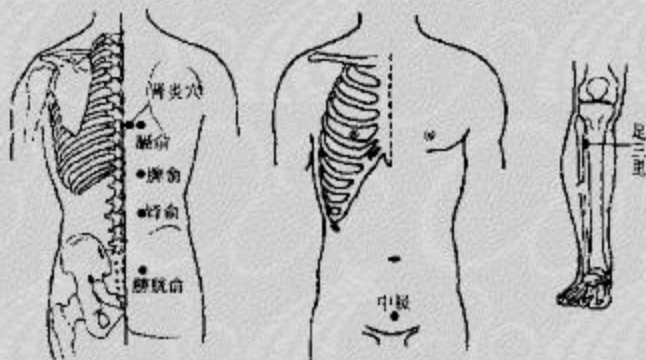
果好,在治疗期间,应注意睡前少进汤水,并定时让人或用闹钟叫醒小便,使其逐渐养成起床排尿习惯。如检查发现因器质性疾病引起者,应积极查出原发病并去医院治疗。

【施治部位】

膀胱俞、肾俞、关元、三阴交、中极、横骨。(见图 39)

40、慢性前列腺炎

慢性前列腺炎是成年男性的常见病、多发病,35 岁以上男性的 30—40% 的人患有此病。由于腺体长期充血,腺小管和腺体功能低下等原

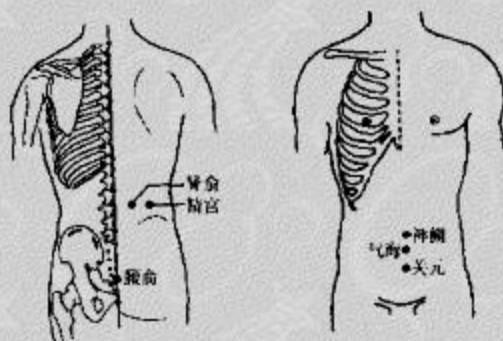


(图 39)

因,可出现尿频、尿痛、小便淋沥不尽等症状,属中医“淋症”范围。

【施治部位】

腰俞、关元、气海、肾俞、精宫(见图 40)。



(图 40)

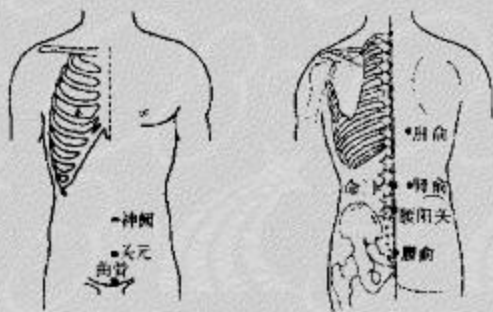
41、阳痿

阳痿,过性生活时阴茎不能勃起,或勃起而不坚,不能进行正常性生活。本病的原因,多因早婚纵欲,或犯手淫致伤肾气,亦有因湿热下注,宗筋弛缓,或恐惧伤肾所致。

【施治部位】

气海、关元、大赫、次髎、肾俞、志室、三阴交。

梦遗加拔心俞、内关、神门，滑精加拔太溪、足三里。（见图 41）



（图 41）

操作方法 1：辨证施治从上述穴中选取 5—7 个，用留罐法拔 10—20 分钟，每天一次，上述穴位交替使用。

操作方法 2：用走罐法沿任脉、督脉、背部足太阳膀胱经穴走罐，以皮肤潮红为度。走罐结束时，罐要分别在大椎、大杼、肾俞、膏肓、神堂、气海、大赫留罐 3—5 分钟，以上穴位分两三次使用。例如：第一次拔大椎、心俞、气海，第二次可拔大杼、肾俞、膏肓、大赫。

注意：

1) 在治疗期间应避免房事。

2) 走罐要涂拔罐油。

42. 糖尿病

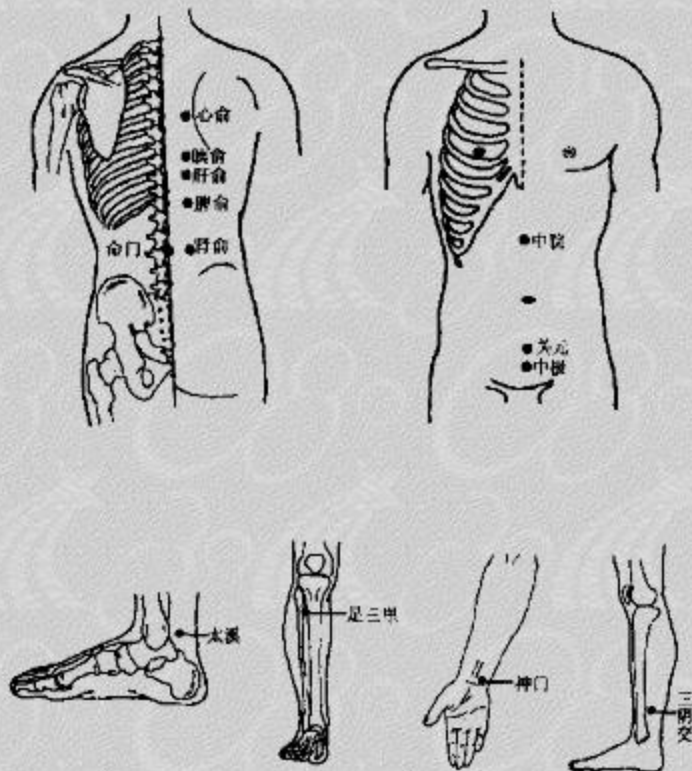
糖尿病，人们把它叫做奢侈病，或者富贵病。多饮、多食、多尿，精疲力竭、日益消瘦，严重时，一般靠注射胰岛素来维持。

根据病因，发病机理和临床表现，可将糖尿病大致分为两型：胰岛素依赖型糖尿病（包括因自身免疫病变所致的Ⅰ型糖尿病）和非胰岛素依赖型糖尿病（又称Ⅱ型糖尿病），前者多在青少年期发病，后者多见于中、老年人。

拔罐对早期、中期患者疗效好，当然花费的时间要长一些。

【施治部位】

胰俞、脾俞、肾俞、足三里、大溪。(见图 42)



(图 42)

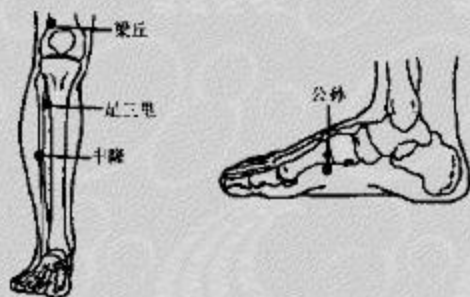
注意事项:糖尿病的出现多是生活饮食丰裕的结果,多因紧张、压力或暴食、肥胖所致。它本身致死者极少,但多因此病引起动脉硬化、中风或心脏病。我们在用药物和拔罐治疗的同时,应特别注意食物疗法的有效配合。每次拔罐后,必须在 30 分钟内喝 1 杯水,有利于血液流动,消除血栓形成。

按照营养学标准,体重(kg)/身高²(m)大于 24 就称为肥胖,肥胖者如常伴有气喘、乏力,甚至流涎等症状,就称为肥胖症。

有人节食减肥或采用一些特殊的减肥手段,使体重骤然下降几十斤,致使精神、体力不佳,虽然体态改观了,结果身体却出现病态,这样的减肥手段是不足取的。所以,经穴减肥主张不要迅速减肥,体重大幅度下降,而是通过循序渐进、持之以恒的减肥手段,在改变体态达到健美目的的同时,保持健康,精力充沛。

【施治部位】

梁丘、丰隆、足三里、公孙、阿是穴。(见图 43)



(图 43)

44、甲状腺机能亢进症

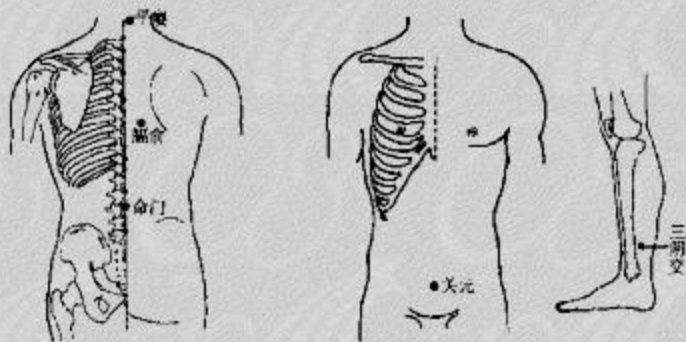
本病简称“甲亢”,是一种常见的内分泌疾病。主要症状为心动过速,怕热多汗,食欲亢进,体重下降,情绪容易激动,手颤等;也有时伴随不同程度的甲状腺肿和突眼症。亦有仅甲状腺肿大,而无甲亢症状者,称为单纯性甲状腺肿,中医称之为“瘰癧”。如甲状腺肿大,并出现压迫症状,可考虑去医院手术。甲亢在针治期间应配合碘剂等药物内服,以提高疗效。

【施治部位】

平瘰、命门、关元、膻俞、三阴交、阿是穴。(见图 44)

二、外科疾病

45、落枕



(图 44)

落枕，多因睡眠时颈项部位不当，或负重时颈部扭转受伤，或风寒侵入经络，使局部气血失调，筋脉拘急所致。

【施治部位】

大椎、天柱、肩井、肩中俞、肩外俞、缺盆、后溪、悬钟。(见图 45)

操作方法 1：从上列穴中选 4—6 穴留罐法拔 10—20 分钟。

操作方法 2：以罐口刮摩手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阳胆经，刮后在颈部肩部穴位加拔罐，或者用重手法刮至出痧为止。

注意：以罐口刮摩涂拔罐油。

46. 颈椎病

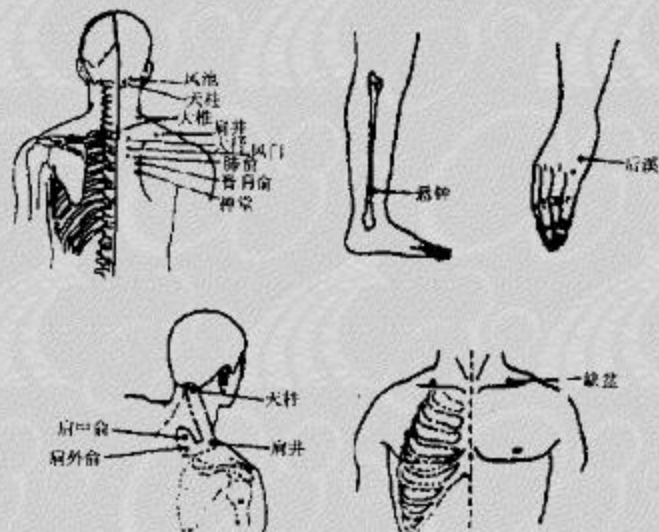
颈椎病是因颈椎长期劳损、骨质增生、椎间盘突出、韧带增厚，压迫颈脊髓、神经根和血液循环障碍所致的综合症。

【施治部位】

大椎、大杼、肩中俞、肩外俞。(见图 46)

操作方法 1：每次选用 2 穴，用梅花针叩至皮肤发红，并有少量出血点，然后拔罐 10 分钟，以拔出瘀血为度，隔日 1 次。

操作方法 2：用梅花针叩刺病变椎体周围的压痛点、阳性反应物或颈椎 4—7 夹脊穴，叩至皮肤出血后拔罐 5—10 分钟，如此重复 3 次，每次罐内可见黄粘液，擦净后用艾条温灸 10 分钟。每日 1 闪，10 次为 1 疗程。



(图 45)

47、颈椎骨质增生症

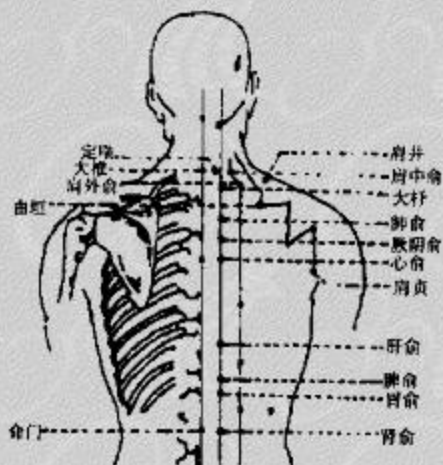
颈椎病是一种退行性颈椎椎间盘韧带关节病，多发于 40 岁以上的人。主要症状有颈、肩、臂痛，上肢麻木，活动受限，或有眩晕、恶心、呕吐、耳鸣、视物不清，甚至出现上、下肢活动障碍和痉挛性瘫痪。中医属“痹症”、“痿症”、“头痛”、“眩晕”、“项强”等范围。

【施治部位】

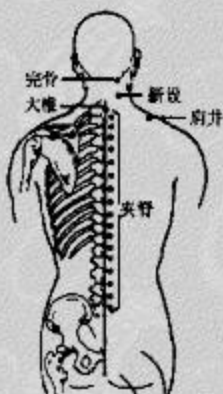
夹脊、大椎；曲池、新设、阿是穴。（见图 47a、b）

48、肩关节周围炎

肩关节周围炎，是肩关节的关节囊和周围软组织的一种退行性炎症性疾病，在 40—50 岁发病，故日本称五十肩，又称漏肩风。女性多于男性。当然二三十岁的年轻人也会发生。患这种病的人症见单侧或双侧肩关节酸重疼痛，运动受限，往往痛连手臂，伸屈不利，或痛有定处，或痛牵颈项，从肩部到手腕，都会有被撕拉的感觉，甚至痛得叫出声来，



(图 46)

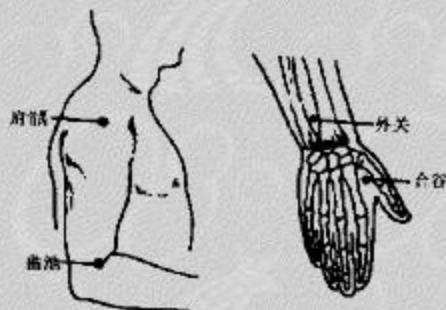


(图 47)a

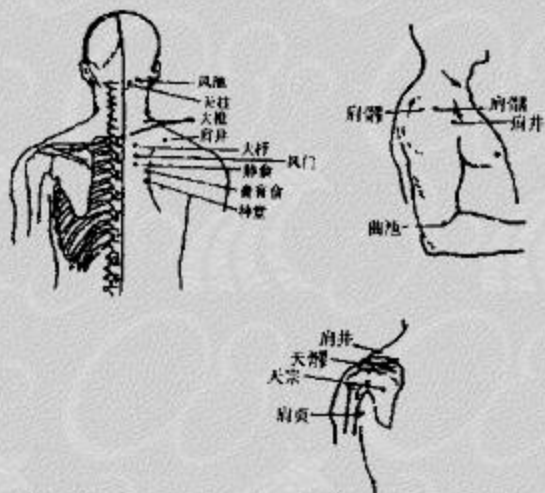
是一般人难以忍受的。

【施治部位】

肩三针、天柱、肩井、天宗、曲池。(见图 48)



(图 47)b



(图 46)

操作方法 1: 从上述穴位中取 5—6 穴, 用留罐法拔 10—20 分钟。

操作方法 2: 用罐口刮痧以上穴区 3—5 分钟, 以出痧为度。

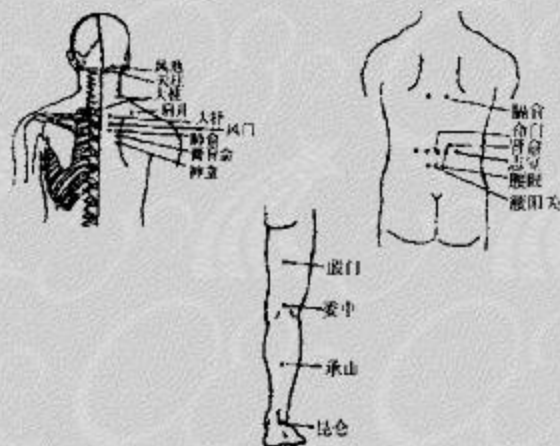
注意事项: 在治疗后应注意活动肩部, 以促进恢复。

49、腰痛

以风湿腰痛、腰肌劳损、肾虚腰痛为主。

【施治部位】

大椎、天柱、大杼、膏肓、神堂、命门、肾俞、腰眼、委中。劳损痛加拔膈俞，肾虚腰痛加拔志室。（见图 49）



(图 49)

操作方法 1：可由主穴与配穴中选取 5—7 个穴位，用留罐法拔 10—20 分钟，身体虚者可用闪罐法。

操作方法 2：走罐法，或循足太阳膀胱经、督脉走罐，以皮肤潮红为度。对身体瘦弱者可用罐口循经刮痧，以皮肤潮红或出痧为度。

50、软组织损伤

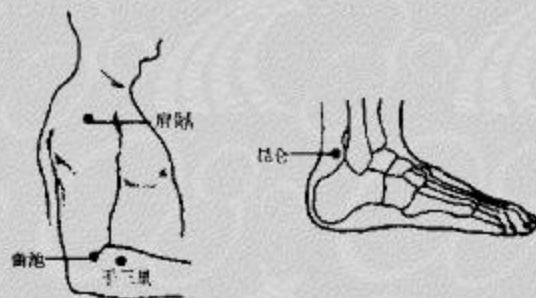
本病多发于颈、肩、肘、腕、腰、髋、膝、踝等部位，多由于受到不同程度的外部暴力，如扭、摔、过度曲伸、负重等使肢体和各关节周围的筋膜、肌肉过度扭曲或牵拉，引起损伤可撕裂，使受伤部位瘀血肿胀，疼痛剧烈，活动受限。此病属中医学“伤筋”范围。

【施治部位】

曲池、手三里、委中、昆仑、足三里、阳陵泉、阿是穴。（见图 50）

51、注射后肿块、疼痛

人们有时因注射青霉素或庆大霉素等药液后，臀部出现注射部位



(图 50)

疼痛而不堪忍受,有的几个小时,有的则 1 周也不能缓解,甚至形成硬结。

【施治部位】

独穴:阳陵泉。(见图 51)



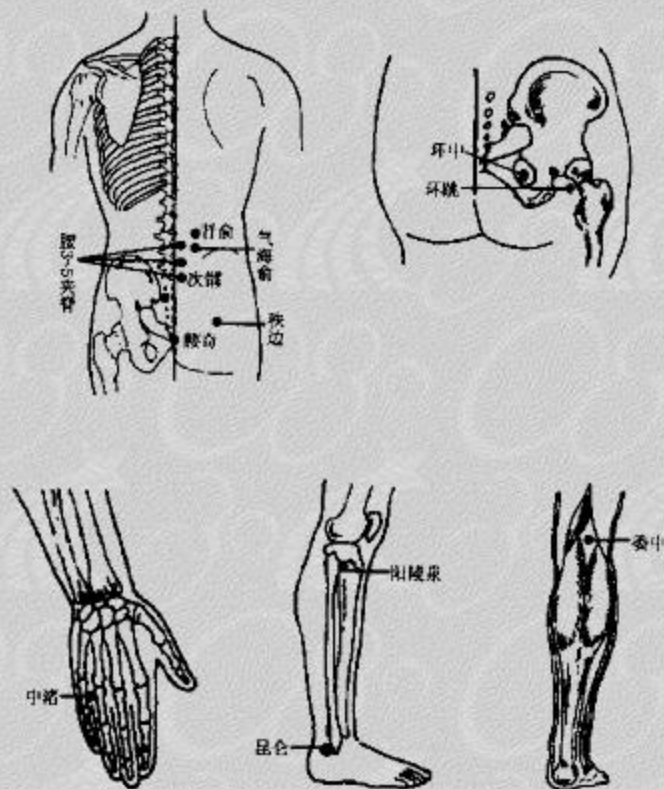
(图 51)

52、坐骨神经痛

坐骨神经痛是指在坐骨神经通路及其分布区内发生疼痛,为常见的周围神经疾病。本病多见于青壮年,男性较多。临床表现为:一侧腰部阵发性或持续性疼痛。其主要症状是臀部、大腿后侧、小腿后或外侧及足部发生放射性、烧灼样或针刺样疼痛,行动时加重,夜重昼轻。多因气候变化和劳累诱发。

【施治部位】

肾俞、气海俞、腰3—5夹脊、秩边、环跳、中渚、阳陵泉、阿是穴。(见图52)



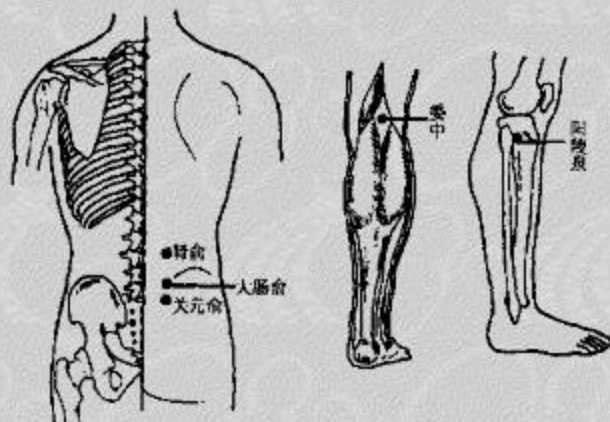
(图52)

53、腰椎间盘突出症

椎间盘的髓核多因长期慢性的纤维环与髓核变性或急剧的机械压迫或扭转而导致向后纵韧带突出,使椎间孔或椎管内狭窄而压迫神经,从而出现腰痛、后腿痛,腿痛重时则不觉腰痛。每发于第4与第5腰椎间隙,此处压痛明显。中医属“腰腿痛”范围。

【施治部位】

肾俞、大肠俞、关元俞、委中、阳陵泉、环跳、阿是穴。(见图 53)



(图 53)

54、腰肌劳损

腰肌劳损是以腰软组织突然受损伤引起腰部疼痛、活动受限为主症的病症。多因过度用力，或姿势不当，剧烈运动时引起此病。腰部前屈、后伸、转侧均明显受限，欲称“板腰”。中医属“腰痛”、“闪挫”范围。

【施治部位】

肾俞、委中、痞根、命门、承山。(见图 54)

55、风湿性关节炎

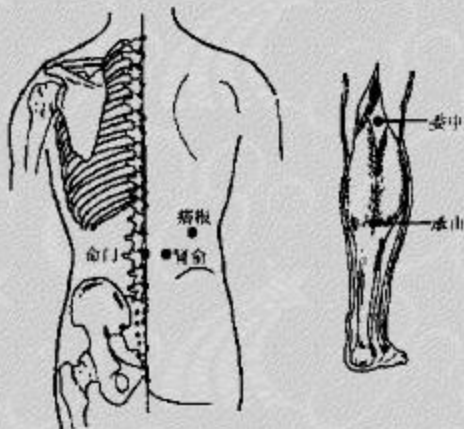
这是一种以侵犯关节为主的变态反应性结缔组织疾病，典型表现为：多发性、游走性，多以侵犯四肢关节为特征。

【施治部位】

委中、膝眼、承山、阿是穴。(见图 55)

56、类风湿性关节炎

此病是以慢性、对称性、多发性关节炎为主的一种周身性疾病，当今临床上尚无针对性的治疗手段和药物。此病为拔罐的适应症，如能耐心坚持，一般可获得满意效果，配合药物治疗效果更好。



(图 54)



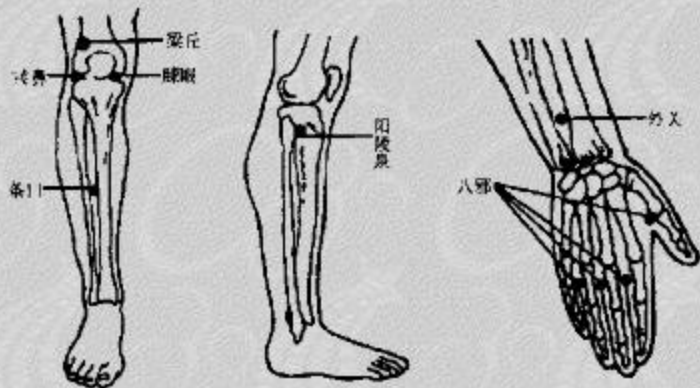
(图 55)

【施治部位】

梁丘、挟鼻、条口、阳陵泉、膝眼、阿是穴。(见图 56)

57、急性阑尾炎

急性阑尾炎由阑尾梗阻继发感染而致，是一种最常见的急症，其临床表现以转移性、固定性右下腹持续疼痛或伴有恶心呕吐发热为主要特征。急性阑尾炎在病理解剖学上分为急性单纯性阑尾炎、急性化脓性阑尾炎和坏疽性或穿孔性阑尾炎三种类型。其中急性单纯性阑尾炎可

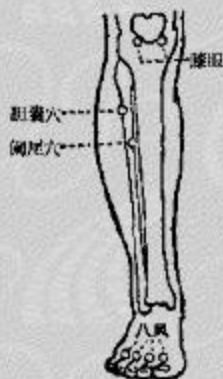


(图 55)

采用拔罐治疗，而急性化脓性阑尾炎、穿孔性阑尾炎则迅速去医院治疗。此病可归属于祖国医学的“肠痈”范畴，其病因病机为寒温不适，饮食不节而致湿热蕴结，气血瘀阻。

【施治部位】

阑尾穴、大横、阿是穴(见图 57)。



(图 57)

操作方法：病人仰卧，取口径 3cm 磁疗拔罐用闪火法在右侧大横

穴(脐旁4寸处)、关元穴(脐下3寸,腹正中线上)、阿是穴(右下腹压痛明显处)和双侧阑尾穴(在足三里穴与上巨虚穴之间压痛最明显处取穴。一般约在足三里下2寸处,足三里穴位于髌骨下方外侧凹陷下3寸处)拔5—10分钟,每天2次。

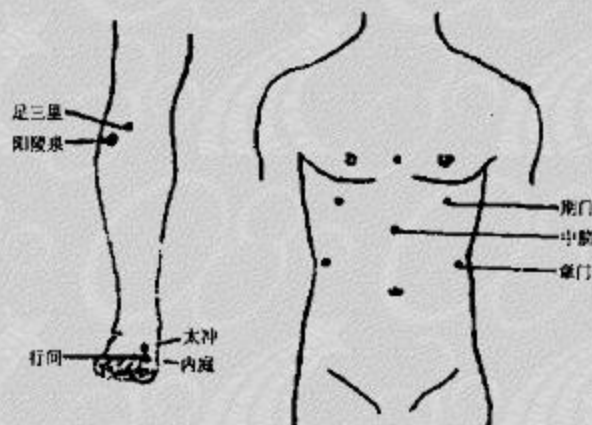
亦可采用先以三棱针点刺阑尾穴和阿是穴,后再拔罐的治疗方法。若病人发热明显时,可加拔曲池穴(侧腕屈肘,肘横纹桡侧端凹陷处)。

58、胆道蛔虫病

胆道蛔虫病是由于肠道蛔虫上窜钻入肠道而引起的一种急腹症。多发于儿童和青壮年。临床特点为突然出现阵发性上腹剑突下剧烈绞痛,有钻顶感,伴有恶心呕吐,疼痛间歇期如常人。本病可归属于祖国医学的“蛔厥”范畴,其病因病机为胃热肠寒,蛔虫逆行入胃和肠道,而致气机逆乱。

【施治部位】

期门、阳陵泉、不容、上腕、胆俞。(见图58)



(图58)

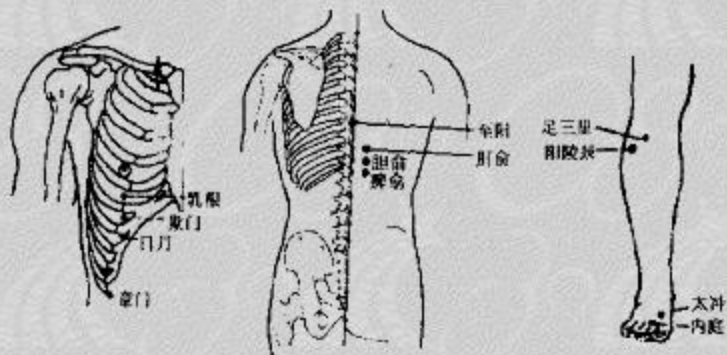
59、胆绞痛

胆绞痛是胆石症和胆道系统感染疾病过程中的一个常见症状。表现为突然发作的右上腹、剑突下阵发性绞痛,多向右肩背部放射。可发

生胆绞痛的疾病常见的有急性胆囊炎、慢性胆囊炎急性发作、胆总管结石、肝内胆管结石、急性梗阻型化脓性胆管炎等，其中急性梗阻型化脓性胆管炎必须迅速去医院就诊；因结石而致胆绞痛可用拔罐法缓解症状，但应配以排石治疗以求根治；由胆囊炎引起的胆绞痛可单独采用拔罐疗法或配以其他疗法。胆绞痛可归属于祖国医学的“腹痛”、“胃脘痛”范畴，其病因病机为情志不畅，饮食不节，外邪侵袭，湿热内蕴而致肝胆之气失于疏泄。

【施治部位】

胆俞、阳陵泉、中脘、期门。（见图 59）



（图 59）

60. 急性乳腺炎

急性乳腺炎是指乳腺的急性化脓性炎症，多见于产后 3—4 周的初产妇。临床主要表现为乳房肿块，疼痛，伴寒战高热等。可归属于祖国医学的“乳痈”范畴，其病因病机为忧思郁怒，肝气郁结或过食肥腻，胃热壅滞而致气血凝滞，乳汁瘀积，蕴热腐肉为脓。

【施治部位】

（1）肝气郁结型：期门、肩井、内关、天池。（图 60-1）

操作方法：病人坐位，取口径 3cm 的拔罐，在肩井穴（肩上，第七颈椎棘突与锁骨肩峰及锁骨与肩胛冈两者连线的中点处）拔 10 分钟；再令病人仰卧，同前法在天池穴（乳头外 1 寸，平第四肋间隙处）、期门（乳

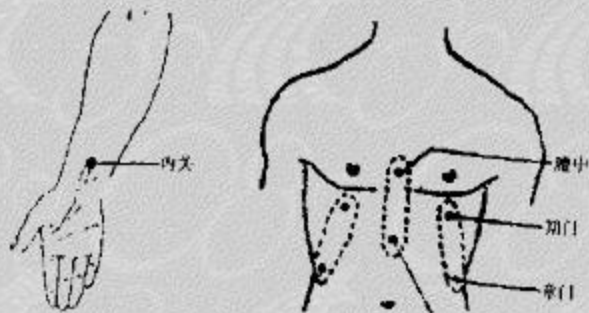
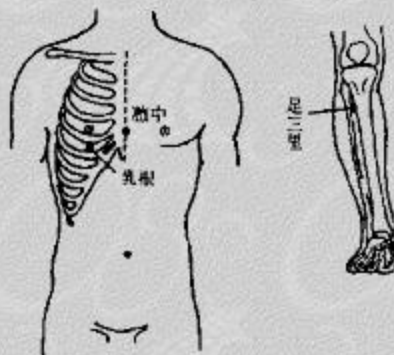


图 60-1

头直下,平第六肋间隙处)和内关(仰掌,腕横纹上2寸,两筋之间)拔罐10分钟。每天1次。

注意取患者侧穴位。

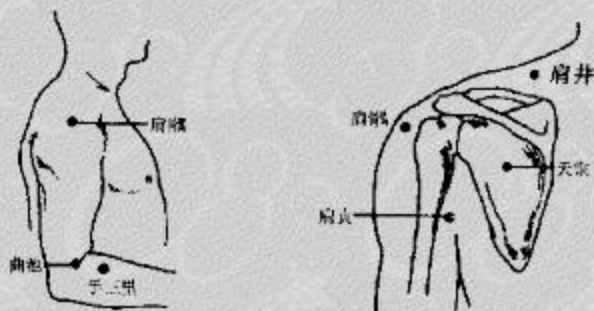
(2) 胃热壅结型:膻窗、足三里、臃中。(见图 60-2)



(图 60-2)

操作方法:病人仰卧位,先用三棱针点刺患侧膻窗穴(乳中线上第三肋间隙处)、臃中穴(胸正中线上,两乳头之间,平第四肋间隙处)和双侧足三里穴(髌骨下方外侧凹陷下3寸处),然后取口径3cm的拔罐,在点刺穴位上拔5分钟。每天1次。

(3) 毒盛酿脓型:肩贞、天宗、乳根、曲池。(见图 60-3)



(图 60-3)

操作方法：人坐位，先用三棱针点刺肩贞穴、天宗穴和曲池穴，然后再拔罐 5 分钟。每天 1 次。若脓肿已溃破，可在破溃处拔罐 5 分钟，每天 1 次，拔至无脓为止。

61. 急性尿潴留

急性尿潴留是指膀胱充满尿液而不能排出。本病常突然发生或在慢性排尿困难的基础上突然加重，临床表现为下腹胀痛，有尿液不能排出。病因可分机械性梗阻和动力性两类，前者常见于前列腺肥大，尿道狭窄，膀胱内肿瘤，结石嵌顿等，后者膀胱、尿道无器质性梗阻病变，尿潴留系由排尿功能障碍所引起，如麻醉、手术后等。拔罐疗法仅适用于后者，若拔罐无效者，则应施行导尿或膀胱穿刺术。本病可归属于祖国医学的“癃闭”之范畴，其病因病机为三焦气化不利，膀胱气化无权。

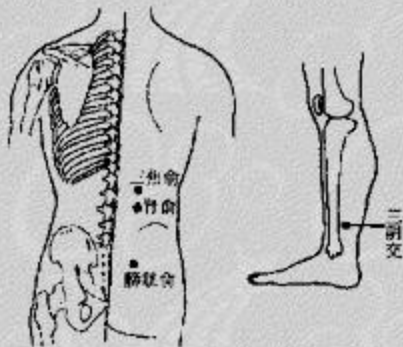
【施治部位】

(1) 湿热壅阻型：三焦俞、膀胱俞、水道、三阴交。(见图 61-1)

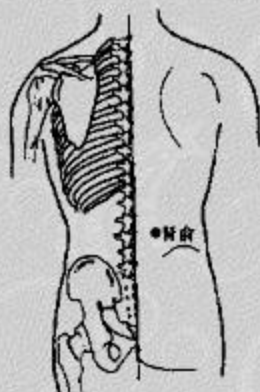
操作方法：病人俯卧，先用三棱针点刺双侧三焦俞穴（第一腰椎棘突下，旁开 1.5 寸处）、双侧膀胱俞穴（平第三骶后孔，旁开 1.5 寸处），取口径 3cm 罐在穴位上拔 5 分钟；再令病人仰卧，同前法在水道穴（脐下 3 寸，腹正中线上旁开 2 寸）和双侧三阴交穴（内踝高点上 3 寸处）拔罐 5 分钟。

(2) 肝气郁滞型：肾俞。(见图 61-2)

操作方法：病人俯卧，先用三棱针点刺双侧肝俞穴（第九胸椎棘突



(图 61-1)

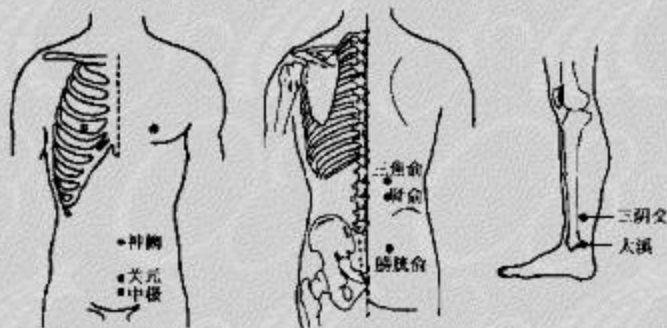


(图 61-2)

下,旁开 1.5 寸处)、双侧膀胱俞穴(平第二骶后孔,旁开 1.5 寸处)和双侧三焦俞穴(第一腰椎棘突下旁开 1.5 寸处),后取口径 3cm 的拔罐,在穴位上拔 5 分钟;再令病人仰卧,同前法在中极穴(脐下 4 寸,腹正中线上)拔罐 5 分钟。

(3) 中气不足型:脾俞、三焦俞、关元、三阴交。(见图 61-3)

操作方法:病人俯卧,先用三棱针点刺双侧脾俞穴(第十一胸椎棘突下,旁开 1.5 寸处),然后取口径 3cm 的拔罐,在穴位上拔 5 分钟;再



(图 61-3)

令病人仰卧，同前法在关元穴（脐下 3 寸，腹正中线上）和三阴交穴（内踝高点上 3 寸处）拔罐。

62、急性胰腺炎

由于胰腺消化腺本身所引起的急性炎症，病理上有胰腺水肿、坏死、出血等改变。祖国医学认为由湿热之邪蕴结中焦，脾不健运，胃失和降而成。

【施治部位】

大椎、肝俞、脾俞、至阳、胆俞、胃俞。（见图 62）

操作方法：病人俯卧，先用三棱针点刺双脾俞、肝俞、胆俞、大椎，然后取口径 3cm 的拔罐，留罐 10 分钟。

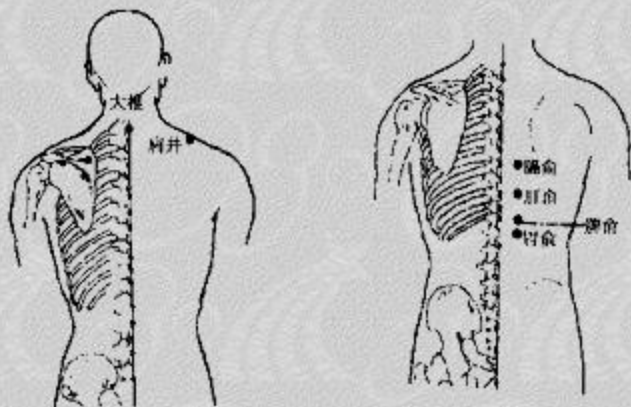
63、肾绞痛

肾绞痛是肾及输尿管结石的主要症状。肾绞痛常因为激烈运动和大量饮水而诱发，表现为腰部可腹部阵发性绞痛，可向下腹、外阴、大腿内侧放射。本病可归属于祖国医学的“淋症”、“腹痛”等病证范畴。其病因病机为湿热下注，尿液煎熬成石阻塞尿路，下焦气机郁闭不通。本病采用拔罐疗法主要可除、缓解疼痛，还应配合其他排石疗法以达根治。

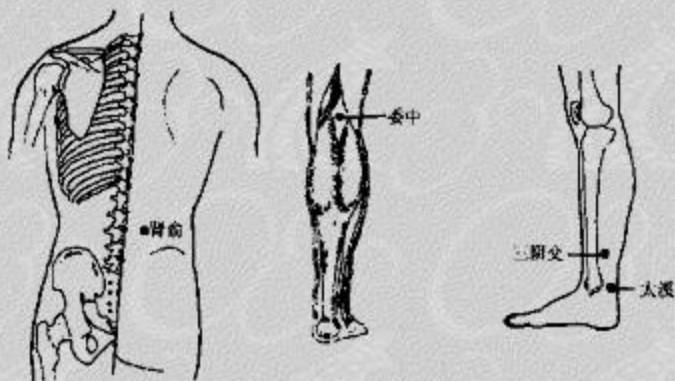
【施治部位】

(1) 下焦湿热型：肾俞、京门、委阳、三阴交。（见图 63-1）

操作方法：病人俯卧，先用三棱针点刺双侧肾俞穴（第二腰椎棘突下，



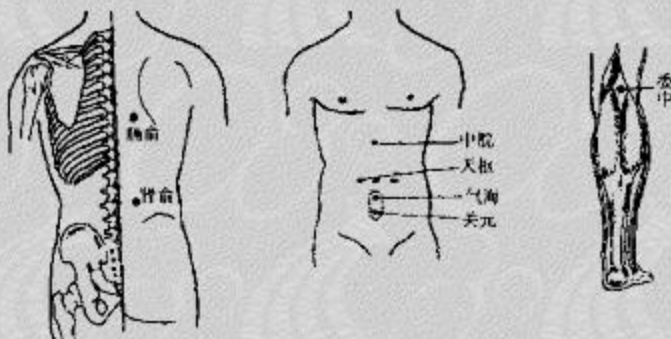
(图 62)



(图 63-1)

旁开 1.5 寸处)、或是委阳穴(横纹偏外侧端),取口径 1.5cm 拔罐,用拔罐拔穴位 5 分钟;再令病人侧卧,用前法在患者京门穴(侧卧,侧腹部十二肋骨游离端下际处)拔罐 5—10 分钟;再仰卧,同前法在双侧三阴交穴(内踝高点上 3 寸处)拔罐。每次 1 次。

(2) 气滞血瘀型：肾俞、京门、水道、气海、委中。(见图 63-2)



(图 63-2)

操作方法：病人俯卧，取口径 3cm 磁疗拔罐，用闪火法在双侧肾俞穴（第二腰椎棘突下，旁开 1.5 寸处）、患侧委中穴（腠横纹处中央）拔 10 分钟；再侧卧，同前法在患侧京门穴（侧卧，侧腹部十二肋骨游离下际处）拔罐；再令病人仰卧，（脐下 3 寸，腹正中线旁开 2 寸处）拔罐。每天 1 次。

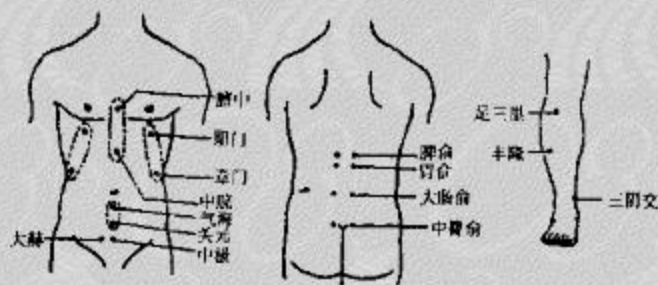
64. 直肠脱垂

直肠脱垂又名脱肛，是指肛管、直肠向下脱出于肛门之外。多见于老年和 1—3 岁儿童。现代医学认为本病与解剖缺陷有关，多与小儿身体未发育完全或因先天性发育不全，年老久病，营养不良致盆底组织松弛无力等因素有关。也可因习惯性便秘，长期腹泻，多次分娩，重体力劳动使腹内压增高而致脱肛。主要临床表现为排便时或其他原因使腹内压增高时有肿块自肛门脱出，可自行缩回或需要用手托回。本病可归属于祖国医学的“脱肛”范畴，其病因为素体虚弱，中气不足或劳力耗气，产育过多，大病久病后而致气虚失摄。

【施治部位】

(1) 气虚下陷型：足三里、脾俞、气海。(见图 64-1)

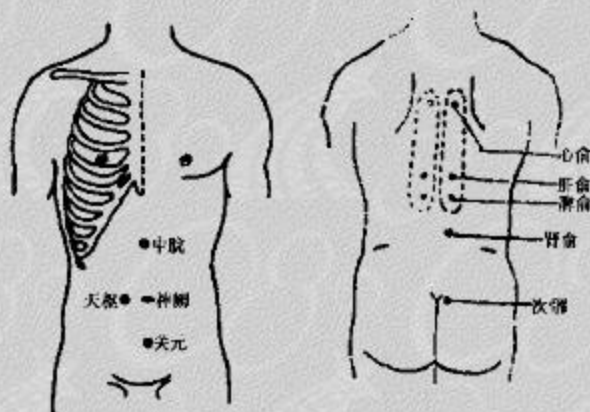
操作方法：病人俯卧，取口径 3cm 的拔罐，用拔罐法在双侧脾俞穴（第十一胸椎棘突下，旁开 1.5 寸处）和双侧次髂穴（第二骶后孔中）拔



(图 64-1)

罐 15 分钟；再令病人仰卧，同前法在气海穴（脐下 1.5 寸，腹正中线上）和双侧足三里穴（髌骨下方外侧凹陷下 3 寸处）拔罐。每天 1 次。

(2) 脾肾两虚型：气海俞、白环俞、脾俞、肾俞、关元。（见图 64-2）



(图 64-2)

操作方法：病人仰卧，取口径 3cm 拔罐，用拔罐法在关元穴（脐下 3 寸，腹正中线上）拔 15 分钟；再令病人俯卧，同前法在同一侧脾俞穴（第十一胸椎棘突下，旁开 1.5 寸处）、肾俞穴（第二腰椎棘突下，旁开 1.5 寸处）、气海俞穴（第三椎棘突下，旁开 1.5 寸处）和白环俞穴（平第四骶后旁开 1.5 寸处）拔罐。第二天拔另一侧背部俞穴和关元穴。每天 1 次，

两侧交替进行,10天为1疗程。

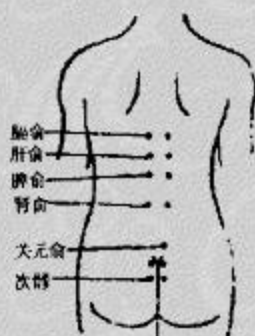
此外,治疗脱肛还可采用面饼拔罐法。病人俯卧,先在长强穴(尾骨端与肛门之间)盖覆面饼(用小麦面炆加水 and 面一小块,软硬度如包水饺面,把面捏成比所用拔罐口径稍大之 0.2cm 厚圆饼),然后用口径 1.5—3cm 拔罐在强穴上 15 分钟。每天 1 次。

65、疔病

疔病是指多个疔在身体各处同时散在发生或先后反复发生的疾病。好发于青壮年及糖尿病患者。此病是由于金黄色葡萄球菌从皮肤毛孔侵入毛囊及所属皮脂腺引起的急性化脓性感染。临床表现是反复发作的身体各处散在的局部圆锥形隆起,红肿热痛,有脓头,脓出即愈。本病可归属于祖国医学的“坐板疮”、“发际疮”等病症范畴,其病因病机为内郁湿热,外感风邪,邪毒蕴结而致。

【施治部位】

身柱,膈俞,肝俞。(见图 65)



(图 65)

操作:病人俯卧,先用三棱针点刺身柱穴(第三胸椎棘突下凹陷处)膈俞穴(第七胸椎棘突下,旁开 1.5 寸处),再取口径 3cm 的拔罐,用拔罐法在点刺穴位拔 5 分钟。隔天 1 次,5 次 1 疗程。

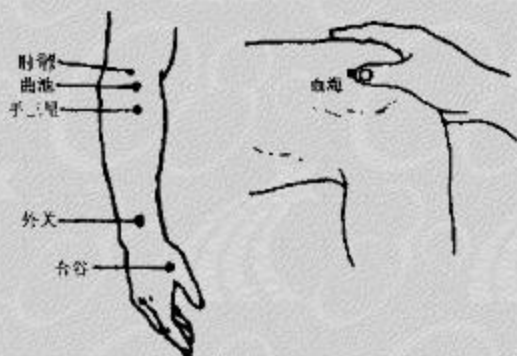
66、丹毒

丹毒是急性接触性传染性疾病。多发于春秋季节,常见于颜面部及

小腿部位。现代医学认为本病是溶血性链球菌(丹毒链球菌)侵入皮肤或粘膜内的网状淋巴管所引起的急性感染,由于皮肤粘膜的破损,如针刺,抓伤,皲裂,虫咬伤,足癣等而致感染所发。临床主要表现为皮肤突然出现红斑,灼热疼痛,色如涂丹,边缘清楚而稍隆起,常迅速向周围蔓延,中央部分可转为暗红色,发生脱屑渐愈。由于丹毒的发病部位不同,症状不尽相同,病名亦有多种,如发于头面部称为“抱头火丹”,发于躯干者称为“内发丹毒”,发于腿者称为“流火”。祖国医学认为本病的病因病机为体表失固,邪毒外侵而致血分有热,郁与肌肤。

【施治部位】

(1) 风热型:风池,外关,曲池,风门,血海。(见图 66-1)

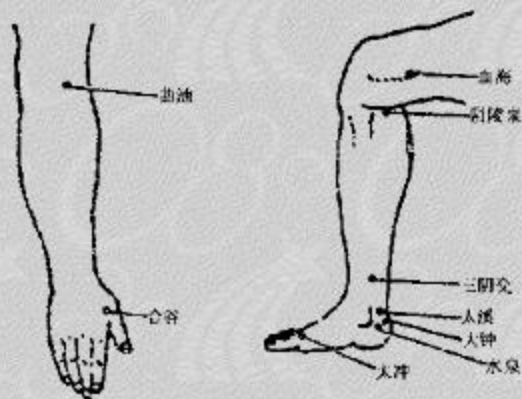


(图 66-1)

操作方法:病人坐位,先用三棱针电点刺同一侧的风池穴(枕骨粗隆直下凹陷,胸锁乳突肌与斜方肌上端之凹陷处)、曲池穴(侧腕屈肘,肘横纹桡侧端凹陷处)、外关穴(前臂背侧面,腕部横纹上 2 寸,桡、尺骨之间)、风门穴(第二胸椎棘突下,旁开 1.5 寸处)和血海穴(患者屈膝,医者以手掌心按患者膝腓骨上,食指至小指向上伸直,拇指约成 45° 角度,斜置于大腿内上方,当拇指尖处)取口径 1.5cm 的拔罐,在点刺穴位拔 5 分钟。第二天用同法拔另一穴位。两侧交替进行。

(2) 湿热型:曲池,阴陵泉,三阴交,血海,委中。(见图 66-2)

操作方法:病人仰卧,先用三棱针点刺同一侧的曲池穴(侧腕屈肘,



(图 66-2)

肘横纹桡侧凹陷处)、血海穴(患者屈膝,医者以手掌心按患者膝腘骨上,食指至小指向上伸直,拇指约成 45° 角度,斜置于大腿内上方,当拇指尖处)、阴陵泉穴(胫骨内侧踝起点凹陷处)、三阴交(内踝高点上3寸处),再取口径1.5cm的拔罐拔5分钟;再令病人仰卧,同上法在同一侧委中穴(膕横纹中央,两筋之间)拔罐。第二天拔另一侧,两侧交替进行。

此外,还可以采取局部拔罐法。常规消毒皮肤局部,先用三棱针散刺几下红肿部位,再取与皮肤部位相应的磁疗拔罐,拔两分钟,每天1次。

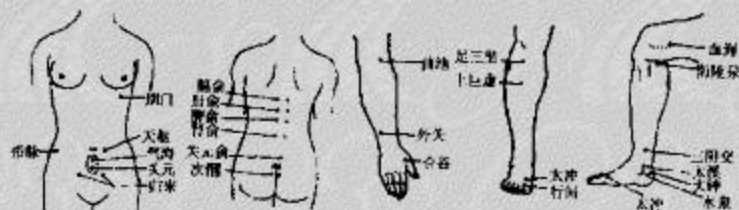
三、妇科疾病

67、月经不调

月经不调是指月经周期、经量、经色、经质发生异常变化,若提前七天以上称为月经先期,延后七天以上称为月经后期,不能定期来潮称为月经前后不定期。如持续时间超过正常范围,经量多,为月经过多;如经量很少,称为月经过少。

【施治部位】

关元、三阴交。(见图 67)



(图 67)

操作方法：月经先期加拔归来、行间、中封、太冲、太溪。月经后期加拔归来、天枢、气海、足三里。月经先后不定期加拔期门、肝俞、脾俞、血海、肾俞、太溪。月经量少加拔肾俞。可根据症状选穴，用留罐法拔罐 10—20 分钟。也可用走罐法，循任脉、足太阳膀胱经走罐，以使皮肤潮红为度。也可以根据症状自选穴位留罐，以提高效果。

68、痛经

痛经是指行经前后或行经期间，小腹或腰骶部疼痛，甚至痛不可忍。

【施治部位】

关元，三阴交，次髎，中极气滞血淤者加拔气海、太冲。

寒湿凝滞者加拔肾俞、大赫。

肝肾不足者加拔肝俞、肾俞、太溪。

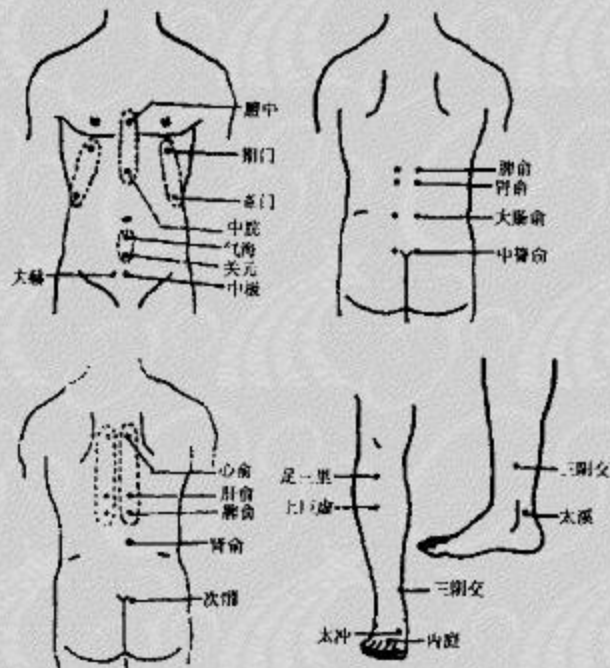
气血虚弱者加拔脾俞、大肠俞、足三里。(见图 68)

操作方法：(1) 可据症状选穴，用留罐法拔 10—20 分钟。(2) 用走罐法沿任脉、足太阳脾经肌肉丰满处走罐，以皮肤潮红为度。走罐后，应在关元、次髎、三阴交停留 3—5 分钟。(3) 用罐口重刮大椎、大杼、膏肓、神堂等穴区，以出痧为佳，同时应配合刮关元、中极、地机、合谷、曲泉等穴区。

注意：走罐或用罐口刮摩应涂拔罐油。

69、白带增多症

白带是指妇女阴道内流出的一种白色粘稠液体，属正常生理现象，但如果白带量多，或色、质、气味异常，并伴有腰酸背痛等症状者，即思



(图 68)

有白带增多症。

【施治部位】

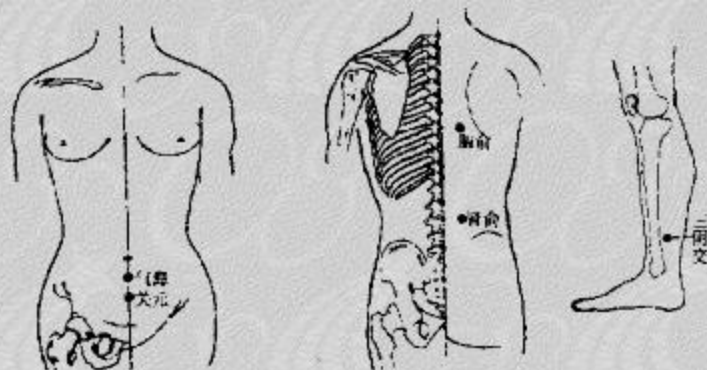
曲谷、关元、气海、归来、肾俞。(见图 69)

70、闭经

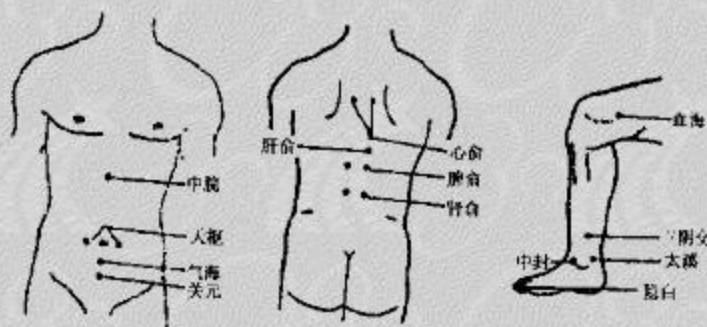
凡女子年龄超过 18 岁，仍无月经来潮；或曾来过月经，但又连续 3 个月以上不来月经者称为闭经。前者称为原发性闭经，后者称为继发性闭经。至于妊娠期、哺乳期、年老绝经期等闭经均属正常生理现象。闭经多由于全身性疾病或大悲大怒、严重营养不良、环境改变等因素干扰月经周期引起，应检查出原发病并对症治疗。

【施治部位】

气海、关元、膈俞、三阴交、血海。(见图 70)



(图 69)



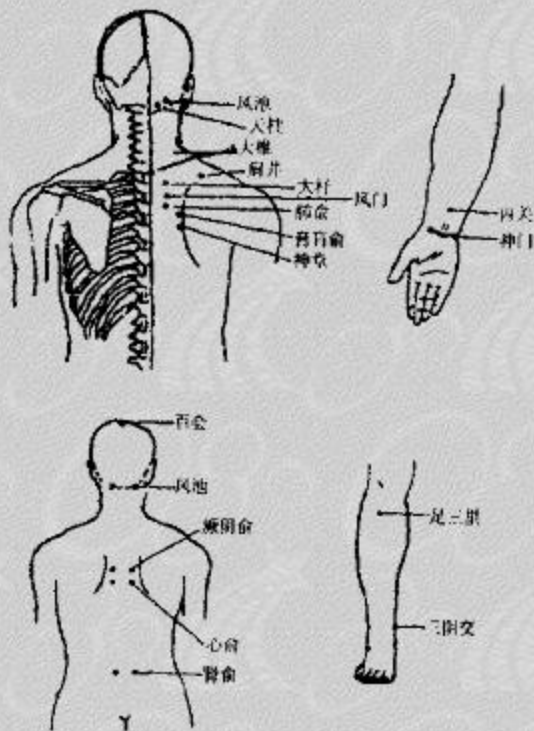
(图 70)

71、妇女更年期综合症

更年期综合症是指女性绝经前后出现的异常生理现象，即植物神经功能紊乱引起的一系列症候群，主要表现为：月经紊乱，烦躁或忧郁，头晕耳鸣，健忘失眠，性欲减退，神疲乏力，下肢浮肿，性格异常等症，可持续半年到1年。中医属“脏躁”等绝经前后诸症范围。

【施治部位】

腰俞、大椎、关元、肾俞、三阴交、风池、大抒、心俞、厥阴俞、膏肓、神堂、神门、足三里。（见图 71）



(图 71)

操作方法：(1) 从上述穴中选取 4—6 个穴位，用留罐 10—20 分钟，每日一次，穴位应交替使用。(2) 走罐法。沿任脉、足太阴脾经腹部穴走罐至皮肤潮红为度。

为提高疗效，可配合方法(1)或方法(2)，以罐口刮摩大椎、肩井、大杼、膏肓穴区，以皮肤潮红或出痧为佳。

注意：走罐或刮痧应涂拔罐油。

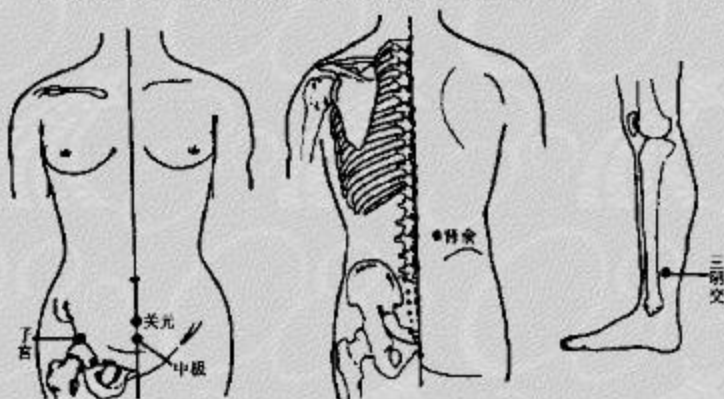
72、冷感症

在困扰妇女的病症中，以冷感症为最常见。症状主要表现为手臂、腿脚，尤其是腰部等发冷发凉，对性行为表现冷淡。妇女患寒症极易月

经不调,阻碍妊娠,应及时认真加以治疗。治疗冷感症,最重要的是促进荷尔蒙的分泌,强化生殖器的机能。如能夫妻协作,增加性感,相互治疗更佳。

【施治部位】

中极、子宫、三阴交、关元、肾俞、会阴。(见图 72)



(图 72)

73、产后乳汁不足

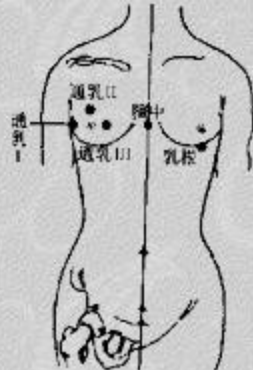
产妇在产后 2—10 天没有乳汁分泌,或分泌量过少,不能满足乳儿需要,称为“产后缺乳”或“乳汁不足”。多因分娩时失血过多,气随血耗,导致脾胃虚弱;或因精神抑郁,神疲乏力,食欲不佳而致经脉阻滞,乳汁不足。拔罐治疗乳汁不足效果不错,当然还应注意哺乳方法,保持心情舒畅,不可急躁。还应改善饮食,增加营养以治本,多食猪蹄汤、鲫鱼汤、糯米赤豆米粥等,配合针灸治疗,效果会更好。

【施治部位】

膻中、乳根、通乳(见图 73)。

74、不孕症

婚后夫妇同居 3 年以上未避孕而不孕者,称原发性不孕;婚后曾有过妊娠(流产、分娩),相距 3 年以上未避孕而不再受孕者,称继发性不孕。不孕是由于卵巢分泌及卵子生成障碍,或生殖道畸形,或孕卵着



(图 73)

床困难,或患有其它全身性疾病等原因所致。患者应做全面检查,而后
再治不孕之症。

【施治部位】

中极、三阴交、关元、足三里、内关。(见图 74)

75、子宫肌瘤

此病全称为子宫平滑肌瘤,是女性生殖器官中最常见的良性肿瘤,以 40—50 岁的妇女发病率最高,约占 60%,40 岁以下的妇女患此病者极少见。临床表现为子宫出血,腹部有包块,邻近器官有压迫症状,白带增多、不孕、贫血,并伴有心脏功能障碍等,也有全无症状者。磁疗拔罐对子宫肌瘤有良好的治疗效果,方法简便,疗效高,可避免手术之苦。

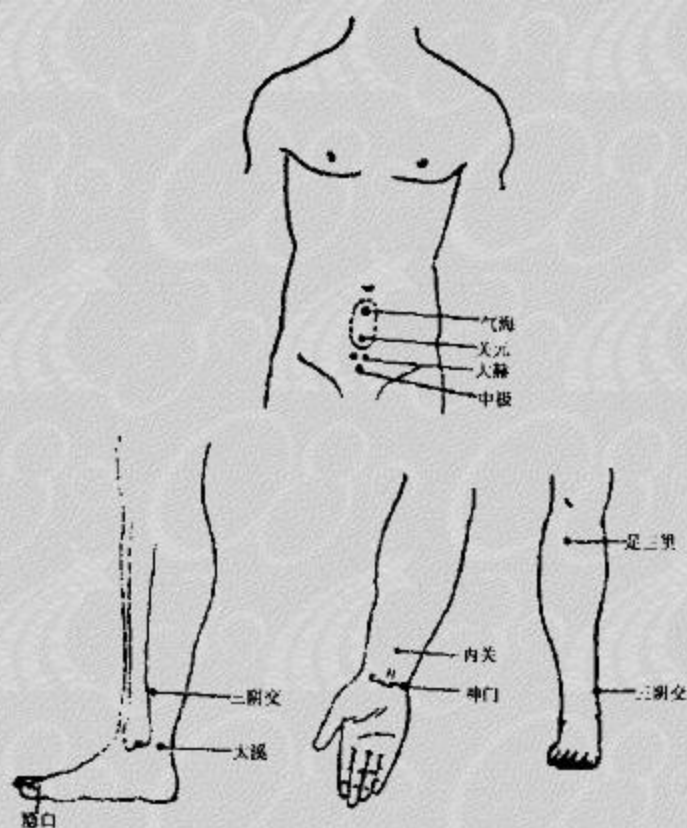
【施治部位】

曲骨、横骨、太溪、三阴交、子宫。(见图 75)

四、五官科疾病

76、急性扁桃体炎

急性扁桃体炎是上呼吸道的溶血性链球菌、肺炎双球菌等致病菌引起的腭扁桃腺的特异性炎症,是上呼吸道感染常见的病症之一,临床上常伴有畏寒发热、咽痛、吞咽痛,查扁桃腺可见红肿甚至化脓。中医认为本病属“乳蛾”、“喉痹”、“喉蛾”等病症范围。



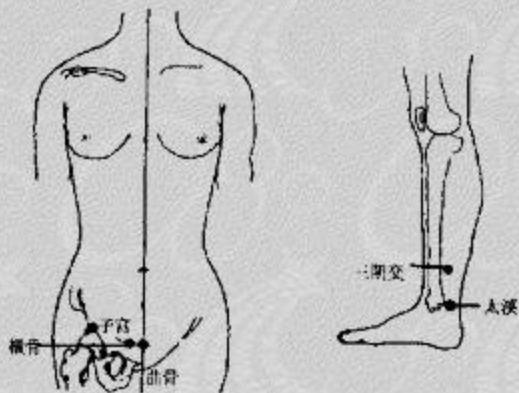
(图 74)

【施治部位】

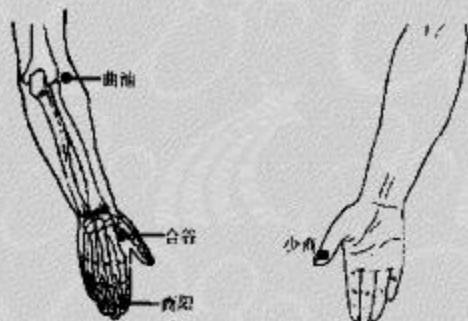
少商、合谷、商阳、阿是穴。(见图 76)

77、急性咽炎

急性咽炎症是咽部粘膜下组织的急性炎症,可由其它传染病继发引起,或由于强刺激食物或烈性气体导致咽部粘膜损伤而引起。主要症状有咽部异物感,干痛灼痛,吞咽不利,咽峡及鼻咽部充血红肿并伴有发热、恶寒、头痛、咳嗽等全身症状。中医属“风热”、“喉痹”范围。



(图 75)



(图 76)

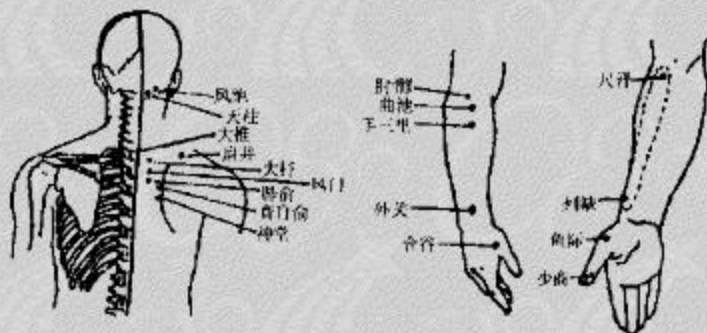
【施治部位】

天突、大椎、合谷、少商、尺泽、内庭、廉泉、阿是穴。(见图 77)

78、慢性咽炎

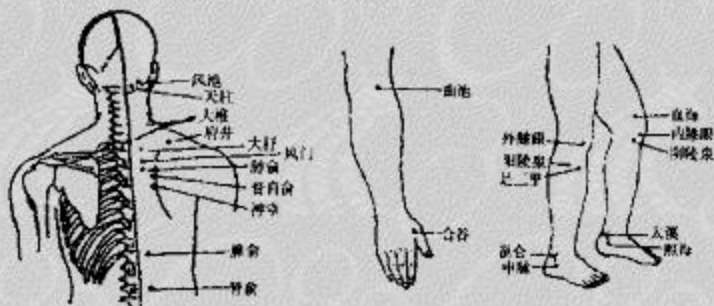
慢性咽炎主要指咽部粘膜、淋巴组织及粘液腺的慢性炎症，多因急性咽炎反复发作，长期烟酒刺激，或化学气体粉尘刺激，发音过度等因素引起。主要症状有咽干、咽痒，吞咽不适，常有“吭”、“咯”类咳发声。检查咽部呈微暗红。中医属“火喉痹”、“珠珀喉痹”等范围。

【施治部位】



(图 77)

1、大椎、肺俞、曲池、足三里、照海。(见图 78-1)



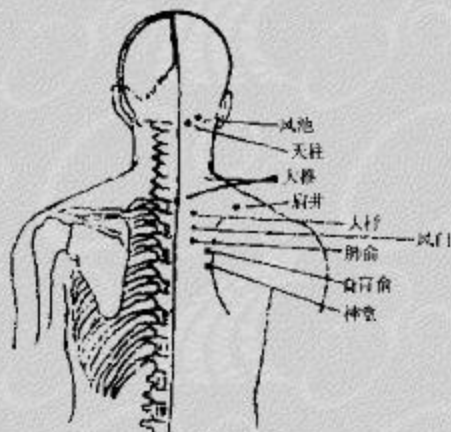
(图 78-1)

操作方法:留罐 15—20 分钟,隔日治疗 1 次,10 次为 1 疗程。

2、大椎、膻中、大杼、肺俞、肾俞。(见图 78-2)

操作方法:拔罐 15 分钟,用三棱针点刺少商、尺泽、商阳穴出血。隔日治疗 1 次。

3、以取颈部咽喉所在局部的皮肤为主,根据辨证配以手太阴、手阳明或足少阴经皮部,用梅花针扣刺后,用拔罐循经密排吸拔,留罐 30 分钟,日 1 次。10 次为 1 疗程。

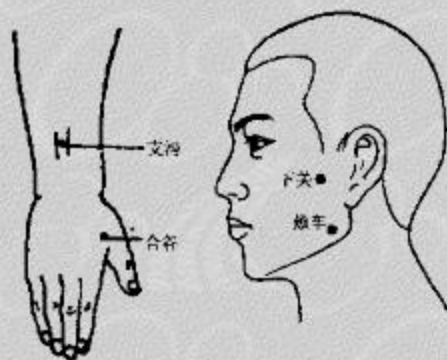


(图 78-2)

牙痛为口腔疾患中常见的症状,大多由龋齿、牙髓炎、牙龈炎、牙周病等所致。中医称之为“齿痛”、“牙痛”。

【施治部位】

1、颊车、下关、合谷。(见图 79-1)



(图 79-1)

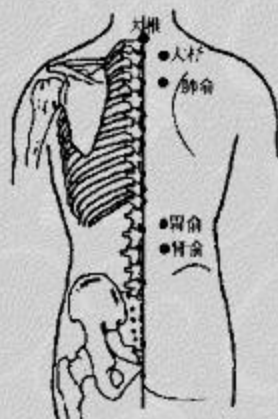
风火牙痛加拔液门、风池;

胃火牙痛加拔内庭；

肾虚牙痛加拔太溪。

操作方法：采用拔罐法留罐 20 分钟，1—2 日治疗 1 次。

2、大椎、胃俞。（见图 79—2）



（图 79—2）

操作方法：（1）用拔罐法拔罐 20 分钟，颊车、内庭穴用三棱针点刺后拔罐 15 分钟，以出血为度，日 1 次，5 次为 1 疗程。（2）取穴：患侧颊车及下关，涂风油精后留罐 15 分钟，然后点刺商阳、合谷穴，出血为度，日 1 次。

80、急、慢性鼻炎

鼻炎是指鼻腔粘膜的炎性病变，包括急性、慢性和副鼻窦炎等，主要症状是鼻塞、流鼻涕，有时伴有头痛等症状。

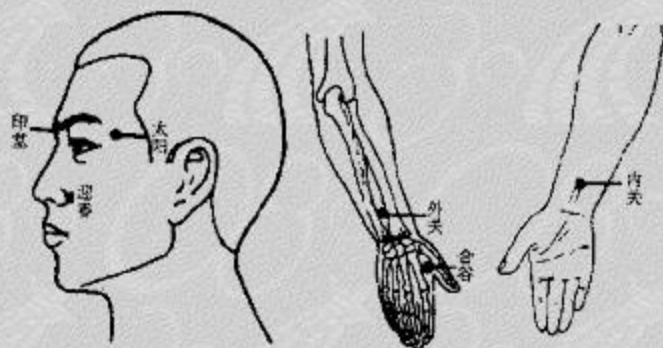
【施治部位】

太阳、印堂、合谷、迎香、内关、外关、阿是穴。（见图 80）

操作方法：每穴拔罐 15 分钟，每天 1—2 次，10 天 1 个疗程。

81、耳鸣、耳聋

耳鸣、耳聋是听觉异常的症状，患者常常自觉耳内鸣响，如闻“呼呼”或“嘶嘶”之声，且终日不绝，妨碍听觉。耳聋的原因较多，也可由耳

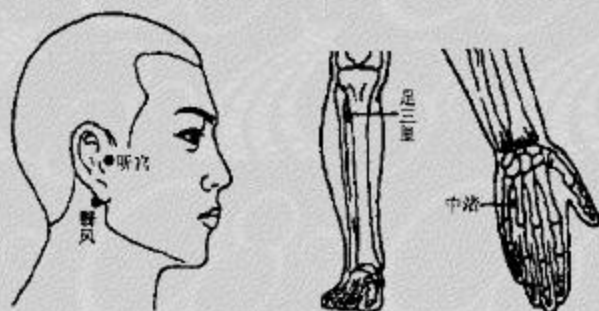


(图 80)

鸣发展而来。

【施治部位】

听宫、翳风、中渚、足三里。(见图 81)



(图 81)

操作方法:每穴拔 15 分钟,每天 1—2 次,10 天为 1 个疗程。

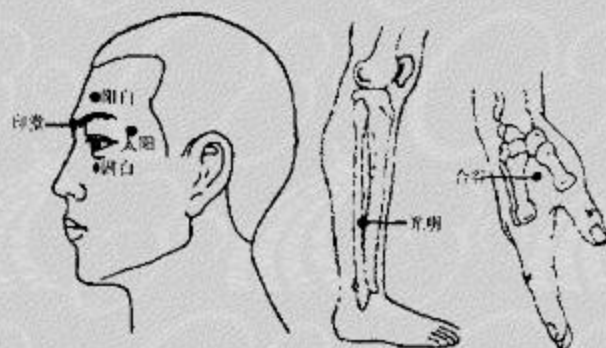
82. 近视

近视是指看近处物体正常,望远处目标模糊不清的一种眼病。凡学龄期儿童、青少年近视,除与先天遗传有一定关系外,主要是由后天性的用眼卫生习惯不良造成的。早期认真按本法拔治,一般 3 个月内即会出现奇迹。年久近视需要耐力,经常坚持。

【施治部位】

太阳、四白、印堂、阳白、光明、合谷。(见图 82)

操作方法:每穴拔 15 分钟,每天 1—2 次,10 天为 1 个疗程。



(图 82)

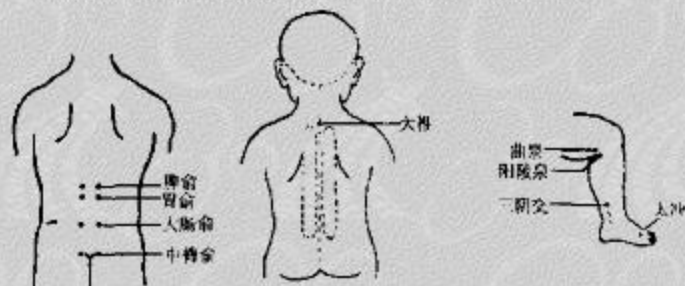
五、 儿科疾病

83、小儿遗尿

凡小儿满 3 岁以上,睡眠时经常不能自行控制排尿的才属病态。偶因疲劳或饮水过多而尿床,不属病态。

【施治部位】

气海、关元、中极、曲泉、阴陵泉、三阴交。(见图 83)



(图 83)

操作方法 1: 每次可从上述穴位中选 3 穴, 用留罐法每穴拔 7—10 分钟。每日一次。

操作方法 2: 可用罐口沿背部足太阳膀胱经和足太阴经刮摩 3—5 分钟。皮肤潮红为度。

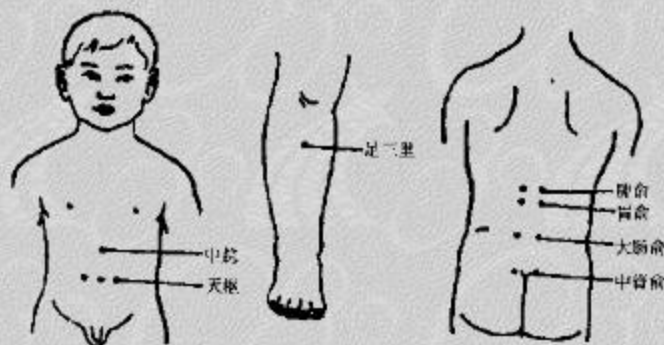
注意事项: 法 1 拔罐要用 3、4 号罐, 不可用大罐。用罐口刮摩皮肤时一定要先涂拔罐油, 防止损伤皮肤。

84、小儿疳疾

小儿疳疾产生于脾胃运行失常, 食物不得消纳, 生化失调, 小儿面黄肌瘦, 毛发不荣, 饮食反常, 肚腹胀满, 精神萎顿。多见于 5 岁以下婴幼儿。

【施治部位】

中脘、天枢、脾俞、胃俞、足三里。(见图 84)



(图 84)

操作方法 1: 每次自上述穴中选 3 个穴位, 用留罐法拔 5—10 分钟。

操作方法 2: 可用罐口沿着背部足太阳膀胱经、足阳明胃经肌肉丰满处刮摩, 以皮肤汗红为度。

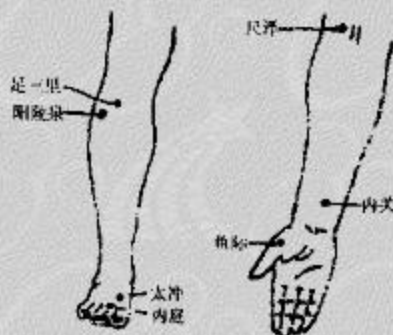
注意事项: 小儿体稚, 拔罐时选用 3、4 号罐且拔吸度不宜过大, 以小儿耐受为度。

85、小儿腹泻

小儿腹泻也称“小儿消化不良”，以大便次数增多，质稀薄或呈水样，带有不消化乳食及粘液便为特征。

【施治部位】

1、天枢、足三里、内关。（见图 85-1）



（图 85-1）

操作方法：伤食型加拔中脘；湿热型加拔大肠俞、大椎；风寒型，加拔上巨虚、三阴交；脾虚型，加拔脾俞、关元俞；脾肾阳虚型加拔神阙、肾俞、命门。采用单纯罐法，或水、药罐法，留罐 5—8 分钟，每日或隔日 1 次。

2、双侧脾俞、胃俞、大肠俞。（见图 85-2）

操作方法：均采用（神阙不针刺）快速针刺后拔罐 5 分钟，以局部皮肤轻度充血为度。日 1 次。

3、（1）水分、天枢、关元；

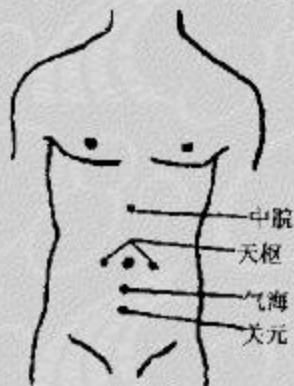
（2）大肠俞、气海俞、关元俞。（见图 85-3）

操作方法：每次取 1 组穴位，施以单纯罐法或水（姜汁）罐法。伴呕吐者，取中脘、膻中、内关施以姜汁罐法。日 1 次或隔日 1 次。

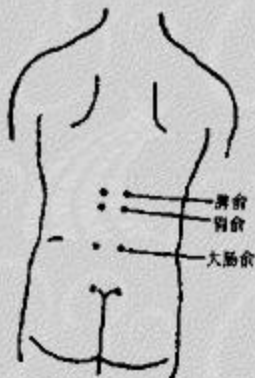
4、龟尾穴（尾骨端与肛门之间）。

操作方法：先按摩 5 分钟，然后用闪火法拔罐 3—5，以充血为度，日 1 次。

5、神阙穴。



(图 85-2)



(图 85-3)

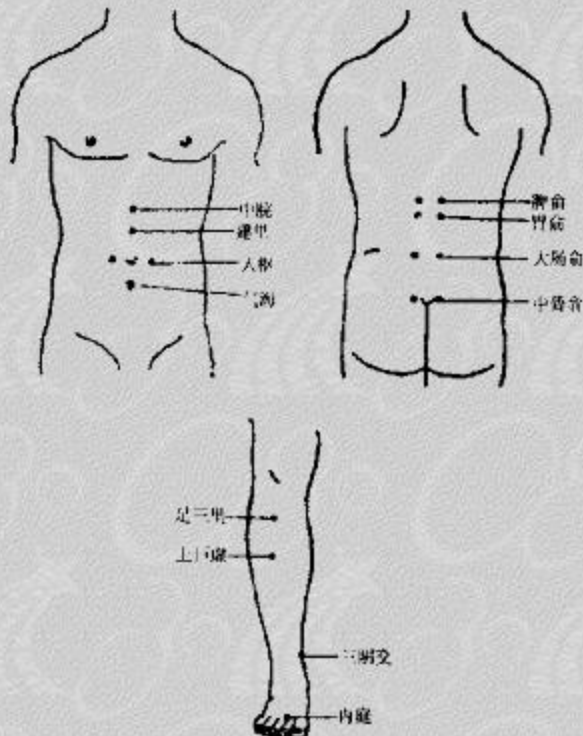
操作方法:随以单纯罐法或温水罐法,留罐 5 分钟,日 1 次。(见图 85-3)

86、小儿厌食

小儿厌食是指不欲饮食,甚至厌食,或伴食后腹胀,形体消瘦,面色萎黄少华等。多由于饮食不节,损伤脾胃,运化失宜,中焦停滞所致。

【施治部位】

中脘、天枢、建里、气海、脾俞、胃俞、足三里。(见图 86)



(图 86)

操作方法：(1) 采用单纯罐法，或刺络拔罐法，留罐 10—15 分钟。可配合三棱针点刺四缝、足三里、穴出血。隔日 1 次。(2) 先用闪火法拔罐于上脘穴 10 分钟，然后用梅花针叩刺脊柱两旁出血，并在胃俞穴上拔罐 10 分钟。可配合三棱针点刺四缝、足三里、穴出血。隔日 1 次。(3) 先取痛部胸椎 8—12 夹脊穴、脾俞、胃俞穴施以走罐，使皮肤充绌发紫；再取中脘、足三里穴拔罐 5—10 分钟，隔日 1 次，5 次为 1 疗程。

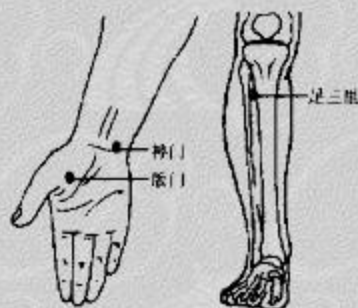
87、小儿营养不良

小儿营养不良是一种常见病，多见于 3 岁以内幼儿喂养不足，消化吸收障碍，以致难以维持正常代谢，而导致本病。主要症状有面色苍白

无华，皮肤干燥，毛发枯黄，食欲不振，腹胀，倦怠无力，手脚冰冷，烦乱萎靡，夜啼、夜尿、盗汗或自汗，常有呕吐腹泻等急性消化功能紊乱症状，甚至智力低下，运动功能发育迟缓。本症因消化道疾病失治或长期嗜食、偏食等不良习惯所致，也可因寄生虫症、慢性消化性疾病而继发本病。中医属“疳积”范围。

【施治部位】

版门、足三里、大都、太白、太溪。（见图 87）



（图 87）

88、小儿咳嗽

感冒咳嗽是小儿常见病。

【施治部位】

天突、大椎。（见图 88）

操作方法：天突穴在颈部，前正中线上，胸骨上窝中央，大椎穴在背上第 7 颈椎棘突下凹陷中。

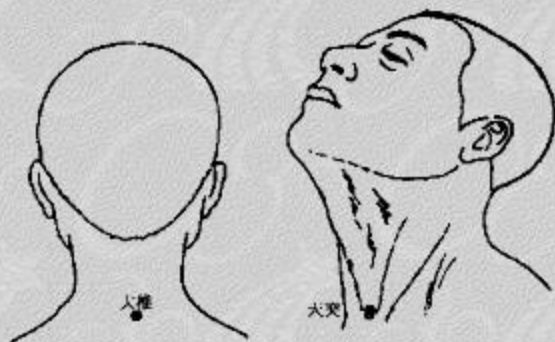
89、小儿麻痹后遗症

小儿麻痹后遗症，又称“脊髓灰质后遗症”。尤以 5 岁以下婴幼儿最多。

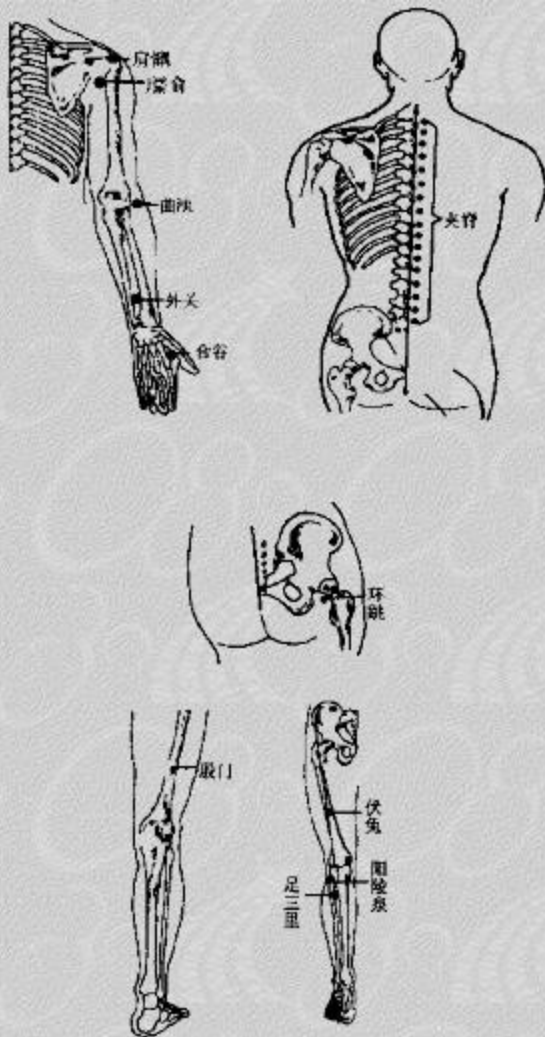
【施治部位】

1、下肢瘫痪：环跳、夹脊、殷门、伏兔、阳陵泉、阿是穴。

2、上肢瘫痪：颈部夹脊穴、膈俞、肩髃、曲池、足三里、合谷、内关、阿是穴。（见图 89）



(图 88)



(图 89)

第六章 拔罐常用经穴

一、常用膻穴

1. 胸腹部膻穴

膻中

【位置】在胸骨上,当两乳头之中间取穴。女子可在第五胸肋关节之间,胸正中线上取穴(图 6-1)。

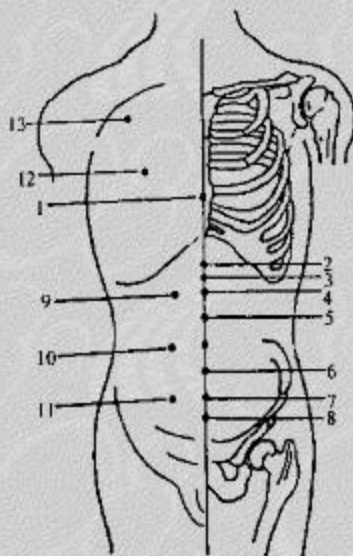


图 6-1 胸腹部膻穴

- 1 膻中 2 巨阙 3 上脘 4 中脘
5 下脘 6 气海 7 关元 8 中极
9 梁门 10 天枢 11 水道
12 阴交 13 中府

【解剖】在胸骨中,相当第五胸肋关节之间,有胸廓(乳房)内动、静脉的前穿支。布有第四肋间神经前皮支的内侧支(内部为心包及心)。

【效能】调气降逆、宽胸利膈。

【主治】支气管哮喘、支气管炎、胸痛、乳腺炎、乳汁不足、肋间神经痛等。

【类别】足太阴、少阴、手太阳、少阳、任脉之会。

巨阙

【位置】前正中线，胸骨剑突下，脐上6寸处(图6-1)。

【解剖】在腹白线中，有腹壁上动、静脉分支。布有第七肋间神经前皮支的内侧支。

【效能】宁神调气，和胃利膈。

【主治】心脏病、心绞痛、精神病、癫痫、胃痛、呕吐、膈肌痉挛、胆道蛔虫症等。

【类别】任脉；心之募穴。

上脘

【位置】前正中线，脐上4寸(图6-1)。

【解剖】在腹白线中，有腹壁上动、静脉分支。布有第七肋间神经分支。

【效能】调胃理气，化湿降逆。

【主治】急(慢)性胃炎、胃扩张、胃痉挛、贲门痉挛等。

【类别】足阳明、手太阳、任脉之会。

中脘

【位置】前正中线，脐上4寸(图6-1)。

【解剖】在腹白线中，有腹壁上动、静脉。布有第七肋间神经前皮支的内侧支(当胃幽门部)。

【效能】调胃理气，化湿降逆。

【主治】胃炎、胃溃疡、胃下垂、急性肠梗阻、胃痛、呕吐、腹胀、腹泻、便秘、消化不良。

【类别】足阳明、任脉之会。

下脘

【位置】腹正中线，脐上2寸(图6-1)。

【解剖】在腹白线中，有腹壁上动、静脉，布有肋间神经前皮支的内侧支。

【效能】调胃理气、通调肠腑。

【主治】胃扩张、胃痉挛、慢性胃炎、消化不良、肠炎、便秘。

【类别】任脉。

气海

【位置】前正中线，脐下1.5寸(图6-1)。

【解剖】在腹白线中，有腹壁浅动、静脉分支及腹壁下动、静脉分支。布有第十一肋间神经前皮支的内侧(内部为小肠)。

【效能】调气机、补肾虚。

【主治】神经衰弱、腹胀、腹前、月经不调、痛经、肠麻痹、阳痿、遗精、遗尿、尿闭等。

【类别】任脉。

关元

【位置】前正中线，脐下3寸(图6-1)。

【解剖】在腹白线中，有腹壁浅及腹壁下动、静脉分地。布有第十二肋间神经前皮支的内侧支(内部为小肠)。

【效能】培肾固本、调气回阳。

【主治】腹痛、腹泻、痢疾、肾炎、尿路感染、痛经、白带多、盆腔炎、月经不调、功能性子宫出血、子宫脱垂、阳痿、遗精、遗尿、肠道蛔虫、神经衰弱等。

【类别】足三阴、任脉之会；小肠之募穴。

中极

【位置】前正中线，脐下4寸(图6-1)。

【解剖】在腹白线中，有腹壁浅动、静脉分支及腹壁下动、静脉分支。布有髂腹下神经的分支。(内部为乙状结肠)。

【效能】助气化、调胞宫、利湿热。

【主治】遗精、遗尿、尿闭、阳痿、早泄、月经不调、白带过多、不孕、尿路感染、盆腔炎、痛经、膀胱炎等。

【类别】足三阴、任脉之会；膀胱之募穴。

梁门

【位置】脐上4寸，距中线旁开2寸(图6-1)。

【解剖】当腹直肌及其腱鞘处，深层为腹横筋膜。有第七肋间动、静脉之支及腹壁上动静脉。布有第八肋间神经分支处(右侧深部当肝下缘、胃幽门部)。

【效能】调胃理气。

【主治】胃痛、溃疡病、急(慢)性胃炎、胃神经症等。

【类别】足阳阴胃经。

天枢

【位置】平脐旁开2寸(图6-1)。

【解剖】当腹直肌及其鞘处。布有第九肋间动、静脉及腹壁下动、静脉分支，布有第十肋间神经分支(内部为小肠)。

【效能】疏调肠腑、理气消滞。

【主治】急(慢)性胃炎、急(慢)性肠炎、菌痢、肠麻痹、便秘、肠道蛔虫症、腹膜炎、痛经等。

【类别】足阳明胃经；大肠之募穴。

水道

【位置】脐下3寸，中线旁开2寸(图6-1)。

【解剖】当腹直肌及其鞘处。有十二肋间动、静脉分支，外侧为腹壁下动、静脉。布有第十二肋间神经(内部为小肠)。

【效能】清湿热、利膀胱。

【主治】肾炎、膀胱炎、尿闭、腹水、睾丸炎等。

【类别】足阳明胃经。

膻窗

【位置】乳中线上第三肋间，距中线旁开4寸(图5-1)。

【解剖】在第三、四肋之间，胸大肌中，深部为肋间肌，有肋间动、静脉。布有胸前神经和肋间神经(内部为肺脏)。

【效能】宣肺、理气、通络。

【主治】肺炎、胸膜炎、乳腺炎、乳汁不足、胸痛、喘咳。

【类别】足阳明胃经。

中府

【位置】锁骨外端下约1寸处(图6-1)。

【解剖】当胸大、小肌处，深部为第一、第二肋间内、外肌。上外侧有腋动、静脉。布有锁骨上神经中间支，胸前神经的分支及第一肋间神经。

【效能】宣肺理气。

【主治】支气管炎、肺炎、哮喘、肺结核、胸痛等。

【类别】手足太阴之会；肺之募穴。

2、背腰部腧穴

大椎

【位置】在第七颈椎与第一胸椎棘突间正中处(图6-2)。

【解剖】在棘上韧带及棘间韧带中，有棘突间皮下静脉丛。布有第八颈神经后支内侧支。

【效能】解表通阳、安神益髓。

【主治】发烧、精神病、癫痫、喘咳、血液病、消化系统病、皮肤病、痿痹及一切虚弱症等。

【类别】手足三阳、督脉之会。

身柱

【位置】在第三胸椎与第四胸椎棘突之间(图6-2)。

【解剖】在棘上韧带及棘间韧带中。为第三肋间动、静脉，布有第三胸神经。

【效能】宣肺通阳、宁神益髓。

【主治】支气管炎、肺炎、神志疾病、痿痹、发热等。

【类别】督脉。

神道

【位置】在第五胸椎与第六胸椎棘突之间(图6-2)。

【解剖】在第五、六胸椎棘突之间，斜方肌及大菱形肌起始部，有肋间动、静脉后支，布有第五胸神经后支之内侧支。

【效能】理气血、宁心神。

【主治】心脏病、神经衰弱、瘰癧、心动过速、神志疾病等。

【类别】督脉。

灵台

【位置】在第六胸椎与第七胸椎棘突之间(图6-2)。

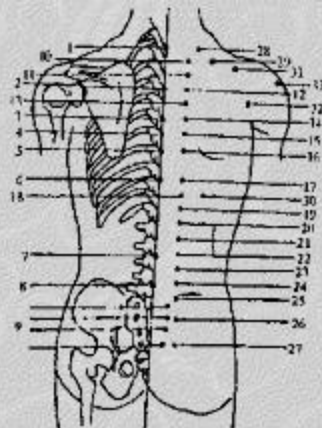


图 6-2 背腰部腧穴

- 1 大椎 2 身柱 3 神道 4 灵台 5 至阳
 6 筋缩 7 命门 8 阳关 9 八邪 10 大杼
 11 风门 12 肺腧 13 厥阴腧 14 心腧
 15 督腧 16 膈腧 17 肝腧 18 胆腧
 19 脾腧 20 胃腧 21 三焦腧 22 肾腧
 23 气海腧 24 大肠腧 25 关元腧
 26 膀胱腧 27 白环腧 28 肩中腧
 29 肩外腧 30 阳纲 31 天宗 32 肩贞 33 肩髃

【解剖】在棘上韧带及棘间韧带中，为第六肋间动脉后支及棘突间皮下静脉丛分布。布有第六胸神经后支内侧支。

【效能】理气血、宁心神。

【主治】心脏病、神志病、咳嗽、哮喘、疔疮、胆道蛔虫、胃痛、疟疾等。

【类别】督脉。

至阳

【位置】在第七胸椎与第八胸椎棘突之间(图 6-2)。

【解剖】在棘上韧带及棘间韧带中，有第七肋间动后支，棘间皮下

静脉从颈。布有第七胸神经后支内侧支。

【效能】理气机、化湿热、宽胸膈。

【主治】肝炎、胆囊炎、疟疾、胃痛、胆道蛔虫症、肋痛等。

【类别】督脉。

筋缩

【位置】在第九胸椎与第十胸椎棘之间(图6-2)。

【解剖】在棘上韧带及间韧带中。有肋间动脉后支。布有胸神经后支。

【效能】解痉活血、舒筋醒神。

【主治】痲痛、腰背神经痛、强直性痉挛、神经衰弱等。

【类别】督脉。

命门

【位置】在第二腰椎与第三腰椎棘突之间(图6-2)。

【解剖】有腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带。有腰动脉后支及棘突间皮下静脉丛。布有腰神经后支内侧支。

【效能】培元补肾、通利腰脊。

【主治】遗尿、遗精、阳痿、白带、子宫内膜炎、盆腔炎、肾炎、脊柱炎、头痛等。

【类别】督脉。

阳关

【位置】第四腰椎与第五腰椎棘突之间(图6-2)。

【解剖】有腰筋膜，棘上带及棘间带，有腰动、静脉后支，棘突间皮下静脉丛。布有腰神经后支内侧支。

【效能】调肾气、利腰膝、祛寒湿。

【主治】腰骶神经痛、下肢瘫痪、风湿性关节炎、月经不调、遗精、阳痿、慢性肠炎等。

【类别】督脉。

八髻

【位置】上、次、中、下左右共八穴合称八髻。上髻在第一骶后孔中；次髻在第二骶后孔中；中髻在第三骶后孔中；下髻在第四骶后孔中(6-1)

【解剖】在骶棘肌及大肌起部，第1—4骶后孔处，有第1—4骶神经后支及其伴行的动、静脉。

【主治】遗尿、遗精、阳痿、月经不调、白带、盆腔炎、睾丸炎、引产、腰骶关节疾病、坐骨神经痛、下肢瘫痪等。

【类别】足太阳膀胱经；上为足太阳，少阳之络；中为足厥阴，少阳所结之会。

大杼

【位置】第一胸椎棘突下旁开1.5寸处(图6—2)。

【解剖】有斜方肌、菱形肌、上后锯肌，最深层为最长肌。有第一肋间动、静脉后支，布有第一胸神经后支内侧支，深层为第一胸神经后支外侧支。

【效能】宣肺、疏风、调气。

【主治】感冒、支气管炎、肺炎、胸膜炎、项背痛、关节痛、哮喘、肢体麻木等。

【类别】手足太阳、少阳之会；督脉别络、骨会。

风门

【位置】第二胸椎棘突下旁开1.5寸处(图6—2)。

【解剖】有斜方肌、菱形肌、上后锯肌，深层为最长肌。有第二肋间动、静脉后支的内侧支。布有第二胸神经后支，内侧皮支，深层为第二神经后支外侧支。

【效能】宣肺、疏风、调气。

【主治】感冒、支气管炎、肺炎、胸膜炎、哮喘、荨麻疹、肩背痛等。

【类别】督脉，足太阳之会。

肺俞

【位置】第三胸椎棘突下旁开1.5寸处(图6—2)。

【解剖】有斜方肌、菱形肌，深层为最长肌。有第三肋间动、静脉后支的内侧支。布有第三胸神经后支的内侧支，深层为第三胸神经后的外侧支。

【效能】宣肺理气、退热驱风。

【主治】支气管炎、肺炎、哮喘、肺结核、胸膜炎、自汗、盗汗、皮肤病、鼻病等。

【类别】足太阳膀胱经。

厥阴俞

【位置】第四胸椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】有斜方肌、菱形肌，深层为最长肌。布有第四肋间动、静脉后支的内侧支。正当第四胸椎神经后支的内侧支，深层为第四胸神经后支的外侧支。

【效能】宁心安神、理血调气。

【主治】心脏病、神志病、肋间神经痛、呃逆等。

【类别】足太阳膀胱经。

心俞

【位置】第五胸椎棘突下旁开 1.5 寸(图 6-2)。

【解剖】有斜方肌、菱形肌，深层为最长肌。有第五肋间动、静脉后支的内侧支。布有第五胸神经后支，内侧支，深层为第五胸神经后支外侧支。

【效能】宁心安神、理血调气。

【主治】心脏病、心动过速、心律不齐、神志疾病、肋间神经痛等。

【类别】足太阳膀胱经。

督俞

【位置】第六胸椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】有斜方肌、背阔肌肌腱、最长肌。有第六肋间动、静脉后支的内侧支，颈横动脉降支。布有肩胛背经，第六胸神经后支骨侧支，深层为第六胸神经后支外侧支。

【效能】宁心调气、理血驱风。

【主治】心脏病、腹痛、肠鸣、膈肌痉挛、脱发、皮肤病、乳腺炎等。

【类别】足太阳膀胱经。

膈俞

【位置】第七胸椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在斜方肌下缘，有背阔肌、最长肌。有第七肋间动、静脉后

支的内侧支。布有第七胸神经后支内侧支，深层为第七胸神经后支外侧支。

【效能】理血化瘀、宽胸补虚。

【主治】贫血、慢性出血性疾病、膈肌痉挛、呕吐、食道疾病、淋巴结结核、荨麻疹等。

【类别】足太阳膀胱经。

肝俞

【位置】第九胸椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6—2)。

【解剖】在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间。有第九肋间动、静脉后支的内侧支。布有第九胸神经后支内侧支，深层为第九胸神经后支外侧支。

【效能】利肝胆、清湿热、调气滞、明眼目。

【主治】急(慢)性肝炎、胆囊炎、胰腺炎、胃病、肋间神经痛、月经不调、血液病、神志病、眼病、筋病等。

【类别】足太阳膀胱经。

胆俞

【位置】第十胸椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6—2)。

【解剖】在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间。有第十肋间动、静脉后支的内侧支。布有第十胸神经后支内侧支，深层为第十胸神经后支外侧支。

【效能】清泄肝胆热邪、和胃理气宽膈。

【主治】肝炎、胆囊炎、胃炎、胆道蛔虫症、腹胀、胸肋痛。

【类别】足太阳膀胱经。

脾俞

【位置】第十一胸椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6—2)。

【解剖】在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间。有第十一肋间动、静脉后支的内侧支。布有第十一胸神经后支内侧支，深层为第十一胸神经后支外侧支。

【效能】调脾气、助运化、除水湿、和营血。

【主治】胃炎、溃疡病、胃下垂、呕吐、消化不良、肝炎、肠炎、浮肿、

贫血、肝脾肿大、慢性出血性疾病、子宫脱垂、荨麻疹、肢体乏力等。

【类别】足太阳膀胱经。

胃俞

【位置】第十二胸椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在腰背筋膜、最长肌和髂肋肌之间。有肋下动、静脉后支的内侧支。布有第十二胸神经后支内侧支，深层为第十二胸神经后支外侧支。

【效能】调胃气、化湿滞。

【主治】胃炎、胃扩张、胃下垂、胃溃疡、胃疼、肠炎、肝炎、胰腺炎、食欲不佳等。

【类别】足太阳膀胱经。

三焦俞

【位置】第一腰椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在腰背筋膜、最长肌和髂肋肌之间。有第一腰动、静脉后支的内侧支。布有第十胸神经后支内侧支末端，深层为第一腰神经后支外侧支。

【效能】调化、利水湿。

【主治】胃炎、肠炎肾炎、腹水、尿闭、遗尿、神经衰弱、腰痛等。

【类别】足太阳膀胱经。

肾俞

【位置】第二腰椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在腰背筋膜、最长肌和髂肋肌之间。有第二腰动、静脉后支的内侧支。布有第一腰神经后支内侧支，深层为第一腰神经后支外侧支。

【效能】调肾气、强腰脊、明耳目。

【主治】肾炎、肾绞痛、遗精、遗尿、阳痿、月经不调、哮喘、耳聋、耳鸣、脱发、贫血、腰痛等。

【类别】足太阳膀胱经。

气海俞

【位置】第三腰椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在腰背筋膜、最长肌和髂肋肌之间。有第三腰动、静脉后支。布有第二腰神经后支内侧支，深层为第一腰神经后支外侧支。

【效能】调气血、健腰膝。

【主治】月经不调、功能性子宫出血、下肢瘫痪、腰脊痛、痔疮等。

【类别】足太阳膀胱经。

大肠俞

【位置】第四腰椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在腰背筋膜、最长肌和髂肋肌之间。有第四腰动、静脉后支。布有第三腰神经后支。

【效能】调肠腑、利腰膝。

【主治】肠炎、痢疾、便秘、腰腿痛、腰扭伤、骶髂关节痛等。

【类别】足太阳膀胱经。

关元俞

【位置】第五腰椎棘突下旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】有骶髂肌。有第五腰动、静脉后支。布有第五腰神经后支。

【效能】理下焦、健腰膝、化湿带。

【主治】慢性肠炎、慢性盆腔炎、膀胱炎、糖尿病、遗尿、遗精、阳痿、腰痛等。

【类别】足太阳膀胱经。

膀胱俞

【位置】平第二骶后孔，背正中线旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在骶棘肌起部和臀大肌起部之间，有骶外侧动、静脉后支的外侧支。布有第一、二骶神经后外侧支，并有交通支与第一骶神经交通。

【效能】生殖(泌尿)系统病、腹泻、便秘、腰骶痛、坐骨神经痛等。

【类别】足太阳膀胱经。

白环俞

【位置】平第四骶后孔，背正中线旁开 1.5 寸处(图 6-2)。

【解剖】在臀大肌、骶结节韧带下内缘。动、静脉，深层为阴部内动、静脉。布有臀下神经，其深层为阴部神经。

【效能】理下焦、利腰腿。

【主治】坐骨神经痛、腰痛、子宫内膜炎、肛门疾患、小儿麻痹后遗症等。

【类别】足太阳膀胱经。

阳维

【位置】第十胸椎棘突下旁开3寸处(图6-2)。

【解剖】在第10-11胸椎棘突间的外方，背阔肌中，有助间动、静脉后支。布有胸神经后支。

【效能】利肝胆、调脾胃。

【主治】肝胆疾病、蛔虫症、胃痉挛、消化不良、腹胀、肠鸣等。

【类别】足太阳膀胱经。

天髻

【位置】在肩井穴之下约1寸处(图6-2)。

【解剖】在肩胛骨的上部岗上窝中，表层为斜方肌，深部为岗上肌。有肩胛上动、静脉。布有锁骨上神经和副神经。

【主治】颈项部疼痛与痉挛、肩背部冷痛、举臂障碍等。

【类别】手少阳三焦经。

3. 侧面腧穴

期门

【位置】乳头正下方，第六肋间隙，肋弓边缘(图6-3)。

【解剖】在第九肋软骨附着部下，表层有腹外肌，中层为腹内斜肌，深层为腹横肌，有腹壁上动、静脉。布有助间神经外侧皮支。

【效能】疏肝利气、化积通瘀。

【主治】肝炎、肝肿大、胆囊炎、胸膜炎、肋间神经痛、吞酸、神经官能症等。

【类别】足太阴、厥阴、阴维之会；肝之募穴。

日月

【位置】期门穴下1寸5分处(图6-3)。

【解剖】在第九肋软骨下，腹外斜肌中。有腹壁上动、静脉。布有助间神经的外侧皮支。

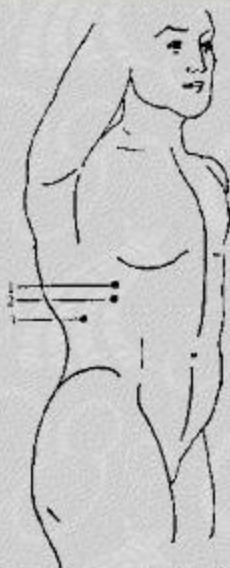


图 6-3 侧面膈穴
1 期门 2 日月 3 京门

【效能】利胆疏肝、开郁理气。

【主治】足少阳胆经；胆之募穴。

京门

【位置】在第十二肋软骨尖端(图 6-3)。

【解剖】在第十二软骨尖端，腹外斜肌和腹内斜肌中。有腹壁上动、静脉之分支。布有肋间神经。

【效能】益肾、理气、行气

【主治】肾炎、腰痛、肠神经痛、腹胀、肠鸣、胁痛。

【类别】足少阳胆经。

4、肩部及上肢腧穴

肩井

【位置】大椎穴与肩峰连线的中点。

【解剖】有斜方肌，深层为肩胛提肌与岗上肌。有颈横动、静脉；布有腋神经分支，深层上方为桡神经。

【主治】头项强痛，肩背疼痛，上肢不随，难产，乳痈，乳汁不下，瘰癧。

【类别】足少阳胆经。

天宗

【位置】肩胛骨岗下窝的中央

【解剖】在岗下窝中央岗下肌中。有旋肩胛动、静脉肌支，布有肩胛上神经。

【主治】肩胛疼痛，气喘，乳痈。

【类别】手太阳小肠经

肩中俞

【位置】第七颈椎棘突下旁开2寸处(图6-2)。

【解剖】在第一胸椎横突端，表层为斜方肌，深层为提肩胛肌。有颈横动、静脉。布有第一胸神经后支内侧支，肩胛背神经和副神经。

【效能】理气活络。

【主治】咳嗽，哮喘，肩背痛，落枕。

【类别】足太阳小肠经。

肩外俞

【位置】第一胸椎棘突下，距中线旁开3寸处(图6-2)。

【解剖】在肩胛骨内侧角，表层为斜方肌，深层为提肩胛肌和小菱形肌。有颈横动、静脉。布有第六、七颈神经后支，肩胛背神经和副神经。

【效能】理气血、活络。

【主治】咳嗽，肩背痛、上肢疾病。

【类别】足太阳小肠经。

肩髃

【位置】三角肌上部的中点，肩峰与肱骨大结节之间，肩平举时陷处(图6-2)。

【解剖】在肩峰与肱骨大结节之间，三角肌上部中央。有旋肱后动、

静脉。布有锁髓上神经及腋神经。

【效能】通脉络，利关节。

【主治】中风偏瘫、肩关节疼、肩关节周围炎、上肢疾病。

【类别】手阳明大肠经，阳跷之会。

肩贞

【位置】在腋缝尽端上1寸处(图6-2)。

【解剖】在肩关节后下方，肩胛骨外侧缘，三角肌后缘，下层是大圆肌。有旋肱后动脉。深部有腋神经，浅部有臂背侧、内侧皮神经及肋间神经外侧皮上。

【效能】通窍活络。

【主治】耳鸣、耳聋、肩胛痛、上肢麻痹与疼痛。

【类别】属手少阳小肠经。

曲池

【位置】屈肘，成直角，当时横纹外端与肱骨外上髁连线的中点。

【解剖】桡侧腕长伸肌起始部，肱桡肌的桡侧；有桡反动脉的分支布有前臂背侧皮神，内侧深层为桡神经本干。

【主治】咽喉肿痛，齿痛，目赤痛，上肢不遂，高血压。

【类别】手阳明大肠经。

郄门

【位置】腕横纹上5寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

【解剖】有指浅屈肌，深部为指深屈肌。

【主治】心痛，心慌，咳血，癫痫。

【类别】手厥阴心包经。

内关

【位置】腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

【解剖】有指浅屈肌，深部为指深屈肌。

【主治】心痛，心慌，胸闷，胃痛，呕吐，咳血，癫痫，偏头痛，偏瘫，失眠，眩晕。

【类别】手厥阴心包经。

外关

【位置】腕背横纹上2寸，桡骨与尺骨之间。

【解剖】在指总伸肌和拇长伸肌之间。

【主治】热病，头痛，上肢麻痹与疼痛，咽喉肿痛，齿痛，目赤痛，上肢不遂，高血压。

【类别】手少阳三焦经。

劳宫

【位置】第二、三掌骨之间，握拳，正对中指指尖下。

【解剖】第二、三掌骨之间，下为掌腱膜，第二蚓状肌及指浅、深屈肌腱，深层为拇收肌横头的起部，有骨间肌，有指掌侧总动脉，布有正中神经。

【主治】心痛，呕吐，癫狂，口疮，口臭。

【类别】手厥阴心包经。

5、下肢腧穴

髀关

【位置】髂前上棘直下，平臀处(图6-4)。

【解剖】在股骨大转子的前下方，缝匠肌和张阔筋膜肌之间。深层有旋股外侧动、静脉分支，布有股外侧皮神经。

【效能】舒筋活络。

【主治】下肢麻痹、瘫痪、腹股沟淋巴腺炎、腰痛等。

【类别】足太阳胃经。

伏兔

【位置】髌骨外上缘直上6寸(图6-4)。

【解剖】在股骨前外侧，股直肌的肌腹中。有旋股外侧动、静脉分支。布有股前皮神经，当股外侧皮神经处。

【效能】舒筋活络。

【主治】下肢瘫痪、麻痹、膝关节炎、风湿性肌炎等。

【类别】足阳明胃经。

秩边

【位置】第四骶椎棘突旁开3寸(图6-5)。

【解剖】有臀大肌，在梨状肌下缘。正当臀下动、静脉。深层当臀下



图 6-4 下肢前侧俞穴

1 解关 2 伏兔 3 鹤顶



图 6-5 下肢后侧俞穴

1 秩边 2 殷门

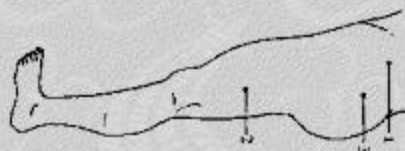


图 6-6 下肢外侧俞穴

1 居髎 2 风市 3 环跳

图 6-4

神经及股后皮神经，外侧为坐骨神经。

【效能】舒筋活络，益肾强腰。

【主治】坐骨神经痛、腰骶痛、臀肌劳损、下肢瘫痪、肛门和生殖器疾病等。

【类别】足太阳膀胱经。

殷门

【位置】大腿后侧正中中部(图 6-5)。

【解剖】在股骨后面的中央部，半腱肌中。外侧为股深动、静脉第三

穿支。布有股后皮神经，深层正当坐骨神经。

【效能】舒筋络、强腰腿。

【主治】腰背痛、坐骨神经痛、下肢麻痹、瘫痪、下肢疼痛等。

【类别】足太阳膀胱经。

居髃

【位置】在髂前上棘与大转子最高点连线中点(图6-6)。

【解剖】在阔筋膜前缘，深部为股外侧肌。有旋髂浅动、静脉分支及旋外侧动、静脉升支。当股外侧皮神经处。

【效能】理气血、通脉络。

【主治】上下腹前、睾丸炎、子宫内膜炎、膀胱炎、腰痛、髋关节及周围软组织疾病。

【类别】足少阳，阳跷之会。

风市

【位置】在大腿外侧中线，髌骨上7寸，或直立时手臂下垂，中指指尖所点处(图6-6)。

【解剖】在阔筋膜下，股外侧肌中。有旋股外侧动、静脉肌支。布有股外侧皮神经，股神经肌支。

【效能】舒活络。

【主治】下肢麻痹、瘫痪、腰腿痛、股外侧皮神经炎等。

【类别】足少阳胆经。

环跳

【位置】在股骨大转子最高点与骶骨裂孔连线的外1/3与内2/3交界处(图6-6)。

【解剖】在臀大肌，梨状肌下缘。内侧为臀下动、静脉。布有臀下皮神经，臀下神经，深部正当坐骨神经。

【效能】利腰腿，通经络。

【主治】坐骨神经痛、腰骶神经根炎、下肢麻痹、瘫痪、腰腿痛、髋关节及周围软组织疾病等。

【类别】足少阳，太阳之会。

鹤顶

【位置】髌骨上缘正中(图6-4)。

【解剖】在髌骨上缘,股四头肌腱中,有膝关节动、静脉网。布有股神经前反支。

【效能】舒筋活络。

【主治】膝关节炎、下肢麻痹疼痛、下肢肌无力等。

【类别】经外奇穴。

血海

【位置】髌骨内上缘上2寸。

【解剖】在股骨内上髁上缘,股内侧肌中间,有股动、静脉肌支,布有股前皮神经及股神经肌支。

【主治】月经不调,崩漏,闭经,隐疹,湿疹,丹毒。

【类别】足太阴脾经。

阴市

【位置】在髌骨上棘与髌骨外缘连线上,髌骨外上缘上3寸。

【解剖】在股直肌和股外侧肌之间;有旋骨外侧动脉降支,布有股前皮神经,股外侧皮神经。

【主治】腿膝痿痹,屈伸不利,疝气,腹胀腹痛。

【类别】足阳明胃经。

梁丘

【位置】在髌骨上棘与髌骨外缘连线上,髌骨外上缘上2寸。

【解剖】同阴市穴。

【主治】膝肿痛,下肢不遂,胃痛,乳痈,血尿。

【类别】足阳明胃经。

阴陵泉

【位置】胫骨内侧髁下缘凹陷中。

【解剖】在胫骨后缘和腓肠肌之间,比目鱼肌起点上;前方有大隐静脉,膝最上动脉,最深层有胫后动、静脉,布有小腿内侧皮神经本干,最深层有胫神经。

【主治】腹胀,泄泻,水肿,黄疸,小便不利或失禁,膝痛,下肢痹痛。

【类别】足太阴脾经。

阳陵泉

【位置】胫骨小头前下方凹陷中。

【解剖】当腓骨长、短肌中；有膝下外侧动、静脉；当腓总神经分为腓浅及腓深神经处。

【主治】胁痛，口苦，呕吐，下肢痹痛，黄疸，脚气，小儿惊风。

【类别】足少阳胆经。

委中

【位置】腘横纹中央。

【解剖】在腘窝正中，有筋膜，皮下有股国静脉，深层内侧有股静脉，最深层为国动脉，有股后皮神经，正当胫神经处。

【主治】腰痛，腹胀，泄泻，下肢痿痹，腹痛，吐泻，小便不利，遗尿，丹毒。

【类别】足太阳膀胱经。

足三里

【位置】外膝眼下3寸，胫骨前嵴外一横指处。

【解剖】在胫骨前肌，趾长伸肌腱之间；有胫前动、静脉，为腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支分布处，深层当腓深神经。

【主治】胃痛，呕吐，腹胀，泄泻，痢疾，便秘，乳癌，下肢痹痛，水肿，癫狂，脚气，虚劳羸瘦，小便不利。

【类别】足阳明胃经

承山

【位置】腓肠肌两肌腹之间凹陷的顶端。

【解剖】在腓肠肌两肌腹交界下端，有小隐静脉，布有腓肠内侧皮神经，深层为胫神经。

【主治】痔疮，脚气，便秘，腰腿拘急疼痛。

【类别】足太阳膀胱经。

三阴交

【位置】内踝高点上3寸，胫骨内侧面后缘。

【解剖】在胫骨后缘和比目鱼肌之间，深层有屈趾长肌。有大隐静脉，胫后动、静脉，布有小腿内侧皮神经，深层后方有胫神经。

【主治】肠鸣腹胀，泄泻，月经不调，带下，不孕，遗精，阳痿，早泄，失眠，下肢萎痹，脚气。

【类别】足太阴脾经

涌泉

【位置】足底(去趾)前1/3处，足趾跖屈时呈凹陷。

【解剖】在足底第二、三跖骨之间，跖腱膜中，内有跖短屈肌腱，跖长屈肌腱，第二蚓状肌，深层为骨间肌，深层有来自胫前动脉的足底弓，布有足底内侧神经分支。

【主治】头痛，头昏，失眠，目眩，咽喉肿痛，失音，便秘，小便不利，小儿惊风，癲狂，昏厥。

【类别】足少阴肾经。

二、拔罐疗法必选腧穴

拔罐疗法，属于祖国医学外治法的一种。因此它亦是以中医辨证论治为依据，以经络为基础，结合现代医学理论，少而精地选取相应俞穴。现将其必选俞述如下：

一、全身疾病：必选俞穴大椎、身柱。

二、下半身疾病：必选俞穴命门。

三、呼吸系统疾病：风门、肺俞、脾俞、中府、膻中。

四、循环系统疾病：心俞、厥阴俞、脾俞、肝俞、督俞、神道、灵台、巨阙。

五、胃病：膈俞、肝俞、脾俞、胃俞、中脘、上脘。

六、肠道病：脾俞、三焦俞、大肠俞、天枢、关元。

七、肝胆疾病：肝俞、胆俞、脾俞、中脘、至阳、期门、阿是穴。

八、生殖(泌尿)疾病：肝俞、脾俞、肾俞、膀胱俞、关元、中极。

九、内分泌系统疾病：肺俞、心俞、肝俞、脾俞、肾俞、中脘、关元。

十、神经系统疾病：心俞、厥阴俞、神道、灵台、肝俞、脾俞、肾俞。

十一、脑血管疾病：心俞、厥阴俞、肝俞、脾俞、神道、灵台。

十二、运动系统疾病：

上肢范围：肩髃、肩贞、肩中俞、肩外俞、阿是穴。

下肢范围：肾俞、命门、八髎、秩边、环跳、殷门、阳关、伏兔、风市、阿

是穴。

十三、高烧：大椎、身柱、心俞、肝俞、肺俞、风门。

十四、妇科疾病：肝俞、脾俞、肾俞、大肠俞、关元、中极、八髎、阿是穴。

十五、五官科疾病：风门、肺俞、肝俞、脾俞、心俞、肾俞。

十六、皮肤科疾病：风门、肺俞、肝俞、脾俞、肾俞。

第七章 临床典型病例

1、感冒

(1) 鲁某,男,22岁,工人,于1995年5月11日就诊。在两天前晚上,自觉受凉后翌日头痛,鼻塞流涕,全身不适,发烧口干咽痛,伴有微咳无痰,服药后汗出症减,但今晨又加重,故来就诊。查体:面赤,舌淡,苔薄白,咽赤,心肺未见著变,肝脾不肿大,体温摄氏38度,脉象浮数。取穴:大椎、风门、肺俞。经梅花针叩刺后,用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟。治疗两次即告治愈。

(2) 患者王某,男,农民,40岁,1985年9月10日来诊,自诉感冒十余日,初为发热,周身不适,微有恶寒,经服西药后,感觉日渐寒热往来,口苦喜呕,胸胁闷满无食欲。查体:面红润,舌苔黄脉弦数,体温 37.8°C ,检验白细胞 $7200/\text{mm}^3$,中性70%,淋巴30%,尿常规(一)肝功(一),无咽肿痛及黄疸症状,腹软未触及肝脾,取大椎穴、陶道穴,按上述方法刺络拔罐。一次后症状明显好转,又治两次后恢复健康一切如常。

2、慢性支气管炎

李某,男,47岁,咳嗽,咯痰,气短三年。每至寒冷季节发病,早晚咳嗽频繁,咯血色沫痰,有时胸背痛。查体:神感清楚,舌淡苔白腻,脉滑,体质较弱,心音纯整,心率稍快,104次/分,全肺野有干性罗音,于1996年7月采用本书处方,用可调式磁疗拔罐进行拔罐治疗,两个疗程即告治愈。

3、支气管哮喘

(1) 周某,女,21岁,学生,患过敏性支气管哮喘一年有余。曾在某医院做过敏原检查,对尘螨、花粉过敏,采用脱敏疗法和其它中西药治疗,效果不佳,常因劳累、受凉而反复发作,以晨起时发作较甚,感冒时哮喘加重,甚至持续状态,严重影响学业。检查:患者神情疲惫体瘦,腰酸乏力,舌淡苔薄白,脉弦细,取肺俞、定喘、膻中,刺络出血,再用可调式磁疗拔罐治疗,留罐15—20分钟,每周3次,3个疗程后,哮喘未发作,随访半年未复发。

(2) 陈某,男,14岁,发作性哮喘三年,每冬季必发作,逐年加重,这次发病已三周。检查:神清,面色淡白,舌淡苔白腻,脉滑,心音纯整稍快,肺部布满哮鸣音。1996年10月,采用本书处方,用可调式磁疗拔罐进行拔罐,配合拔罐油走罐治疗一个疗程后即治愈。随访一年未复发。

4、急性胃炎

赵某,男31岁,上腹部疼痛一天,并伴有恶心,呕吐,食欲不佳,服药后仍未好转,而来就诊。检查:神感清楚,舌红,苔黄腻,心肺未见著变,肝脾未触及,胃区有明显压痛,脉沉数。取大椎穴、脾俞、胃俞经梅花针叩刺后,取内关、足三里,再用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟,两次即治愈。

5、慢性萎缩性胃炎

杨某,女,24岁,于1996年10月初诊,患者于五月前无明显诱因渐出现胃脘部胀痛不适,痛引两肋,嗝气,泛酸,纳差,且身困乏力,大便时干时稀,每遇劳累则痛重。生气时甚,得热则痛。曾经多方医治未效。检查:浅表萎缩性胃炎,采用本书处方,用可调式磁疗拔罐,配合拔罐油背部两侧足太阳膀胱经走罐治疗五次后,患者胃脘痛基本消失。但仍有泛酸嗝气,后又经两个疗程本法医治,临床诸症均消失,随访半年,未复发。

6、急性肠胃炎

周某,男,34岁。左上腹部疼痛,反复发作已一年余,伴有嗝气嘈杂全身无力。查体:较消瘦,神志清楚,舌淡苔腻,心肺无著变,肝脾未触及,胃区有轻压痛,脉缓。X光钡餐透视可见胃粘膜粗大。诊断为肥厚性慢性胃炎。采用本书处方,经梅花针叩刺后,加用可调式磁疗拔罐疗法留拔5—10分钟,治疗两次即告痊愈。

7、消化不良

余某,女,24岁。全无食欲,消瘦一年有余。无任何诱因于一年前开始不思饮食,每顿只吃一小碗,但不觉饿,体重骤减,其他无不适。查体:体质消瘦,舌淡苔薄,心肺无著变,腹部凹陷,肝脾未触及,脉弱。肝功能检查正常。采用本书处方,经梅花针叩刺后,加用可调式磁疗拔罐治疗,留罐15—20分钟,治疗两个疗程即告治愈。

8、顽固性呃逆

唐某,男性,74岁,离休干部,反复呃逆六年,加重一周,1997年8月,采用针罐结合治疗。取胃痛穴(此穴位于足三里下1寸)定位取穴,男左女右,强刺激不留针,取神阙穴,用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐5分钟,每日一次,10次为一个疗程,连续治疗三次后,呃逆状缓解,为了巩固效,继续治疗一个程,随访一年未复发。

9、偏头痛

王某,女,37岁,工人。左侧头痛一周,呈发作性,跳动性,剧烈疼痛,伴有左上肢麻木感,影响睡眠。查体:疼痛病容,舌淡苔白腻,颅神经未见异常,心肺无著变,腹部无所见,生理反射存在,病理反射未引出,血压120/80毫米汞,脉象滑。取大椎、风门、肝俞,配合神肺俞、脾俞,用梅花针刺后,再用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟,配合拔罐油背部走罐。三次治愈,随访半年未复发。

10、脑血栓形成

李某,男,59岁。左侧上、下瘫痪一个月,于一个月前晨起发现手麻木,到中午时则左侧上、下肢运动都不灵活而来就诊。查体:神志清楚,言语正常,舌淡苔白腻,心肺无著变,腹平软,左侧上下肢肌力四级,左侧上下肢病理反阳性,脉弦缓。取大椎、心俞、肝俞,配合神道、风门、膈俞,用梅花针叩刺后,再用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟,配合拔罐油背部走罐。一个疗程后治愈。随访半年未复发。

11、脑供血不足

宋某,男,67岁。右半身不遂一天。于两年月前右上肢有麻木感,今天晨起发现右侧上、下肢运动障碍,不能起床,无其他不适。查体:神志清楚,颅神经正常,舌淡苔白腻,心肺未见著变,肝脾未触及,左侧嗜下肢运动障碍,感觉存在,肌力左上肢二级左下肢一级,生理反射存在,病理反射未引出,脉弦缓。取大椎、风门、肝俞,配合身检、心俞、脾俞,治疗四次即告治愈。

12、面瘫

张某,男,49岁,干部。1995年2月晨起突感右侧面部麻木,继发现右眼闭合不利,口角歪向左侧,并伴有耳后疼痛,右眼流泪等症状。经某

医院改诊为“周围性面神经麻痹”，经中、西医治疗七个月余，症状无明显改变，检查：心肺（-），血压 19/11Kpa，舌质暗，舌体胖，舌苔白，中稍厚，微黄。证属风邪入络，气血瘀阻。1995 年 10 月采用刺络拔罐治疗。取穴：太阳、阳白、牵正、颊车、地仓。用常规消毒，每次取穴 2—3 穴位，用消毒后三棱针点刺所选穴位 2—3 下，深约 2—3 毫米。在用小号可调式磁疗拔罐进行拔罐，留罐 5—15 分钟，治疗 12 次，症状明显好转。治疗 18 次后，即收痊愈之效。三个月后随访，未见复发。

13、神经衰弱

杨某，男，32 岁。失眠半年余，由于工作关系以致长期睡眠不足，逐渐引起入睡、健忘、易疲劳、易出汗，有时遗精。查体：神志清楚，舌淡苔白薄，双眼睑震颤，颅神经未见异常，心肺无著变，肝脾未触及，四肢运动正常，生理反射存在，病理反射未引出，脉滑。取大椎、神道、心俞、肝俞、配合身检、灵台、脾俞、肾俞、中脘、关元。用梅花针叩刺后，再用可调式磁疗拔罐进行拔罐，留罐 15—20 分钟，也可配合拔罐油背部走罐。治疗一个疗程后，睡眠好转，自觉症状消失。

14、失眠

(1) 王某，女，49 岁。患者于 1996 年 10 月患顽固性神经衰弱失眠症，每晚只能睡 1—2 小时，十分痛苦，食欲不佳，全身无力，头晕，头痛，面容枯黄，腰膝酸软，甚至不能操持家务劳动，经医院药物治疗无效，于 1997 年 8 月采用可调式磁疗拔罐治疗 2 个疗程后，患者可以平稳入睡 6—8 小时，头痛、头晕、全身无力等症明显减退，现患者体重增加，面色红润光泽，饮食量增，未服药，随访半年未见复发。

(2) 何某，女，65 岁。反复失眠已 5 年，多梦易醒，醒后即难以入睡。失眠时仅能睡 2—3 小时，经常服用“安定”，“芬娜露”，仍不见效。常头痛，头晕，恶心，食欲不佳，于 1996 年 10 月用可调式磁疗拔罐，采用本书处方治疗 3 个疗程后，症状已基本好转，半年后，随访未见复发。

15、糖尿病

李某，男，62 岁。糖尿病（非胰岛素依赖性）患者在 1989 年体检时，发现空腹血糖偏高，尿糖呈强阳性，其他症状不明显，当时作观察治疗，以后反复检查，血糖始终徘徊在 6.5—12 之间，尿糖示在（++++）至

(十十)间,经服中西降糖药物,仍时高时低,但血糖最低仍在6.5以上。1996年10月因患轻症脑血管意外,后遗右半身不遂,经用可调式磁疗拔罐,在背部的腧、脾俞、肾俞穴拔罐,经40天治疗后,近两次复查血糖空腹为6,尿糖(+),患者说这是近两年来没有过的化验结果。

16、高血压

(1) 张某,男,68岁。患原发性高血压已有10余年,常年头晕,失眠,手指麻木,长期服用降药物,血压仍居高不下,在180/110mmHg,此次,用可调式磁疗拔罐治疗3个疗程,患者自觉头痛、头晕、失眠、乏力等症状消失,血压降至160/85mmHg,由于患者坚持用拔罐拔足三里穴,使其胆固醇由治疗前的8.4mmol/L降至5.5mmol/L,甘油三脂由治疗前的3.04mmol/L降到1.7mmol/L,患者疗效显著。至今,该患者仍在家里巩固治疗。

(2) 杨某,女,63岁。因患冠心病及继发性高血压10余年,常年头痛,头晕,胸闷,心悸,半侧肢体麻木,靠吃药维持,血压182/108mmHg,居高不下。用可调式拔罐采用本书处方治疗3个疗程,血压降至150/90mmHg,头晕、心悸等不适症状消失,停药2个月未复发。

17、冠心病

刘某,男,72岁,干部。两周来,胸前膈区发作性闷痛,有时伴有心悸,全身无力,气短。检查:神志清楚,舌红少苔;心尖区第一音减弱,主动脉第二音亢进,心率每分钟60次;肺部呼吸音正常,肝脾未触及,血压120/70毫米汞柱,脉沉缓。心电图ST段下降。采用本书处方,经梅花针叩刺后,再用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟,一个疗程治疗后,自觉症状消失,心率每分钟75次,心电图ST段恢复正常。

18、阵发性心动过速

朱某,女,30岁。心跳头晕无力已两个月余,反复发作,经药物治疗仍未愈,故来就诊。查体:神志清楚,舌淡苔白薄,心界不大,心音纯,心率快144次/分,肺呼吸正常,腹部平软,脉沉数。心电图为窦性心动过速。取神道、心俞、厥阴俞、灵台。用梅花针叩刺后,运用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟。一个疗程治愈。

19、落枕

颜某,男,52岁。右颈部疼痛,活动障碍两天。于两天前因睡眠当风,晨起发现右颈部不适,渐至疼痛,转头困难,牵引背部及后头疼痛。查体:强迫体位,头部右斜,舌淡苔白薄,心肺无著变,腹无所见,脉弦。取大椎、风门,配合身柱、肩中俞、大杼,用梅花针叩刺后,再用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟,也可配合拔罐油走罐。三次即可治愈。

20、颈椎病

刘某,女,43岁。患颈椎病半有余,患者颈部疼痛,肩背部沉重疼痛,伴有右手麻木,近两周加剧,曾服中药及针灸治疗疗效不显,故前来就诊。患者颈疼痛不能仰俯、转侧,右手麻木牵拉痛,夜不能睡,疼痛异常,舌淡胖,苔薄白,脉紧,查颈5、6、7两旁压痛,X光示颈5、6、7骨质增生,诊为颈椎病。大椎穴配合刺血拔罐。然后按摩当天即疼痛大减,当晚睡眠尚可,坚持治疗一周,诸症消失,临床病症痊愈。

21、肩周炎

(1) 郭某,男,55岁,1996年9月就诊。左肩疼痛1年,无明显外伤史。左肩及上臂明显压痛,三角肌、冈下肌略有萎缩,功能活动受限。检查:上举90度,外展60度,后伸20度。诊断:左肩关节周围炎。用梅花针叩刺肩三针、曲池、外关、阿是穴,配合足三里、血海交替使用。用可调式磁疗拔罐进行拔罐,配合拔罐油走罐。活动患肢关节,按摩、牵拉、旋转、举伸、屈、收等活动。早晚自作功能锻炼。第一疗程后,患者左肩疼痛明显减轻,肩关节活动增大。第二疗程后,基本痊愈。随访五年,身体健康,未见复发。

(2) 徐某,男,45岁。右肩关节活动受限,疼痛1月。无外伤史。右臂上举,外旋、外展、后伸活动受限,肱二头肌短头起始端明显压痛,肌腱粗硬。诊断:右肩关节周围炎。用可调式磁疗拔罐进行拔罐,配合走罐活动患肢关节,按摩肩部,牵拉、抖动,作顺、反时针慢旋转动作,并作展、收、屈、伸等肢体活动,早、晚自作功能锻炼及摸高。拔罐6次后,上臂恢复正常,疼痛消失而愈。随访两年,身体健康,未见复发。

22、肌纤维织炎

张某,女,36岁,会计。自觉右肩背沉重隐痛半年余,活动受限。检查见右侧颈肩部肌肉紧张,有条索状物,压痛明显,头后仰时痛甚。舌质暗紫有瘀点,脉弦,诊断为右肩肌纤维组织炎。取阿是穴、肩中俞、肩髃、委中穴。常规消毒后,用梅花针叩刺出血,取阿是穴重叩,然后在叩刺部位拔罐,并留罐10分钟。隔日一次,经10次治疗病愈。

23、急性腰扭伤

刘某,男,42岁。腰部扭伤后当天,不能直腰,行走与咳嗽疼痛加重,故来就诊。查体:局部未见红肿,脊柱未见畸形,腰部活动受限,第2—4腰椎两旁有明显压痛。取穴:肾俞、命门、腰阳关、阿是穴,经刺络拔罐治疗,配合背部走罐,一次治愈。

24、腰椎间盘突出

王某,男,30岁,工人,初诊日期:1996年3月20日。主诉:8天前因抬重物不慎扭伤腰部,腰部疼痛并向左侧臀部及左下肢放射,行走困难。经服芬必得,外敷膏药,无效。于第三天作CT检查,诊断为L4—L5、L5—S1椎间盘突出(左突),查:脊椎明显侧弯,腰椎屈伸严重受限,L4、L5、S1棘突左侧压痛(+),左下肢直腿抬高试验(+),左伸拇肌肌力减弱。临床诊断同CT诊断。采用本书处方,用可调式磁疗拔罐进行拔罐,配合拔罐油走罐,症状即减轻80%以上,经2个疗程治疗,诸症状均消失,又经1疗程巩固治疗,告愈。于1996年4月22日做CT复查,病理改变恢复正常。同时,嘱患者治疗后2个月,腰部加小枕平卧硬板床,白天佩带腰围,坚持5个月,随访2年未复发。

25、坐骨神经痛

周某,男,57岁,工人。左腰骶部及左下肢疼痛四天,疼痛从腰开始,沿大腿串到足根部,为灼痛阵发性加剧,无外伤史。查体:神志清楚,舌淡苔薄白,心肺无著变,腹部未见异常,双下肢未见肌肉萎缩,感觉运动均正常,左侧直腿试验阳性,左侧第4、5腰椎棘旁有压痛,脉象缓。采用本书处方,用梅花针叩刺后,再用可调式磁疗拔罐进行拔罐,留罐15—20分钟,也可配合拔罐油走罐,三个疗程即告治愈,一年随访未复发。

26、膝关节积液症

张某,男,58岁,工人。因左膝关节肿痛、活动受限一年来诊。述病初感膝关节沉重、酸痛,一年前出现左膝髌骨内下缘隆起,未引起重视,近来肿痛加剧,不能负重久行,尤上下楼及站起时困难。查:左膝关节明显肿胀,不红,不热,髌骨上缘周径42cm,右膝40cm,浮髌试验左(+),右(-),左膝关节屈伸受限于90—130度,左膝正侧位片示:髌韧带生理曲度消失,向外呈弧形膨隆,关节周围密度稍增高,关节骨质增生。诊断:左膝关节积液证。经内外膝眼、阴陵泉、阳陵泉、阿是穴刺络拔罐,2个疗程即治愈,门诊随访半年未复发。

27、痛经

李某,女,18岁,学生。月经期腰腹剧痛,伴有恶心,头昏一天。于15岁月经初潮,每月行经期均有酸腹痛,但经期尚准,血量不多,色红,口不干,二便正常,查体:体质较瘦,神志清楚,舌淡苔白,心肺正常,肝脾未触及,腹平软,无明显压痛,脉紧。取穴:大椎、气海俞、脾俞、关元、中极、天枢、经刺络拔罐疗法治疗一疗程治愈。随访半年未复发。

28、更年期综合症

陈某,女,52岁。失眠多梦,精神不振已三年,近半年来胃里不适。查体:神志清楚,舌淡苔白薄,颅神经正常,心肺无著变,肝脾未触及,生理反射正常,病理反射未引出,脉弦。取大椎、身柱、心俞、肝俞、脾俞、肾俞、气海俞,经三棱针刺络拔罐法治疗两个疗程治愈,随访一年未复发。

29、急性乳腺炎

周某,女,24岁,1997年1月11日产后2周,右侧乳房红肿热痛来外科就诊,外科诊断为急性感染性化脓性乳腺炎,转入理疗科治疗。查体右侧乳房红肿发热,按之痛甚无应指感,排乳不畅,属肝气郁结型,伴见胸闷胁痛,呕逆纳呆,苔薄脉弦数。取大椎及患侧乳房肿部位的背部用三棱针点刺放血,然后分别用大号可调式拔罐疗法拔罐于点刺部位,拔罐使其拔出瘀血3—5毫米,一般留置10—15分钟。拔罐第一次后,患者即觉肿痛缓解,热退身轻,经治疗4次痊愈。

30、酒渣鼻

张某,男,39岁,鼻端红肿三个月,既往有慢性鼻炎,慢性支气管炎史,现在仍咳嗽,咯痰、多涕。查体:神志清楚,舌淡苔白薄,鼻端红晕表

面光亮,心肺无著变,肝脾未触及,脉弦。取穴:大椎、身柱、肺俞、肝俞、脾俞、胃俞、膈俞,经三棱针刺络拔罐法治疗一个疗程治愈。

31、皮肤瘙痒症

冯某,男,56岁。于半年前开始全身性瘙痒,夜间加重,越搔越痒,影响睡眠,食欲欠佳,服药后只暂时缓解,而且渐渐几乎失效,故来就诊。查体:神志清楚,舌红暗,苔白少,心肺未见著变,肝脾未触及,脉弦,全身有散在的抓痕。取穴:大椎、身柱、冈门、肺俞、心俞、肝俞、脾俞,经针刺络拔罐法治疗一疗程明显减轻,两疗程治愈。

32、银屑病

孙某,男,34岁,工人。于三个月前无任何诱因开始头部发疹,后延及背及四肢,发痒,曾用药,效果不明显,而来就诊。查体:神志清楚,舌红苔少,头及背四肢伸侧有散在与融合性突出于表皮之圆形皮癣,表面覆有白屑,心肺无著变,脾未触及,脉滑。取穴:大椎、身柱、冈门、肺俞、脾俞、肝俞,经三棱针刺络拔罐三个疗程治愈。

33、荨麻疹

孙某,男,50岁,工人。1995年8月来就诊,患者周身出现条索状扁平丘疹,反复发作二年,瘙痒剧烈,严重时周身浮肿,不能工作,难以入睡。每次发病持续五至二十五天,舌质红,苔薄白,脉沉缓无力,用多种西药,皮下注射,中药二剂均无效。医院检查过敏原,诊断为“灰尘过敏”。取穴:大椎、膈俞,常规消毒,用三棱针点刺出血,然后用可调式拔罐进行拔罐,大约十分钟起罐,治疗五次痊愈。

34、湿疹

马某,男,56岁,干部。于1996年1月初就诊,患者自诉一年前右前臂屈侧皮肤出现丘疹,剧痒难忍,搔破后出血,当时诊为急性湿疹。虽经多种治疗,但反复发作,最后结痂。来我处就诊时,患者自诉瘙痒难忍,以夜间为甚,前臂挠侧肘弯处有面积 $3.3 \times 3.1 \text{cm}^2$ 大小的皮损处,久治不愈。检查:患处皮肤干燥,肥厚粗糙,呈苔藓样变。皮肤发暗,表面附有糠皮状鳞屑,伴抓痕,舌质淡,苔薄白,脉细弦。诊断为湿疹(血虚风燥型)。用梅花针在皮疹局部叩刺,以微渗血为好,然后用可调式磁疗拔罐配合拔罐油在叩刺部位行走罐数次,隔日治疗1次。治疗1次后,

皮肤瘙痒感明显减轻,治疗 3 次后,瘙痒消失,皮损部粗糙症状减轻,变平,治疗 5 次后,除上述症状改善外,皮肤黯褐色也消失、皮色基本正常。巩固治疗 2 次,患外痊愈。随访半年未见复发。